Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO - COLECISTITE E COLANGITE AGUDA

CURSO EXTENSIVO 2024



INTRODUÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

Mais um tema dentro de abdome agudo inflamatório que cai muito em prova. Eu, particularmente, acho correta essa cobrança, porque é muito frequente atendermos pacientes com colecistite aguda nos serviços de urgência. É preciso saber diferenciar uma "simples" cólica biliar de uma colecistite aguda, que geralmente necessita de tratamento cirúrgico de urgência. Colecistite aguda não se resume à "paciente feminina, acima do peso, com dor em hipocôndrio direito, febre, vômitos, leucocitose e Murphy positivo". E nem sempre é isso que é cobrado em prova! Mas, fique tranquilo que vou ensinar a você tudo de relevante sobre o tema e, principalmente, o que é mais cobrado em prova, para garantir sua aprovação.

Estratégia MED

@prof.renathapaiva

@estrategiamed

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

/estrategiamed

Estratégia MED

SUMÁRIO

1.0 COLECISTITE AGUDA 5

1.1 INTRODUÇÃO 5

1.2 EPIDEMIOLOGIA 5

1.3 FISIOPATOLOGIA 6

1.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO 7

1.5 EXAMES COMPLEMENTARES 10

1.5.1 LABORATÓRIO 10

1.5.2 EXAMES DE IMAGEM 10

1.6 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 16

1.7 COMPLICAÇÕES 19

1.7.1 COLECISTITE GANGRENOSA 19

1.7.2 PERFURAÇÃO 19

1.7.3 ABSCESSO HEPÁTICO 19

1.7.4 COLECISTITE ENFISEMATOSA 20

1.7.5 EMPIEMA DE VESÍCULA BILIAR 21

1.7.6 FÍSTULA COLECISTOENTÉRICA 21

1.7.7 ÍLEO BILIAR 21

1.7.8 SÍNDROME DE MIRIZZI 24

1.8 DIRETRIZES DE TOKYO 28

1.9 TRATAMENTO 31

1.9.1 TRATAMENTO CIRÚRGICO – QUANDO INDICAR? 32

1.9.2 TRATAMENTO TOKYO 37

1.10 COLECISTITE AGUDA ALITIÁSICA 43

1.10.1 INTRODUÇÃO 43

1.10.2 FISIOPATOLOGIA 43

1.10.3 EPIDEMIOLOGIA 44

1.10.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO 44
1.10.5 EXAMES COMPLEMENTARES 45
1.10.6 DIAGNÓSTICO 45
1.10.7 COMPLICAÇÕES 45
1.10.8 TRATAMENTO 45
1.11 COLECISTITE AGUDA NA GESTANTE 48
2.0 COLANGITE AGUDA 53
2.1 INTRODUÇÃO 53
2.2 EPIDEMIOLOGIA 53
2.3 FISIOPATOLOGIA 53
2.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO 54
2.5 EXAMES COMPLEMENTARES 59
2.5.1 EXAMES LABORATORIAIS 59
2.5.2 EXAMES DE IMAGEM 59
2.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 64
2.7 DIRETRIZES DE TOKYO 64
2.7.1 GRAVIDADE 65
2.8 TRATAMENTO 66
2.8.1 MEDIDAS DE SUPORTE 66
2.8.2 ANTIBIOTICOTERAPIA 67
2.8.3 DRENAGEM BILIAR 67
2.9 COLANGITE PIOGÊNICA RECORRENTE 77
2.9.1 FISIOPATOLOGIA 77
2.9.2 EPIDEMIOLOGIA 77
2.9.3 MANIFESTAÇÃO CLÍNICA E DIAGNÓSTICO 77
2.9.4 TRATAMENTO 78
3.0 MAPAS MENTAIS 79
4.0 LISTA DE QUESTÕES 81
5.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 82
6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 82

CAPÍTULO

1.0 COLECISTITE AGUDA

1.1 INTRODUÇÃO

Antes de começarmos, precisamos definir o que são uma colecistite aguda e uma colecistite crônica:

Colecistite crônica: termo usado para descrever a infiltração celular inflamatória crônica da vesícula biliar observada na histopatologia. Desenvolve-se após repetidos episódios de cólica biliar, que causam inflamação e estenose no colo vesical e no ducto cístico, levando a uma fibrose e espessamento da vesícula biliar. A apresentação clínica é de cólica biliar, dor em epigástrio ou hipocôndrio direito que pode irradiar para a escápula, causada pela obstrução temporária do ducto cístico e que tende a ocorrer após as refeições, principalmente as ricas em lipídios, em que há aumento da colecistoquinina (CCK) e contração da vesícula biliar. Toda colelitíase sintomática tem indicação cirúrgica, já que, após o primeiro episódio, há o risco de evolução para complicações, como a colecistite aguda. A colecistite crônica será abordada no livro de "Vesícula e Vias Biliares"

Colecistite aguda: refere-se a uma síndrome de dor no quadrante superior direito, febre e leucocitose associada à inflamação da vesícula biliar. Na maioria dos pacientes (90%), a colecistite aguda desenvolve-se em pacientes com histórico de cálculos biliares sintomáticos, enquanto a colecistite acalculosa é responsável por cerca de 5% a 10% dos casos.

Meu querido aluno, guarde isto: a diferenciação entre cólica biliar e colecistite aguda é o bloqueio não resolvido do ducto cístico. Na cólica biliar, a obstrução é temporária, e na colecistite, é constante, gerando o processo inflamatório.

1.2 EPIDEMIOLOGIA

A colecistite aguda é a complicação mais comum da colelitíase e geralmente desenvolve-se após crises recorrentes de cólica biliar. Aproximadamente 6% a 11% dos pacientes com cálculos biliares sintomáticos evoluem para colecistite aguda. As mulheres são as mais acometidas, com relação de 3:1, mas essa diferença diminui a partir dos 50 anos.

Como a forma mais comum da colecistite é a litiásica, vamos relembrar os principais fatores de risco para a colelitíase:

FATORES DE RISCO PARA A COLELITÍASE

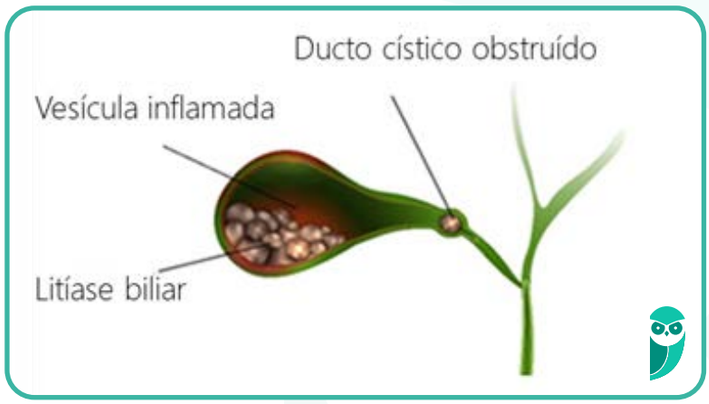
- ✓ **Sexo feminino**
- ✓ **Idade**
- ✓ **Obesidade/dislipidemia**
- ✓ **Gravidez/multiparidade**
- ✓ Genética
- ✓ Diabetes mellitus
- ✓ Nutrição parenteral total/vagotomia
- ✓ Rápida perda ponderal/gastroplastia
- ✓ Medicamentos: fibrato, análogos da somatostatina, reposição com estrogênio
- ✓ Doença de Crohn/ressecção ileal/hemólise/cirrose hepática = cálculos pretos



Já a colecistite aguda alitiásica é mais frequente em homens.

A colecistite aguda é a segunda causa mais frequente de abdome agudo, não obstétrico, na gravidez (apenas recordando, a primeira causa é a apendicite aguda). E, nos idosos, é indicação de cirurgia de urgência mais frequente.

1.3 FISIOPATOLOGIA



Dois fatores são importantes na patogênese da colecistite aguda. O primeiro é a obstrução do ducto cístico, geralmente por cálculo impactado no infundíbulo, e o segundo seria a ação irritante da lisolecitina, que é produzida a partir da ação da enzima fosfolipase A2, presente na mucosa da vesícula biliar, sobre a lecitina, um constituinte normal da bile.

Com a obstrução do ducto cístico, ocorre aumento da pressão intraluminal e consequente obstrução venosa e linfática, edema da parede vesicular, que pode evoluir para isquemia, necrose e até perfuração (mais comum no fundo da vesícula, por ser menos irrigada). A infecção da bile "estagnada" é considerada um fenômeno secundário (e nem sempre ocorre), e o mecanismo fisiopatológico primário é a obstrução não resolvida do ducto cístico. Por isso, no início do quadro, a inflamação da colecistite é dita "estéril". As principais bactérias isoladas foram *Escherichia coli* (mais frequente), *Enterococcus* (Gram-positivo), *Klebsiella* e outros bacilos Gram-negativos e anaeróbios (ex.: *Bacterioides fragilis*). Uma colecistite aguda gangrenosa pode infectar-se por bactérias produtoras de gás, presentes na parede da vesícula, e dar origem à chamada "colecistite enfisematosa".





Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

A infestação pelo *Ascaris lumbricoides* usualmente instala-se na luz intestinal, porém, em alguns casos, os vermes podem migrar para outros locais, como ductos pancreáticos, ductos biliares, vesícula biliar e apêndice cecal, podendo complicar com colangite, colecistite, abscesso hepático, pancreatite, apendicite. A ascaridíase das vias biliares, embora rara, constitui- se na mais frequente ascaridíase ectópica, sendo mais raramente encontrada na vesícula biliar.

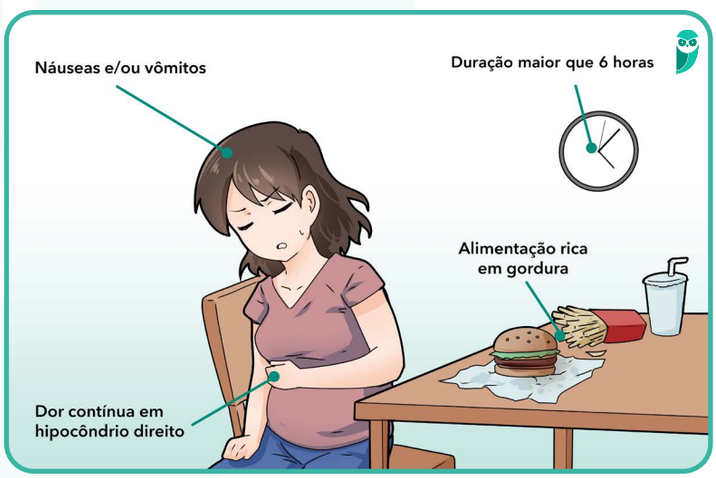
A ultrassonografia é o exame de escolha para o diagnóstico de ascaridíase biliar, particularmente da vesícula biliar. A CPRE (colangiopancretografia retrógrada endoscópica) fica reservada para os casos em que a US não foi conclusiva, tendo então sua indicação propedêutica e terapêutica.

O tratamento preconizado para ascaridíase das vias biliares consiste na administração de drogas anti-helmínticas e na remoção do verme por via endoscópica ou cirúrgica. No caso da colecistite por *Ascaris*, o tratamento de eleição é a colecistectomia, convencional ou laparoscópica. A abordagem laparoscópica é melhor que a convencional, por diminuir o período de hospitalização e a morbidade pós-operatória. A terapia com drogas antihelmínticas pode ser feita antes ou depois da cirurgia.

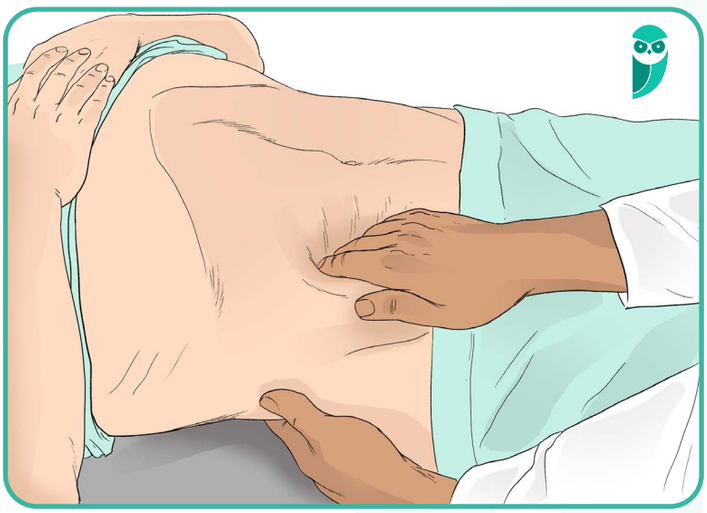
1.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

Sempre devemos procurar no histórico do paciente se já havia o diagnóstico prévio de colelitíase ou se ele apresentava cólicas biliares após a ingesta alimentar gordurosa.

A dor da colecistite aguda é constante, intensa e geralmente prolongada, superior a 4 a 6 horas. Pode irradiar-se para o ombro direito (sinal de Kehr) ou para a escápula direita. Geralmente, vem associada à febre, náuseas, vômitos e anorexia. Aproximadamente 10% dos pacientes apresentam icterícia leve por edema do colédoco adjacente, coledocolitíase associada ou pela síndrome de Mirizzi.



Ao exame físico pode haver febre, taquicardia, hipersensibilidade à palpação e defesa no quadrante superior direito. O sinal mais importante no exame físico, e que SEMPRE CAI EM PROVA, é o **"SINAL DE MURPHY"**, que consiste na interrupção abrupta da inspiração durante a palpação profunda do rebordo costal direito, ou ponto cístico. Esse sinal tem alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de colecistite aguda.



Sinal de Murphy.

COLECISTITE AGUDA

Sinal de Murphy: interrupção abrupta da inspiração profunda por dor à palpação do hipocôndrio direito.

A vesícula distendida e palpável pode estar presente em cerca de 15% a 20% dos casos de colecistite aguda.

Em casos mais avançados, como na necrose e perfuração da vesícula, os pacientes podem apresentar sinais de sepse, peritonite generalizada, crepitação da parede abdominal (colecistite enfisematosa) e até uma obstrução intestinal (íleo biliar).

CAI NA PROVA

(HASP 2019) Em relação á epidemiologia da Colecistite aguda, assinale: (V – para verdadeiro ou F – para falso);

( ) A colecistite aguda, é mais freqüente no sexo feminino.

( ) A colecistite aguda é a segunda causa mais freqüente de abdômen agudo na gravidez.

( ) A forma alitiásica é mais freqüente no sexo feminino.

( ) Na colecistite alitiásica, a necrose da parede vesicular ocorre em cerca de 90% dos casos.

A) V,V,F,V.

B) V,V,F,F.

C) V,F,F,V.

D) F,V,F,V.

COMENTÁRIOS

Vamos às afirmações:

1) A colecistite aguda é mais frequente no sexo feminino: **CORRETA**.

2) A colecistite aguda é a segunda causa mais frequente de abdome agudo na gravidez: **CORRETA**. A primeira é a apendicite.

3) A forma alitiásica é mais frequente no sexo feminino: **INCORRETA**. A colecistite alitiásica é mais comum em homens, acomete principalmente pacientes gravemente enfermos internados em unidade de terapia intensiva.

4) Na colecistite alitiásica, a necrose da parede vesicular ocorre em cerca de 90% dos casos: **INCORRETA**. A necrose e perfuração ocorrem em cerca de 50% e 10 % dos casos, respectivamente.

Correta a alternativa B, porque esta é a correlação correta: V, V, F, F.

(SCMBH 2016) Sobre a colecistite aguda litiásica, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A identificação de bactérias na bile constitui papel principal na gênese da colecistite aguda.
B) As discordâncias entre os diagnósticos clínicos, cirúrgicos e anatomopatológicos podem chegar até 20%.
C) O sinal de Murphy consiste na interrupção da inspiração profunda por dor à palpação do hipocôndrio direito.
D) A cintilografia é o exame de maior acurácia na colecistite aguda quando comparado ao ultrassom.

COMENTÁRIOS

Coloquei essa questão aqui por ser abrangente sobre o tema "colecistite aguda", já que fala de fisiopatologia, manifestação clínica e sobre exames diagnósticos, mas também para mostrar a você que muitas vezes a resposta vem por exclusão!!!

Incorreta a alternativa A: porque a colecistite calculosa aguda é causada por uma estase biliar obstrutiva, o que favorece a concentração da bile e a consequente liberação da fosfolipase A pela mucosa da vesícula. A fosfolipase promove a transformação da lecitina (um fosfolipídio presente na constituição normal da bile) em lisolecitina, que é tóxica para o epitélio, resultando em irritação química e inflamação da vesícula biliar obstruída. Pelo aumento da pressão no interior da vesícula, pode haver uma isquemia da sua parede que pode evoluir para perfuração dela. Logo, a infecção bacteriana é secundária à obstrução biliar na fisiopatologia da colecistite aguda.

Correta a alternativa B: porque realmente ocorrem discordâncias entre o diagnóstico clinico, cirúrgico e anatomopatológico. Não é tão incomum o paciente apresentar uma clínica pouco exuberante, sem febre e/ou leucocitose, principalmente em pacientes idosos e imunodeprimidos e, durante a cirurgia, ser observada uma colecistite já com necrose de parede.

Correta a alternativa C: porque essa é a descrição do sinal de Murphy, presente nas colecistites agudas.

Correta a alternativa D: porque a cintilografia é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de colecistite aguda. Não é amplamente utilizada devido ao alto custo e por não estar disponível na maioria dos serviços. O ultrassom também apresenta excelente acurácia no diagnóstico da colecistite (85% de sensibilidade e 95% de especificidade). Devido a sua baixa invasividade, ampla disponibilidade, facilidade de uso e relação custo-benefício, a ultrassonografia é recomendada como o método de imagem de primeira escolha para o diagnóstico morfológico de colecistite aguda.

(UFCG 2014) Sobre a colecistite aguda, afirma-se: I– Nos casos de colecistite aguda litiásica, a inflamação é resultado da obstrução do ducto cístico por cálculos, que, na presença de secreção mucosa continuada, leva à distensão da vesícula biliar e eventual isquemia. II– A colecistite não tratada pode evoluir para perfuração com peritonite ou abscesso intra-abdominal. III– A inflamação na colecistite aguda é tipicamente estéril, embora possa ocorrer infecção bacteriana. Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):

A) Apenas I.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.
E) I, II e III.

COMENTÁRIOS

Vamos analisar as afirmações:

I– Nos casos de colecistite aguda litiásica, a inflamação é resultado da obstrução do ducto cístico por cálculos, que, na presença de secreção mucosa continuada, levam à distensão da vesícula biliar e eventual isquemia: **CORRETA.**

Esse é o primeiro passo para instalar-se a colecistite. Outro fator que contribui no processo inflamatório da vesícula é a ação irritante da lisolecitina, que é produzida a partir da ação da enzima fosfolipase A, presente na mucosa da vesícula, sobre a lecitina, um constituinte normal da bile.

II– A colecistite não tratada pode evoluir para perfuração com peritonite ou abscesso intra-abdominal: **CORRETA**.

A propagação do processo inflamatório pode evoluir para isquemia e necrose da parede da vesícula biliar, com consequente perfuração, abscesso e peritonite. A necrose da parede vesicular é a complicação mais frequente na colecistite aguda.

III– A inflamação na colecistite aguda é tipicamente estéril, embora possa ocorrer infecção bacteriana: **CORRETA**.

A infecção da bile tem papel secundário na patogênese da colecistite.

Correta a alternativa E.

1.5 EXAMES COMPLEMENTARES

1.5.1 LABORATÓRIO

As principais alterações laboratoriais são:

- ✓ Leucocitose com desvio à esquerda;
- ✓ Aumento da proteína C reativa (PCR); e
- ✓ Elevações leves a moderadas da fosfatase alcalina, amilase sérica, bilirrubinas e transaminases.

1.5.2 EXAMES DE IMAGEM

A história, o exame físico e os resultados dos exames laboratoriais não são suficientes para estabelecer o diagnóstico. SEMPRE é necessário exame de imagem para confirmação diagnóstica por meio de sinais radiológicos típicos da colecistite aguda, como o espessamento ou edema da parede da vesícula biliar.

ULTRASSONOGRAFIA

Na maioria dos casos, o diagnóstico pode ser estabelecido com uma ultrassonografia abdominal. Tem sensibilidade de 85% e especificidade de 95%, respectivamente. Devido a sua baixa invasividade, ampla disponibilidade, facilidade de uso e relação custo-benefício, a ultrassonografia é recomendada como o **método de imagem de primeira escolha para o diagnóstico de colecistite aguda**. Além de detectar a presença de cálculos biliares, pode apresentar os seguintes sinais:

ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS QUE PODEM SER ENCONTRADOS NOS QUADROS DE COLECISTITE AGUDA

TOME NOTA!

- ✓ Espessamento da parede vesicular (≥ 4 mm) ou edema (sinal da dupla parede);
- ✓ Cálculo impactado e imóvel no infundíbulo;
- ✓ Aumento da vesícula biliar – hidropsia (eixo longo ≥8 cm, eixo curto ≥4 cm);
- ✓ Líquido perivesicular (halo hipoecoico);
- ✓ Sinal de Murphy ultrassonográfico: hipersensibilidade na topografia da vesícula notada durante a palpação com o transdutor do ultrassom;
- ✓ Presença de gás no fundo da vesícula (sinal do Champagne), indicativa de colecistite enfisematosa; e
- ✓ Líquido livre na cavidade (perfuração de vesícula com coleperitônio).



Espessamento da parede vesicular

Fonte: prova de acesso direto SUPREMA-MG, 2020.



Cálculo impactado no infundíbulo

Fonte: prova de acesso direto HCG, 2018.

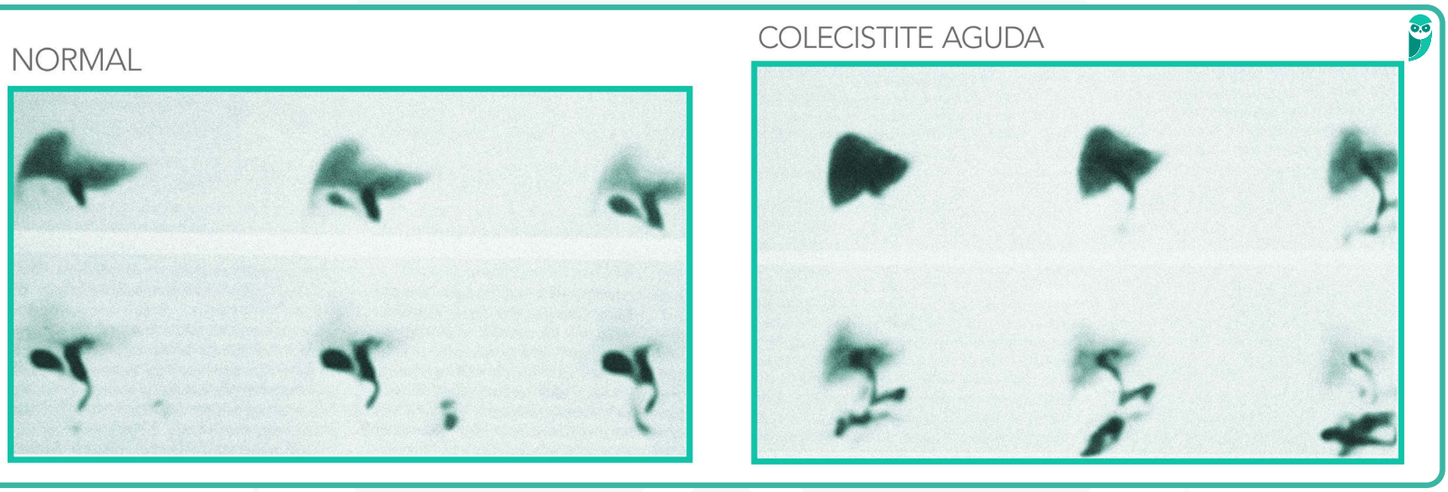
ULTRASSONOGRAFIA = PRIMEIRO EXAME SOLICITADO NA SUSPEITA DE COLECISTITE AGUDA.

CINTILOGRAFIA

A cintilografia é considerada o exame de imagem **PADRÃO-OURO** na investigação quando a ultrassonografia é duvidosa. Tem sensibilidade e especificidade para colecistite aguda de aproximadamente 90% a 97% e 71% a 90 %, respectivamente. É realizada com a injeção intravenosa do ácido iminodiacético (HIDA), ou seu análogo ácido di-isopropil iminodiacético (DISIDA) marcado com tecnécio 99m, que é absorvido seletivamente pelos hepatócitos e excretado na bile. Geralmente, a visualização do contraste no ducto biliar comum, na vesícula e no duodeno ocorre dentro de 30 a 60 minutos. Se a vesícula não for visualizada, pode-se obter imagens tardias, após 3 a 4 horas, ou aplicar morfina, que determina a contração do esfíncter de Oddi com consequente refluxo da bile por meio do colédoco. Se a vesícula biliar for preenchida após 30 minutos da aplicação da morfina, afasta o diagnóstico de colecistite aguda.

CINTILOGRAFIA = PADRÃO OURO-PARA O DIAGNÓSTICO DE COLECISTITE AGUDA.
COLECISTITE AGUDA = VESÍCULA NÃO VISÍVEL.

Apesar da melhor acurácia em relação ao ultrassom, a cintilografia tem como desvantagens o alto custo, ser um exame demorado e não estar disponível na maioria das instituições.



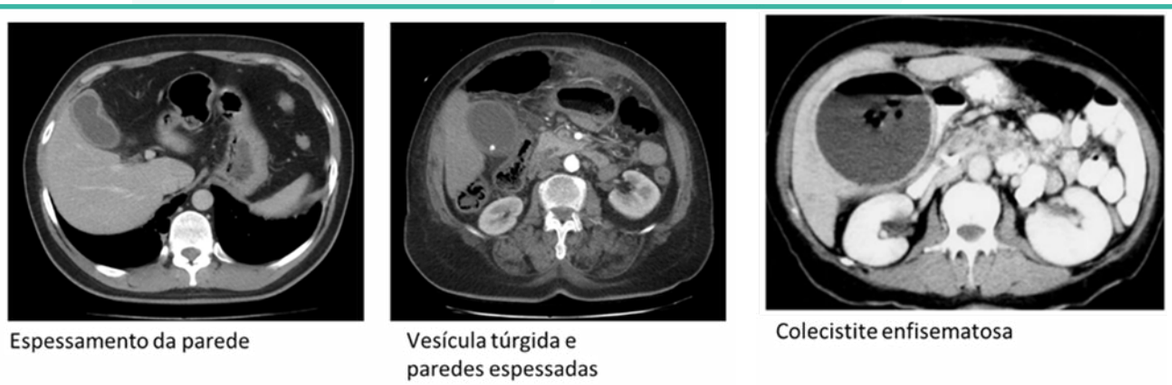
TOMOGRAFIA

A tomografia computadorizada abdominal não é rotineiramente necessária para diagnosticar colecistite aguda. Geralmente, é solicitada para descartar complicações de colecistite aguda em pacientes com sepse, ou seja, necrose ou gangrena da parede vesicular (mais comum), abscesso perivesicular (perfuração bloqueada), peritonite generalizada com coleperitônio (perfuração), empiema de vesícula, abscesso hepático, colecistite enfisematosa ou obstrução intestinal (íleo biliar). Mas, lembre-se de que a **tomografia é menos sensível que a ultrassonografia** para o diagnóstico de colecistite aguda. Tem a vantagem de descartar outras patologias, mas pode falhar na detecção de cálculos biliares, pois muitas pedras são isodensas com a bile (cálculos de colesterol).

ACHADOS TOMOGRÁFICOS QUE PODEM SER ENCONTRADOS NOS QUADROS DE COLECISTITE AGUDA

TOME NOTA!

- ✓ Edema e espessamento de parede vesicular e realce da parede da vesícula;
- ✓ Vesícula biliar túrgida, distendida;
- ✓ Cálculo impactado no infundíbulo;
- ✓ Líquido perivesicular ou livre na cavidade (coleperitônio);
- ✓ Bile de alta atenuação;
- ✓ A presença de interface gás-bile, ou presença de ar em parede vesicular, sugerindo que a bactéria relacionada seja do gênero *Clostridium*, indicativa de colecistite enfisematosa; e
- ✓ Perdas de contornos da vesícula biliar e realce heterogêneo do parênquima hepático.



Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

TOMOGRAFIA = AVALIAÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DA COLECISTITE AGUDA.

RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (RNM)

Assim como a tomografia, a ressonância nuclear magnética (RNM) estaria indicada quando o diagnóstico definitivo não é dado pela ultrassonografia e na suspeita de complicações. Como desvantagem, apresenta o alto custo e disponibilidade limitada na maioria dos serviços.



RNM: Colecistite aguda (cálculo impactado no infundíbulo). Fonte: Shutterstock.

CAI NA PROVA

(PSU MG – 2019) Mulher de 47 anos, costureira, refere dor abdominal em região subcostal direita de início há 48 horas, acompanhada de febre e vômitos (dois episódios). Piora rápida nas últimas 20 horas. Paciente não apresenta comorbidades. Ao exame, apresenta sobrepeso (IMC=27Kg/m²), corada, hidratada, febril, anictérica, taquicárdica. Abdome doloroso à palpação em rebordo costal direito com vesícula palpável, dolorosa, com defesa peritoneal localizada. A ultrassonografia mostra colecistolitíase e parede da vesícula com espessura no limite da normalidade. Ausência de líquido livre na região. Foi solicitada cintilografia. Sobre esse caso, assinale a alternativa CORRETA:

A) A infecção da bile é o fator primário determinante da evolução para colecistite aguda.
B) O preenchimento da vesícula durante a cintilografia afasta o diagnóstico de colecistite aguda.
C) O primeiro exame que deveria ter sido solicitado é a tomografia computadorizada mais sensível que a ultrassonografia para o diagnóstico.
D) O sinal de Murphy não se presta ao diagnóstico diferencial de colecistite aguda com cólica biliar.

COMENTÁRIOS

Temos uma paciente feminina, 47 anos e com sobrepeso, ou seja, com fatores de risco para desenvolver litíase vesicular.

Apresenta queixa de dor abdominal em região subcostal direita, com evolução de 48 horas, febre e vômitos. ***ANICTÉRICA*** *e taquicárdica. Dor em hipocôndrio direito e defesa peritoneal localizada indicam-nos que a paciente tem peritonite localizada. A ultrassonografia mostra litíase vesicular, porém a parede encontra-se no limite superior da normalidade e não tem líquido perivesicular.*

Todos os dados do enunciado sugerem-nos fortemente o diagnóstico de COLECISTITE AGUDA, porém a ultrassonografia não corroborou nossa hipótese. Vamos discutir as opções:

Incorreta a alternativa A: porque a colecistite calculosa aguda é causada por uma estase biliar por obstrução do ducto cístico e por ação da lisolecitina, que é tóxica para o epitélio, resultando em irritação química e inflamação da vesícula biliar obstruída. A infecção bacteriana é secundária à obstrução biliar na fisiopatologia da colecistite aguda.

Correta a alternativa B: a colecistocintilografia usando 99mTc-ácido iminodiacético hepático (HIDA) é indicada se o diagnóstico permanecer incerto após a ultrassonografia. É considerado o exame padrão-ouro para o diagnóstico da colecistite aguda pela alta acurácia (sensibilidade e especificidade de aproximadamente 90% a 97 % e 71% a 90 %, respectivamente). Se o ducto cístico estiver patente, o radiotraçador entrará na vesícula biliar, levando a sua visualização sem a necessidade de concentração, excluindo o diagnóstico de colecistite. A não visualização da vesícula biliar é diagnóstico de colecistite aguda.

Incorreta a alternativa C: porque a ultrassonografia é considerada o exame de primeira escolha para o diagnóstico de colecistite aguda, devido a sua baixa invasividade, ampla disponibilidade, facilidade de uso e relação custo-benefício. Segundo o Sabiston, 20ª edição, a tomografia computadorizada tem menor sensibilidade comparada ao ultrassom, ficando reservada para descartar complicações de colecistite aguda.

Incorreta a alternativa D: porque o sinal de Murphy positivo tem alta sensibilidade para o diagnóstico de colecistite aguda. É um sinal clínico importante na diferenciação de uma cólica biliar de uma colecistite.

(IASMPE 2019) Na avaliação de dor abdominal aguda e intensa referida e localizada em hipocôndrio direito, assinale a alternativa correta.

A) A história clinica bem realizada e o exame de raio X abdominal em 2 posições são suficientes para diagnóstico e conduta na maior parte desses casos.

B) O exame físico demonstrando sinal de irritação peritoneal nesse ponto indica a necessidade de uma tomografia abdominal.

C) A dosagem de amilase elevada exclui a necessidade de ultrassonografia abdominal.

D) A presença de leucocitose e elevação de bilirrubinas indicam a necessidade de realização de tomografia abdominal imediata.

E) A partir da suspeita diagnóstica, nesses casos, a ultrassonografia é o exame de eleição.

COMENTÁRIOS

Bom, quando uma paciente vem com queixa de dor em hipocôndrio direito (HCD), a primeira hipótese que deve vir em mente é uma colelitíase, que pode ou não estar complicada com uma colecistite aguda. E, para o diagnóstico, além da clínica apresentada com dor constante em HCD (> 4 a 6 horas), náuseas, vômitos, febre e presença do Sinal de Murphy no exame físico, precisamos lançar mão de exames de imagem para confirmar esse diagnóstico.

Vamos analisar cada alternativa:

Incorreta a alternativa A: porque a radiografia não tem relevância no diagnóstico da colecistite aguda. Apenas 10% dos cálculos biliares são radiopacos, o que também não nos dá o diagnóstico de uma colecistite!

Incorreta a alternativa B: porque o sinal de irritação peritoneal no hipocôndrio direito deve suscitar a hipótese de colecistite e, nesse caso, o exame de imagem indicado é a ultrassonografia abdominal, e não a tomografia.

Incorreta a alternativa C: porque a elevação da amilase está presente em uma série de patologias. Quando essa elevação é três vezes o limite superior da normalidade, devemos pensar no diagnóstico de uma pancreatite aguda, cuja principal causa é biliar. Mas, pode também estar elevada na colecistite aguda, no abdome agudo perfurativo, na isquemia mesentérica, dentre outras patologias. Por esse motivo, a ultrassonografia tem grande valor na avaliação da dor no quadrante superior direito. Visualizar os sinais ultrassonográficos típicos da colecistite aguda (espessamento de parede, aumento do diâmetro da vesícula, líquido perivesicular, sinal de Murphy ultrassonográfico positivo), com uma elevação discreta da amilase, já nos autoriza tratar a colecistite, geralmente com colecistectomia precoce.

Incorreta a alternativa D: a leucocitose e elevação das bilirrubinas podem estar associadas à colecistite (elevação discreta da bilirrubina) ou uma colangite. A tomografia tem baixa sensibilidade para identificar cálculos biliares, sendo melhor indicada para descartar complicações de colecistite aguda, como gangrena, perfuração, colecistite enfisematosa ou sinais de obstrução intestinal (íleo biliar). E, para estudar a via biliar, pensando em uma possível obstrução, o melhor exame seria a colangiorressonância.

Correta a alternativa E: a ultrassonografia abdominal é o exame de eleição para a investigação de dor em hipocôndrio direito, já que possui excelente sensibilidade e especificidade para diagnosticar colelitíase e colecistite aguda.

(UERJ 2015) Uma paciente de 34 anos dá entrada no setor de emergência queixando-se de dor em hipocôndrio e ombro direito, associada a febre baixa e vômitos. Refere início do quadro há cerca de 24 horas. Foi solicitada ultrassonografia das vias biliares, que foi sugestiva de colecistite aguda por apresentar o seguinte achado:

A) Cálculo com sombra acústica.
B) Calcificação parietal.
C) Halo hipoecoico.
D) Lama biliar.

COMENTÁRIOS

Temos um diagnóstico clínico e ultrassonográfico de colecistite aguda. Apenas relembrando, a colecistite aguda pode apresentar dor referida no ombro direito, conhecida como sinal de Kehr.

Vamos relembrar os principais sinais ultrassonográficos que podem ser encontrados na colecistite aguda:

- ✓ Espessamento da parede vesicular (≥ 4 mm) ou edema (sinal da dupla parede);
- ✓ Cálculo impactado e imóvel no infundíbulo;
- ✓ Aumento da vesícula biliar – hidropsia (eixo longo ≥8 cm, eixo curto ≥4 cm);
- ✓ Líquido perivesicular (halo hipoecoico);
- ✓ Sinal de Murphy ultrassonográfico: hipersensibilidade na topografia da vesícula notada durante a palpação com o transdutor do ultrassom;
- ✓ Presença de gás no fundo da vesícula (sinal do Champagne), indicativa de colecistite enfisematosa; e
- ✓ Líquido livre na cavidade (perfuração de vesícula com coleperitônio).

Incorreta a alternativa A: porque cálculo com sombra acústica só nos indica que há cálculo na vesícula biliar, ou seja, um diagnóstico de colelitíase, e não de colecistite aguda.

Incorreta a alternativa B: porque a calcificação parietal quer dizer uma calcificação da parede da vesícula biliar, também chamada de "vesícula em porcelana". Em 95% dos casos, encontra-se associada à colelitíase. É cinco vezes mais comum em mulheres do que em homens, mais frequente na quinta e sexta décadas da vida.

Correta a alternativa C: porque o halo hipoecoico nada mais é do que a imagem ultrassonográfica de um líquido perivesicular decorrente de um processo inflamatório. É dos sinais ultrassonográficos encontrados na colecistite aguda.

Incorreta a alternativa D: porque a lama biliar ou barro biliar surge quando a vesícula biliar não consegue esvaziar completamente a bile para o intestino. Não é um sinal ultrassonográfico de colecistite aguda.

(HOSPITAL EVANGÉLICO DE LONDRINA - HEL 2017) Quando houver suspeita de necrose, de abscesso ou de perfuração na colecistite aguda, qual é o exame de imagem indicado?

A) Ultrassonografia.
B) Cintilografia.
C) Tomografia computadorizada.
D) Ressonância nuclear magnética.
E) Raio X simples de abdome

COMENTÁRIOS

Incorreta a alternativa A: a ultrassonografia é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico da colecistite aguda não complicada.
Incorreta a alternativa B: a cintilografia com o ácido iminodiacético (HIDA) é considerada o exame padrão-ouro para o diagnóstico de colecistite aguda quando a ultrassonografia é duvidosa. É um exame de alto custo, pouco disponível e demorado e não é destinado para avaliação de complicações.

Correta a alternativa C: a tomografia computadorizada geralmente é solicitada quando a ultrassonografia é inconclusiva ou para avaliar possíveis complicações da colecistite aguda, ou seja, necrose da parede vesicular (mais comum), peritonite generalizada (perfuração), colecistite enfisematosa, formação de abscessos ou obstrução intestinal (íleo biliar).
Incorreta a alternativa D: assim como a tomografia, a ressonância nuclear magnética estaria indicada quando o diagnóstico definitivo de colecistite aguda não é dado pela ultrassonografia e na suspeita de complicações. Como desvantagem, apresenta o alto custo e disponibilidade limitada na maioria dos serviços, e por esse motivo a tomografia está melhor indicada para avaliar as complicações.
Incorreta a alternativa E: aproximadamente 10% dos cálculos biliares são radiopacos e visíveis na radiografia simples de abdome, o que não contribui para o diagnóstico da colecistite e de suas possíveis complicações.

1.6 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

CÓLICA BILIAR

Assim como na colecistite aguda, a dor da cólica biliar é no quadrante superior direito, mas é autolimitada, porque a obstrução do ducto cístico é transitória. Dura pelo menos 30 minutos, com pico máximo em uma hora. Se o tempo de dor ultrapassar seis horas e o paciente ainda apresentar febre e sinais peritoneais, devemos suspeitar de uma colecistite aguda. Também não há alteração laboratorial na cólica biliar.

COLANGITE AGUDA

Pacientes com colangite aguda apresentam, em comum com a colecistite, dor em quadrante superior direito, febre e leucocitose. Mas, ao contrário dessa, há obstrução da via biliar, com consequente icterícia marcante e dilatação da via biliar aos exames de imagem.

PANCREATITE AGUDA

Também tem como principal etiologia a litíase vesicular. A clínica típica da pancreatite aguda é dor epigástrica, "em faixa", com irradiação para o dorso, geralmente associada a vômitos. Não apresenta sensibilidade localizada em hipocôndrio direito ou sinal de Murphy.

SÍNDROME DE FITZ-HUGH-CURTIS

Em mulheres com doença inflamatória pélvica aguda, a peri-hepatite pode causar dor abdominal no quadrante superior direito. Acomete mulheres jovens, com vida sexual ativa, e geralmente um esfregaço genital revela a presença de gonococo.

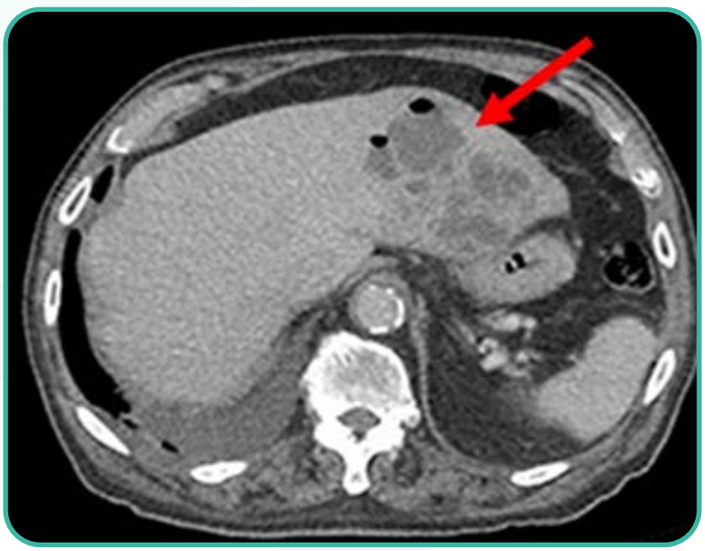
Na ultrassonografia, o líquido pericolecístico pode ser confundido com colecistite aguda, mas a cintilografia é negativa.

SÍNDROME DE BUDD-CHIARI

É definida como obstrução da via de saída venosa hepática, independentemente do nível ou mecanismo de obstrução. Pode ser primária, quando há obstrução devido a um processo predominantemente venoso (trombose ou flebite), ou secundária, quando há compressão ou invasão das veias hepáticas e/ou veia cava inferior por uma lesão que origina-se fora da veia (por exemplo, uma malignidade). É mais comum em mulheres na 3ª ou 4ª décadas de vida. Clinicamente, manifesta-se com febre, dor abdominal, ascite, edema nos membros inferiores, icterícia, sangramento gastrointestinal (por varizes ou gastropatia hipertensiva portal) e/ou encefalopatia hepática.

ABSCESSO HEPÁTICO

Os principais sintomas do abscesso hepático são febre e dor abdominal. Outros sintomas podem estar presentes, como náuseas, vômitos, anorexia e perda de peso. A febre é o sintoma mais marcante dos abscessos hepáticos e está presente em pelo menos 90% dos casos. Lembre-se de que o abscesso hepático pode ser uma complicação da colecistite e da colangite aguda.



Abscesso hepático. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

CAI NA PROVA

(UFRJ 2018) Mulher, 35 anos, com dor abdominal em hipocôndrio direito e vômitos após ingestão de alimentos gordurosos há três dias. Exame físico: normocorada, afebril, anictérica e hipohidratada +/4+. Exame do abdome: vesícula palpável. A hipótese diagnóstica mais provável é:

A) Colangite aguda.
B) Abscesso hepático.
C) Colecistite aguda.
D) Hepatite viral aguda.

COMENTÁRIOS

Aqui temos uma questão sobre diagnósticos diferenciais de dor no quadrante superior direito do abdome.

Vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A: a colangite aguda é o processo infeccioso devido à obstrução das vias biliares, tipicamente caracterizada por icterícia, febre e dor abdominal, a então chamada "tríade de Charcot" (abordaremos esse assunto no próximo capítulo). Como vimos acima, a paciente não está ictérica, o que fala contra o diagnóstico de colangite.

Incorreta a alternativa B: os principais sintomas do abscesso hepático são febre e dor abdominal. Outros sintomas podem estar presentes, como náusea, vômitos, anorexia e perda de peso. A febre é o sintoma mais marcante dos abscessos hepáticos e está presente em pelo menos 90% dos casos. A paciente está afebril!

Correta a alternativa C: a história clínica de dor em hipocôndrio direito, persistente (superior a quatro horas), associada a vômitos relacionados à ingesta de alimentos gordurosos e associada à vesícula biliar palpável é sintoma muito sugestivo de uma colecistite aguda. O próximo passo será realizar uma ultrassonografia para confirmar o diagnóstico.

Incorreta a alternativa D: as hepatites virais apresentam um espectro largo de apresentações clínicas possíveis. Podem ter desde uma apresentação assintomática, até um quadro de hepatite aguda fulminante. Os sintomas, quando presentes, incluem febre, dor abdominal, mal-estar, anorexia, icterícia, mialgia, artralgia, entre outros. Na hepatite, as provas de função hepática estão bastante alteradas, com padrão de lesão hepatocelular. Exames virológicos e sorológicos são necessários quando o diagnóstico diferencial é difícil.

(UNB 2019) Paciente do sexo feminino, de 37 anos de idade, faxineira, quatro filhos, foi atendida no pronto-socorro hospitalar com índice de massa corporal de 32 e histórico de crises dispépticas e cólicas abdominais, localizadas em epigástrico. O quadro clínico evoluiu nas últimas 8 horas com dor forte e contínua no epigástrico e hipocôndrio direito, houve remissão transitória, com o uso de analgésicos orais, e dois episódios de vômitos. No exame físico, apresentava-se ansiosa, hipocorada (+/4+), taquicárdica (90 bpm) e levemente ictérica. No que tange a esse caso clínico e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item subsecutivo. A presença do sinal clínico de Murphy no exame físico leva ao diagnóstico de síndrome de Budd-Chiari.

A) CERTO

B) ERRADO

COMENTÁRIOS

A síndrome de Budd-Chiari é um quadro raro, secundário à obstrução das veias hepáticas, podendo ser de ordem crônica ou aguda.

Nos casos da doença aguda, os achados clínicos típicos são a dor em quadrante superior direito, associada à hepatomegalia, icterícia e ascite.

Temos um quadro típico de colecistite aguda! Mulher, com sobrepeso (IMC:32), multípara, com dor forte e constante no HCD, superior a seis horas, e com sinal de Murphy positivo.

Correta a alternativa B.

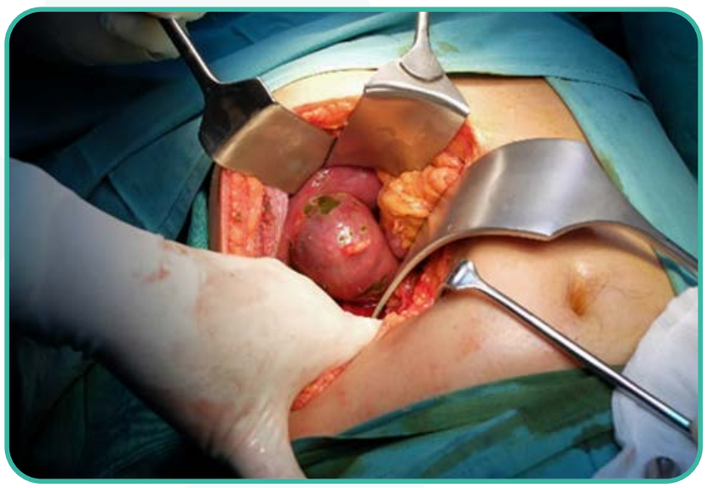
1.7 COMPLICAÇÕES

A colecistite aguda pode apresentar uma série de complicações, algumas que exigem tratamento cirúrgico de urgência, por isso é importante saber diagnosticá-las. Complicações, como gangrena de parede, perfuração e colecistite enfisematosa, são mais comuns na colecistite aguda alitiásica.

1.7.1 COLECISTITE GANGRENOSA

É a complicação mais comum da colecistite (até 20% dos casos), mais frequente na colecistite alitiásica. Acomete principalmente pacientes masculinos, idosos, diabéticos e pacientes que demoram a procurar atendimento médico. Exibe achados específicos na tomografia contrastada, por isso é considerada o melhor exame diagnóstico na suspeita de colecistite gangrenosa. A maioria dos autores considera o tratamento cirúrgico de urgência (colecistectomia).

Na tomografia, podemos encontrar espessamento irregular da parede da vesícula biliar (sinal interrompido da borda), aumento da densidade de tecido adiposo ao redor da vesícula biliar, gás no lúmen ou parede da vesícula biliar e abscesso perivesicular.



Necrose da parede vesicular. Fonte: Shutterstock.

1.7.2 PERFURAÇÃO

É uma evolução da necrose da parede e ocorre principalmente no fundo da vesícula. Pode ocorrer a formação de abscesso perivesicular ou, se a perfuração for livre para a cavidade, coleperitôneo com peritonie difusa, o que aumenta as taxas de mortalidade. A presença de coleperitônio exige tratamento cirúrgico de urgência (colecistectomia).

1.7.3 ABSCESSO HEPÁTICO

Ocorre por disseminação direta da infecção biliar (colecistite, colangite), que está presente em 40% a 60% dos casos de abscesso hepático. As manifestações clínicas típicas do abscesso hepático são febre, presente em 90% dos casos, e dor abdominal. Outros sintomas comuns incluem náuseas, vômitos, anorexia, perda de peso e mal-estar. Ultrassom e tomografia computadorizada são os exames de imagem normalmente usados para identificação de abscesso hepático. O tratamento consiste em antibioticoterapia e drenagem do abscesso hepático, cirurgicamente (aberto ou laparoscópico), por via percutânea ou via colangiopancreatografia endoscópica retrógrada.



Abscesso hepático lobo esquerdo.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



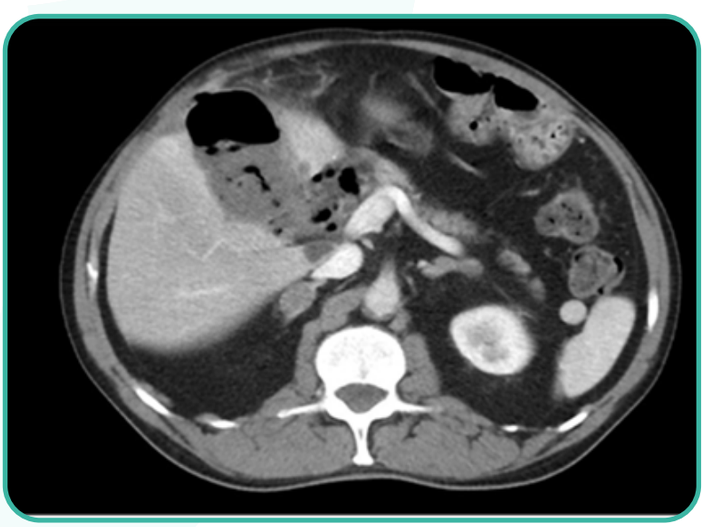
Volumoso abscesso hepático lobo direito.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

1.7.4 COLECISTITE ENFISEMATOSA

Ocorre nos casos de colecistite aguda com infecção secundária da parede da vesícula por bactérias formadoras de gás, como o ***Clostridium*** (ex.: *Clostridium perfringens, Clostridium welchii*). Outros organismos que podem ser isolados incluem *Escherichia coli (15%), Estafilococos, Estreptococos, Pseudomonas e Klebsiella.* A clínica é semelhante à da colecistite aguda, com instalação súbita e evolução rápida, e pode apresentar crepitação da parede abdominal, sendo esse um sinal bastante sugestivo. Acomete principalmente homens, com idade superior a 60 anos e diabéticos. A TC de abdome contrastada é o melhor exame para o diagnóstico de colecistite enfisematosa, que demonstra a presença de interface gás-bile, ou ar na parede vesicular. É possível a visualização de ar na topografia da vesícula biliar à radiografia simples de abdome.

A ultrassonografia pode observar erroneamente a presença de "gás intestinal sobrejacente, dificultando a visualização adequada da vesícula biliar", quando, na realidade, isso reflete o ar na parede da vesícula biliar.

Geralmente, o tratamento é cirúrgico de urgência (colecistectomia).



Colecistite enfisematosa. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

1.7.5 EMPIEMA DE VESÍCULA BILIAR

O termo “empiema” significa que o conteúdo vesicular é purulento.

1.7.6 FÍSTULA COLECISTOENTÉRICA

A fístula colecistoentérica complica 2% a 3% de todos os casos de litíase na vesícula biliar. Resulta da perfuração da vesícula biliar diretamente na luz intestinal. A maioria das fístulas são colecistoduodenais e aproximadamente 15% são colecistocolônicas (mais na flexão hepática).

1.7.7 ÍLEO BILIAR

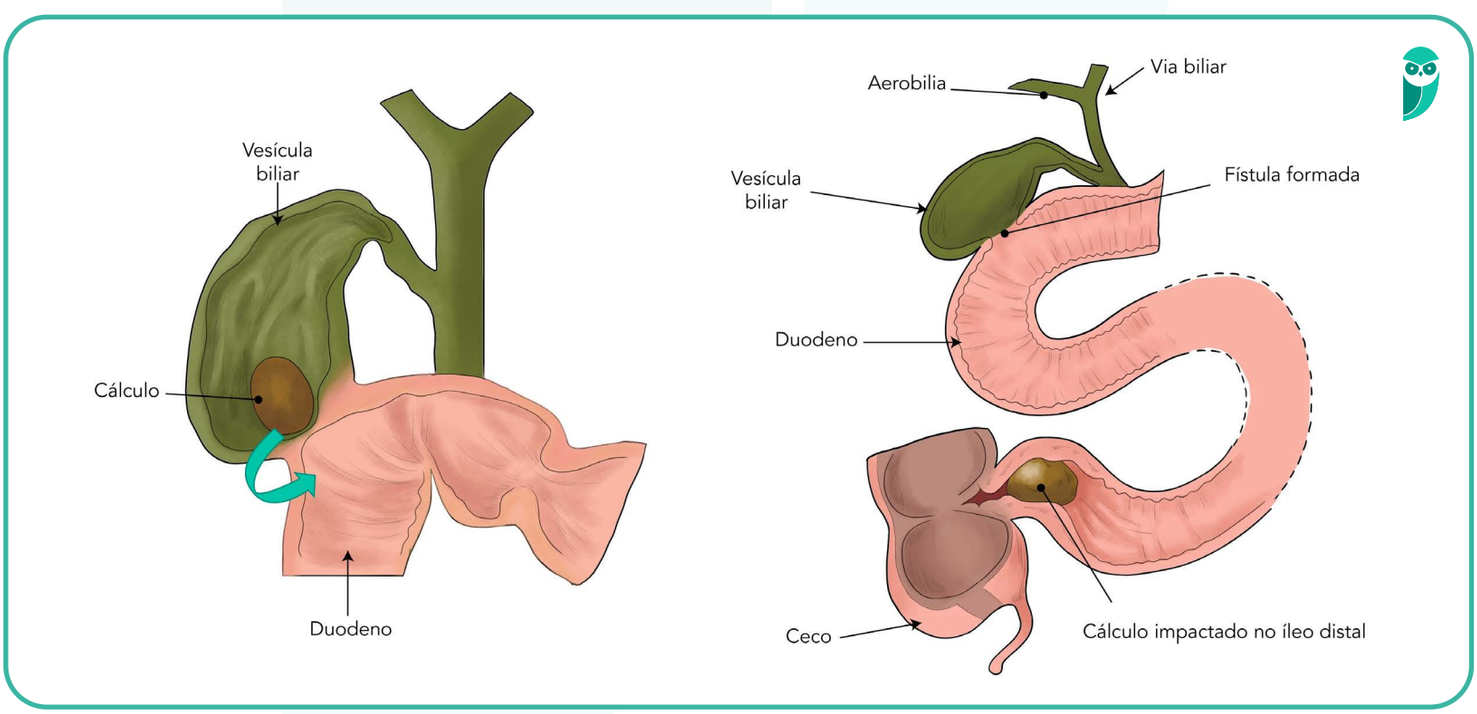
EPIDEMIOLOGIA

O íleo biliar é uma complicação rara de litíase vesicular que ocorre com uma frequência de 0,3-0,5% dos casos e 2% a 3% na presença de colecistite aguda. Acomete principalmente pacientes do sexo feminino e idosos. Pode apresentar a síndrome de Mirizzi coexistente.

Por acometer mais pacientes idosos, a taxa de mortalidade é alta, 5 a 10 vezes maior que a de outras causas de obstrução mecânica do intestino delgado.

FISIOPATOLOGIA

O íleo biliar caracteriza-se pela impactação de um ou mais cálculos no intestino. Decorre da passagem de um cálculo, geralmente maior que 2,5 cm, por meio de uma fístula colecistoduodenal, o qual geralmente impacta-se no íleo terminal, próximo à válvula ileocecal, causando um quadro de obstrução intestinal alta, com dor e distensão abdominal associada a vômitos biliosos. Apesar do termo “íleo biliar”, o bloqueio mecânico pode acometer qualquer parte do intestino, sendo o mais comum o íleo distal, uma vez que esse afunila antes de entrar no ceco.



Raramente, o cálculo biliar é impactado dentro do canal pilórico ou duodeno, causando obstrução da saída gástrica (síndrome de Bouveret). Os sintomas apresentados são início abrupto de dor epigástrica, náuseas e vômitos.

DIAGNÓSTICO

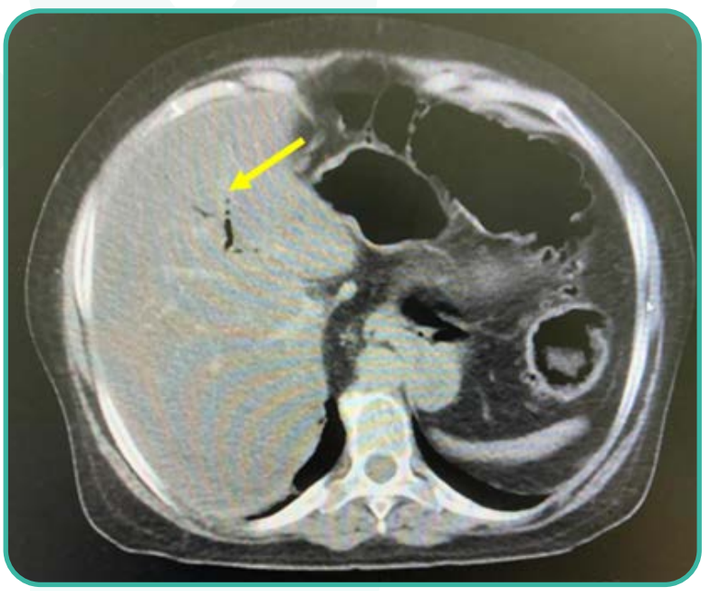
O diagnóstico é confirmado por exames de imagem, sendo a tomografia o exame de escolha. Os principais achados incluem:

ACHADOS TOMOGRÁFICOS DO ÍLEO BILIAR

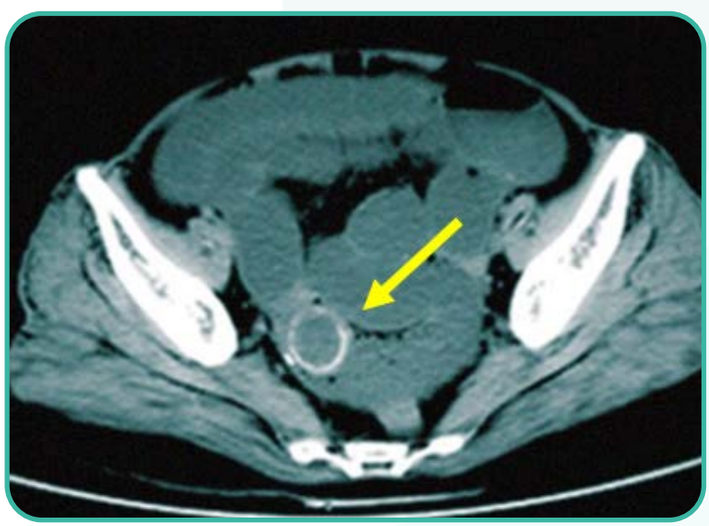
- ✓ Espessamento da parede da vesícula biliar;
- ✓ Pneumobilia (aerobilia): ar na via biliar, presente em 30% a 60% dos pacientes.
- ✓ Padrão de obstrução intestinal alta (distensão de alças, níveis hidroaéreos, empilhamento de moedas); e
- ✓ Cálculo biliar > 2,5 cm impactado no íleo terminal.



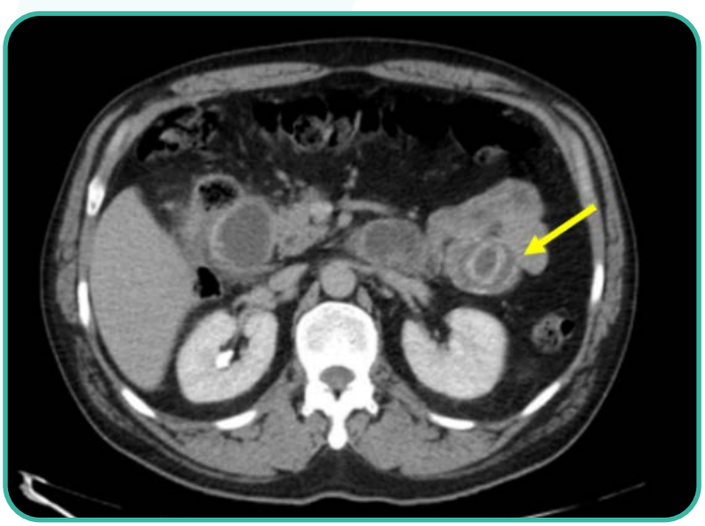
Aerobilia.



Aerobilia. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Cálculo impactado no íleo distal. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

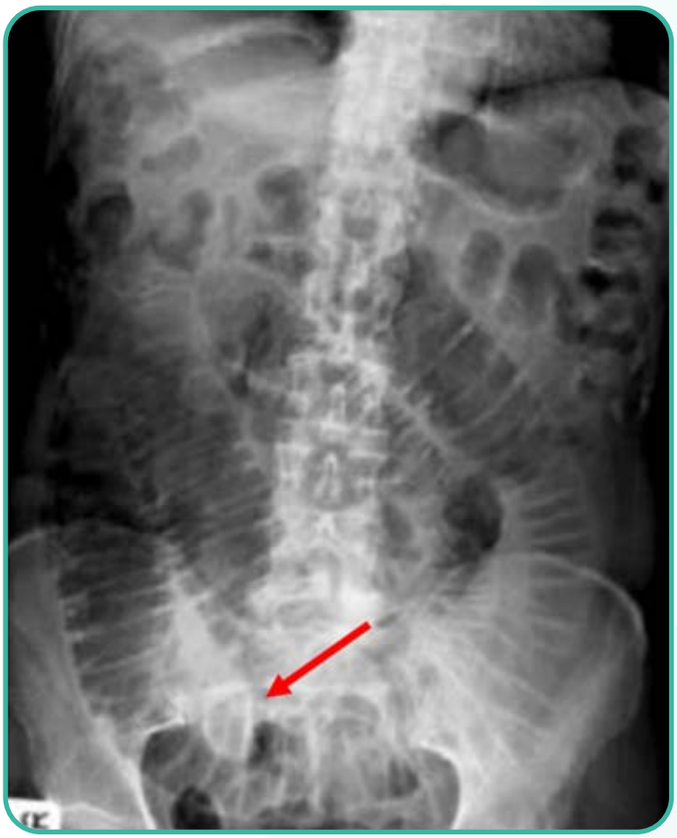


Cálculo impactado no jejuno. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

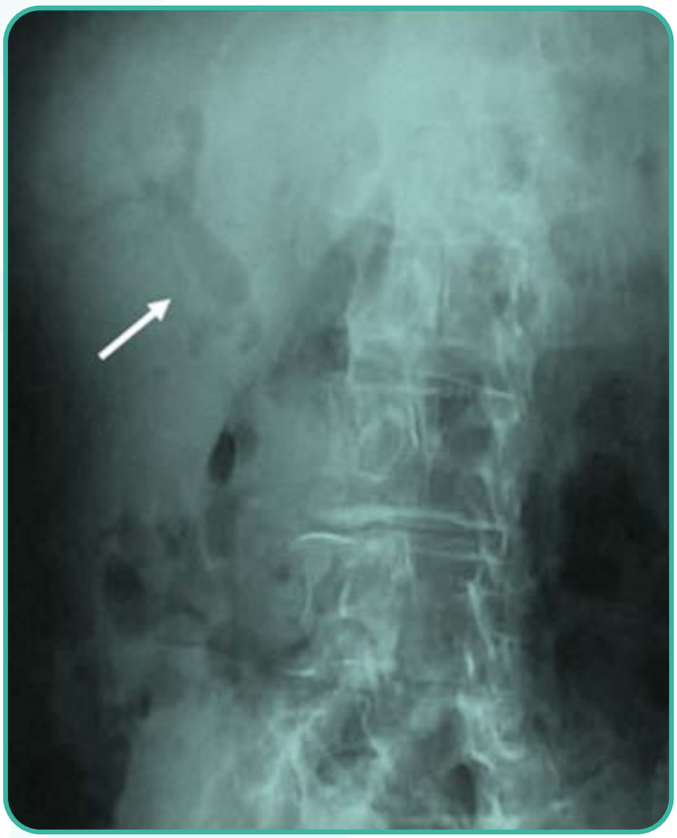
A radiografia simples de abdome também possui alguns achados típicos:

ACHADOS RADIOGRÁFICOS DO ÍLEO BILIAR – TRÍADE DE RIEGLER

- ✓ Sinais de obstrução intestinal alta (distensão de alças, níveis hidroaéreos, "empilhamento de moedas");
- ✓ Pneumobilia (aerobilia) – difícil visualização à radiografia simples;
- ✓ Cálculo biliar ectópico, geralmente observado na fossa ilíaca direita (topografia do íleo terminal)



Cálculo ectópico (íleo terminal). Fonte: prova de acesso direto FAMEMA 2020.



Aerobilia. Fonte: imagem adaptada do site geocites.ws

A ultrassonografia não é a modalidade de imagem preferida para avaliar um paciente com suspeita de obstrução intestinal, devido à distensão gasosa causada pela obstrução intestinal.

TRATAMENTO

O tratamento é cirúrgico de urgência, por meio de laparotomia, e envolve resolver a obstrução intestinal. Então, deve ser realizada uma enterotomia, retirada do cálculo e enterorrafia. Se houver isquemia ou perfuração do segmento intestinal, é necessária a ressecção dele. A laparoscopia não está contraindicada, mas certamente apresenta maior dificuldade técnica, devendo ser realizada por cirurgiões experientes.

A colecistectomia e o fechamento da fístula podem ser realizados em um único tempo cirúrgico se o paciente apresentar condições clínicas favoráveis. Pacientes de baixo risco (ASA I ou II) que estejam estáveis hemodinamicamente devem ser submetidos aos três procedimentos no mesmo tempo cirúrgico (enterotomia, colecistectomia e fechamento da fístula colecistoduodenal). Já os pacientes graves, de alto risco (ASA III, IV ou V), podem ter o procedimento biliar adiado ou mesmo não realizado, uma vez que é possível fechamento espontâneo da fístula, principalmente se o ducto cístico estiver patente, ficando reservada a colecistectomia para sintomas recorrentes.

Na presença da síndrome de Bouveret isolada, em que o cálculo está impactado no piloro ou no duodeno, o procedimento de escolha é a litotripsia endoscópica do cálculo.

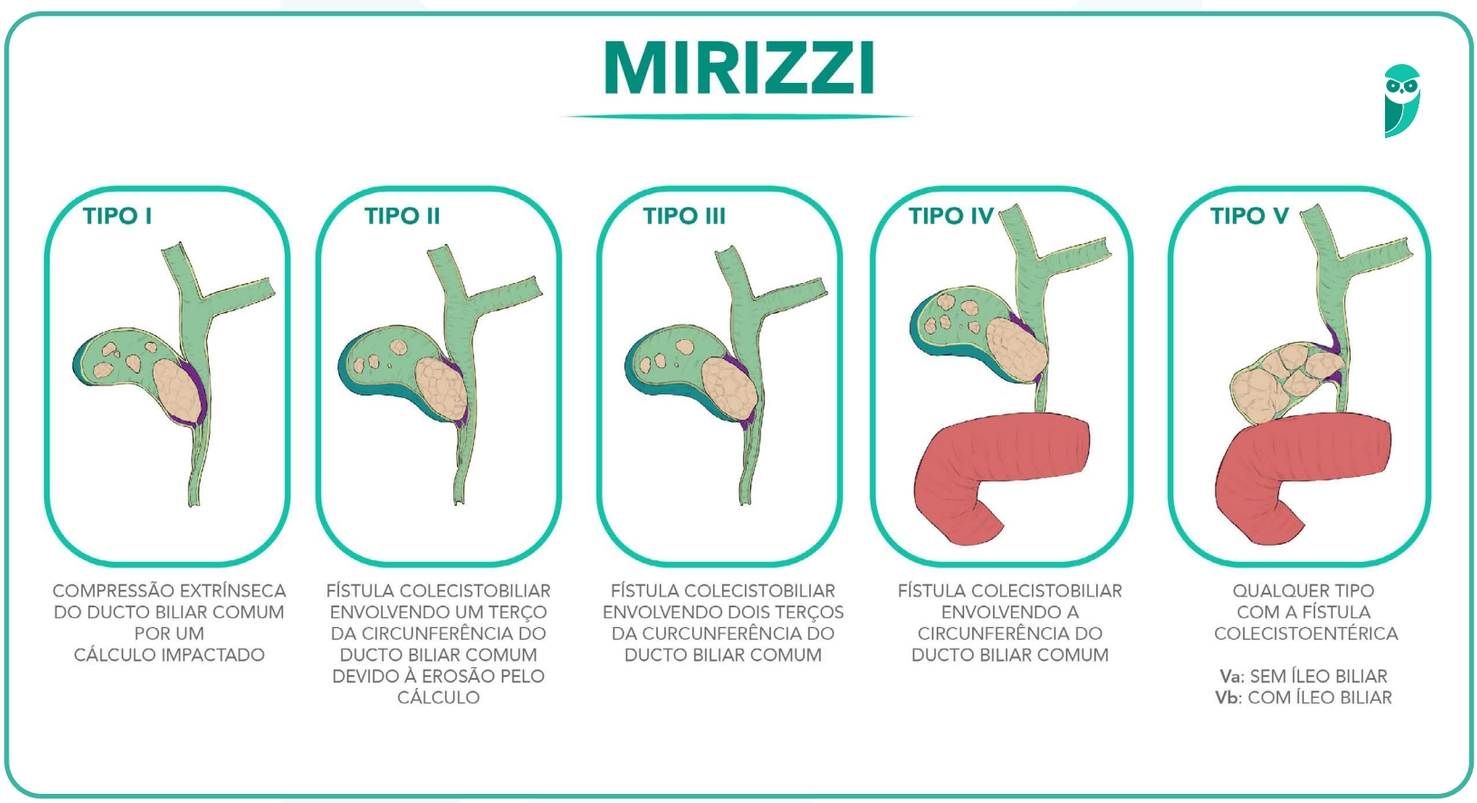


ÍLEO BILIAR

- ✓ Mulheres e idosos;
- ✓ Colelitíase, fístula bilioentérica e obstrução intestinal;
- ✓ Local mais comum da obstrução: íleo terminal;
- ✓ Tríade de Riegler (radiografia de abdome): obstrução de delgado, cálculos biliares ectópicos e pneumobilia;
- ✓ Diagnóstico: tomografia (obstrução intestinal alta, cálculo > 2,5 cm no íleo terminal, **PNEUMOBILIA**);
- ✓ Tratamento: laparotomia e enterotomia;
- ✓ Pacientes de baixo risco: acrescentar procedimento íleo-biliar (colecistectomia e fechamento da fístula).

1.7.8 SÍNDROME DE MIRIZZI

A síndrome de Mirizzi é definida como obstrução do ducto hepático comum, causada por compressão extrínseca de um cálculo impactado no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar. Pacientes com síndrome de Mirizzi podem apresentar icterícia, febre e dor no quadrante superior direito. A síndrome de Mirizzi será melhor abordada no livro de "Vesícula e Vias Biliares".



CAI NA PROVA

(HIAE 2020) Uma senhora de 75 anos, com hipertensão arterial controlada, diabetes e artrose de quadril, é levada pela filha ao pronto-socorro, com queixa de dor abdominal e vômitos há um dia. Faz uso de aspirina, 100 mg por dia. Nunca foi operada. Está em regular estado geral, normotensa, eupneica, afebril, anictérica e desidratada. Frequência cardíaca: 60 bpm. O exame clínico do tórax não revela alterações. O abdome não tem cicatrizes e é doloroso difusamente, mesmo à palpação superficial. Está tenso e tem sinais de irritação peritoneal difusa, mas mais evidente no epigástrio. O toque retal não tem alterações. A filha traz ultrassonografia de abdome, feita no dia anterior, em outro serviço, cujo laudo sugere o diagnóstico de colecistite aguda calculosa, e a radiografia simples de abdome, mostrada abaixo. Obtido acesso venoso, é iniciada hidratação e analgesia. A gasometria arterial não mostra alterações significativas. Hemograma: hemoglobina: 9,8 g/dL, leucócitos: 15.000/mm³, sem desvio à esquerda. Creatinina: 2,16 mg/dL, ureia: 90 mg/dL, potássio: 3,5 mEq/L e sódio normal. Lactato sérico: 35 mEq/L e PCR: 187 mg/L. O médico que está atendendo a paciente solicita tomografia, mas o radiologista diz que, devido à insuficiência renal, seria melhor fazer o exame sem contraste, que não acrescentaria muito para o diagnóstico. Conduta, além de iniciar o tratamento com antibiótico e a reposição volêmica



A) nova ultrassonografia.
B) tratamento percutâneo, por radiologia intervencionista.
C) intervenção cirúrgica de urgência.
D) tomografia, mesmo sem contraste.
E) hidratação vigorosa e tomografia com contraste, depois.

COMENTÁRIO

Temos uma paciente com diagnóstico de colecistite aguda calculosa, evoluindo com dor abdominal difusa, vômitos e sinais de irritação peritoneal. Nos exames laboratoriais, além de alteração da função renal, que foi impeditiva para realizar a tomografia com contaste, apresenta anemia, leucocitose e aumento da PCR. Para nossa surpresa, na radiografia, vemos uma imagem hipodensa no quadrante inferior direito, que nada mais é do que um cálculo. Esse é o chamado "íleo biliar".

Olhe como é importante a anamnese! Se você visse só a radiografia, sem saber a história clínica, a imagem poderia ser interpretada como um fecalito, presente nos casos de apendicite aguda, ou até mesmo uma ureterolitíase à direita. Mas, em uma paciente com história de dor em hipocôndrio direito e ultrassonografia comprovando o diagnóstico de colecistite aguda, evoluindo com quadro de obstrução intestinal, só nos resta pensar na hipótese de um íleo biliar!!!! Um dado importante para o diagnóstico de íleo biliar é a presença de aerobilia ou pneumobilia, ou seja, presença de ar na via biliar. É vista principalmente na tomografia computadorizada e, em alguns casos, na radiografia simples de abdome.

Vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A: porque uma nova ultrassonografia não agregará maiores informações e atrasará o tratamento definitivo. Lembre-se de que a ultrassonografia não é um bom exame frente a um quadro de obstrução intestinal, pois a distensão gasosa prejudica o exame.

Incorreta a alternativa B: a colecistostomia é uma opção nos casos de colecistite em que o paciente não apresenta condições clínicas de cirurgia (pacientes sépticos, múltiplas comorbidades). Nos casos de íleo biliar, está indicada a laparotomia de urgência para resolver principalmente a obstrução intestinal.

Correta a alternativa C: o tratamento do íleo biliar é cirúrgico de urgência e consiste em retirada do cálculo do trato digestivo, normalmente realizado por meio de uma enterotomia e posterior enterorrafia. Se a alça estiver com sinais de sofrimento, está indicada a enterectomia. Se a paciente tiver condições clínicas, no mesmo tempo cirúrgico, deve ser realizada a colecistectomia e a correção da fístula bilioentérica.

Incorreta a alternativa D: nós já temos um diagnóstico clínico e radiológico (ultrassom e radiografia) de uma colecistite aguda complicada com íleo biliar. A realização de uma tomografia, mesmo sem contraste, confirmaria a presença do cálculo no íleo terminal e mostraria-nos aerobilia. Mas, realmente, no nosso caso, só atrasaria o tratamento!

Incorreta a alternativa E: a hidratação venosa está indicada, pois a paciente tem sinais de insuficiência renal pré-renal (desidratação pelos vômitos), hipoperfusão tecidual (lactato 35) e sepse. No entanto, não está indicada a tomografia. O diagnóstico já está estabelecido e é o suficiente para indicar-se a cirurgia.

(UNAERP 2019) O íleo biliar é uma complicação rara de litíase vesicular que ocorre com uma frequência de 0,3-0.5% e se caracteriza pela impactação de um ou mais cálculos no intestino delgado. Com base nas informações, assinale a opção correta.

A) A síndrome de Bouveret é uma forma rara de íleo biliar em que a obstrução se localiza no duodeno, devido à formação de uma fístula colecistoduodenal.
B) Em 50-90% dos casos, a obstrução ocorre no jejuno proximal.
C) As fístulas bilioentéricas ocorrem em mais de 50% dos pacientes com litíase vesicular.
D) Os cálculos com maiores dimensões são menos susceptíveis a provocar obstrução.
E) O paciente normalmente apresenta exame radiológico normal.

COMENTÁRIOS

Correta a alternativa A: porque a rara síndrome de Bouveret consiste na impactação de um grande cálculo biliar dentro do piloro ou duodeno, devido à passagem do cálculo por meio de uma fístula colecistoduodenal. O tratamento é feito por via endoscópica com litotripsia do cálculo ou por laparotomia.

Incorreta a alternativa B: o local mais comum de impactação é o íleo distal, alguns centímetros proximal à válvula ileocecal, em que o calibre do íleo diminui.

Incorreta a alternativa C: porque apenas 2% a 3 % dos portadores de colelitíase desenvolvem fístula colecistoentérica.

Incorreta a alternativa D: porque os cálculos maiores são mais susceptíveis a causar íleo biliar e obstrução intestinal.

Incorreta a alternativa E: a radiografia simples de abdome demonstra sinais de obstrução intestinal alta (distensão de delgado, níveis hidroaéreos, empilhamento de moedas). Também podem ser visualizados o cálculo ectópico na topografia do íleo terminal (mas apenas 10% a 15% dos cálculos são radiopacos) e a pneumobilia (melhor visualizada na tomografia de abdome).

(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VOLTA REDONDA - SMA - VR 2018) A Colescistite Enfisematosa é uma rara condição pelo aparecimento de bolhas de gás na luz da vesícula biliar, em sua parede, no espaço pericolecístico e até em ductos biliares. Sobre Colecistite Enfisematosa é correto:

A) Acomete três vezes mais mulheres que homens.
B) O gás é produzido por infecção aeróbica
C) O RX simples de abdome pode realizar o diagnóstico
D) Tratamento cirúrgico não é necessário
E) Raramente o Clostridium está implicado em sua fisiopatologia

COMENTÁRIOS

A colecistite aguda enfisematosa ocorre nos casos de colecistite com infecção secundária da parede da vesícula por bactérias formadoras de gás, como o Clostridium (Clostridium perfringens, Clostridium welchii). A clínica é semelhante à da colecistite aguda, com instalação súbita e evolução rápida, e pode apresentar crepitação da parede abdominal, sendo esse um sinal bastante sugestivo. Acomete principalmente homens com idade superior a 60 anos e diabéticos. A TC de abdome contrastada é o melhor exame para o diagnóstico da colecistite enfisematosa. Geralmente, o tratamento é cirúrgico de urgência (colecistectomia).

Incorreta a alternativa A: a colecistite aguda enfisematosa é mais comum em homens.

Incorreta a alternativa B: o gás é produzido por infecção anaeróbica.

Correta a alternativa C: é possível a visualização de ar na topografia da vesícula biliar à radiografia de abdome. No entanto, a tomografia de abdome contrastada é o melhor exame para o diagnóstico de colecistite enfisematosa.

Incorreta a alternativa D: o tratamento da colecistite enfisematosa é a colecistectomia de emergência!

Incorreta a alternativa E: a principal bactéria relacionada à colecistite enfisematosa é o Clostridium.

(SCM SP 2019) Uma paciente de 92 anos de idade referiu dor em cólica em hipocôndrio direito persistente há sete dias, que evoluiu com febre e taquicardia. Ao exame físico, estava em regular estado geral, taquicárdica, febril, ictérica 2+/4+, com dor à palpação em hipocôndrio direito e com sinal de Murphy positivo. Realizou ultrassonografia de abdome, que mostrou espessamento da parede da vesícula biliar, múltiplos cálculos e líquido livre na cavidade abdominal. Foi realizada uma punção abdominal com retirada de líquido bilioso. Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa correta.

A) Trata-se de colecistite aguda não complicada que deverá ser tratada com antibiótico.
B) Em idosos, nenhuma colecistite aguda deverá ser operada.
C) Trata-se de colecistite aguda não complicada e o tratamento indicado é drenagem da cavidade e antibiótico.
D) Trata-se de colecistite aguda complicada, com coleperitôneo, e deverá ser realizado tratamento operatório.
E) Trata-se de colangite aguda e o tratamento clínico é o melhor para a paciente.

COMENTÁRIOS

Temos uma paciente idosa com um quadro típico de uma colecistite aguda já complicada com coleperitônio, pois a ultrassonografia visualizou líquido livre na cavidade e a punção abdominal aspirou bile. O tratamento frente a uma perfuração de vesícula biliar com coleperitônio é cirúrgico de urgência!

Incorreta a alternativa A: porque temos uma colecistite aguda complicada com perfuração da vesícula biliar e coleperitônio.

Incorreta a alternativa B: não é a idade que determina a indicação de cirurgia na colecistite aguda e, sim, as condições clínicas do paciente, risco cirúrgico e a presença de complicações. Perfuração de vesícula livre para a cavidade com coleperitônio tem indicação cirúrgica de urgência (colecistectomia).

Incorreta a alternativa C: como explicado anteriormente, a colecistite da nossa paciente é complicada e o tratamento é cirúrgico de urgência.

Correta a alternativa D: porque colecistite aguda complicada com perfuração e coleperitônio tem indicação de colecistectomia de urgência.

Incorreta a alternativa E: porque, apesar da paciente apresentar icterícia, trata-se de uma colecistite, e não de uma colangite. O ultrassom não mostrou dilatação da via biliar e nenhum fator obstrutivo no colédoco, além de apresentar líquido livre, o que fala contra uma colangite. E, se o diagnóstico fosse uma colangite, o melhor tratamento seria uma CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) para retirada de cálculos e descompressão da via biliar.

1.8 DIRETRIZES DE TOKYO

Meu querido aluno, achei importante colocar aqui as Diretrizes de Tokyo, que possuem algumas particularidades que bancas, principalmente o IASMPE e Santa Casa de São Paulo, adoram cobrar nas provas.

Foram desenvolvidos sistemas para estratificar a gravidade da colecistite e colangite aguda, e o mais utilizado atualmente está nas "Diretrizes de Tokyo", em que são estabelecidos critérios diagnósticos e de classificação da gravidade da colecistite e colangite aguda, bem como a conduta terapêutica. A primeira edição foi em 2007 (TG07), com revisão em 2013 (TG13) e, mais recentemente, em 2018 (TG18).

Os critérios de diagnóstico do TG13 (inalterados no TG18) para colecistite aguda constituem a combinação de achados clínicos, laboratoriais e de **imagem para o diagnóstico**. Repare que para o diagnóstico definitivo SEMPRE é necessário um exame de imagem.

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO TG18 / TG13 PARA COLECISTITE AGUDA

A) Sinais locais de inflamação:

1) Sinal de Murphy; e

2) Massa QSD*/ dor/sensibilidade.

*Quadrante superior direito.

B) Sinais sistêmicos de inflamação:

1) Febre;

2) PCR elevado; e

3) Contagem elevada de leucócitos.

C) Resultados da imagem:

Achados de imagem característicos da colecistite aguda.

Diagnóstico suspeito: um item em A + um item em B.

Diagnóstico definitivo: um item em A + um item em B + C.



A classificação da gravidade da colecistite aguda em grau I (leve), grau II (moderado) e grau III (grave) é considerada fator preditivo de mortalidade na admissão. Pacientes com classificação grave apresentam maior tempo de internação hospitalar, maior conversão da laparoscopia para cirurgia aberta, complicações pós-operatórias e mortalidade.

CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DO TG18 / TG13 PARA COLECISTITE AGUDA

Colecistite aguda grau III (grave): associada à disfunção de qualquer um dos seguintes órgãos/sistemas:

1) Disfunção cardiovascular: hipotensão que requer tratamento com dopamina ≥ 5 µg/kg por minuto ou qualquer dose de noradrenalina;

2) Disfunção neurológica: diminuição do nível de consciência;

3) Disfunção respiratória: relação PaO 2 / FiO 2 <300;

4) Disfunção renal: oligúria, creatinina> 2,0 mg / dl;

5) Disfunção hepática: PT - INR> 1,5; e

6) Disfunção hematológica: contagem de plaquetas <100.000 / mm^3.

Colecistite aguda grau II (moderada): associada a qualquer uma das seguintes condições:

1) Contagem elevada de leucócitos (> 18.000 / mm^3);

2) Massa macia palpável no quadrante abdominal superior direito;

3) Duração das reclamações > 72 h; e

4) Inflamação local marcada (colecistite gangrenosa, abscesso pericolecístico, abscesso hepático, peritonite biliar, colecistite enfisematosa).

Colecistite aguda grau I (leve): a colecistite aguda "grau I" não atende aos critérios de colecistite aguda "grau III" ou "grau II". Também pode ser definida como colecistite aguda em um paciente saudável, sem disfunção orgânica e alterações inflamatórias leves na vesícula biliar, tornando a colecistectomia um procedimento cirúrgico seguro e de baixo risco.

CAI NA PROVA

(ASMPE 2020) O diagnóstico da colecistite aguda de certeza segundo critérios de Tokio 18 é por:

A) Clínica, laboratorial e raio X.
B) Clínica, laboratorial e cultura.
C) Laboratorial, tomografia e cultura.
D) Clínica, laboratorial e ultrassom.
E) Clínica e ultrassom.

COMENTÁRIO

Quais são os critérios diagnósticos da colecistite aguda segundo o TG18?

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO TG18 / TG13 PARA COLECISTITE AGUDA

A) Sinais locais de inflamação:
1) Sinal de Murphy; e
2) Massa QSD*/dor/sensibilidade;
* Quadrante superior direito.

B) Sinais sistêmicos de inflamação:
1) Febre;
2) PCR elevado; e
3) Contagem elevada de leucócitos.

C) Resultados da imagem:
Achados de imagem característicos da colecistite aguda.

Diagnóstico suspeito: um item em A + um item em B.

Diagnóstico definitivo: um item em A + um item em B + C.

Logo, o diagnóstico de colecistite aguda, segundo as Diretrizes de Tokyo, é baseado em parâmetros clínicos, laboratoriais e exames de imagem, que podem ser ultrassom, tomografia, cintilografia... Resultado de cultura não entra nos critérios!

Correta a alternativa D.

(SANTA CASA 2020) Segundo o consenso de Tokyo 2018 para avaliação da gravidade da colecistite aguda, assinale a alternativa correta.

A) Os critérios utilizados dizem respeito a sinais do exame físico, aos sinais de inflamação sistêmicos e aos sinais inflamatórios nos exames de imagem.
B) Os critérios utilizados dizem respeito apenas aos achados operatórios.
C) Os critérios utilizados dizem respeito à alteração da função renal, à ultrassonografia e aos achados operatórios.
D) Os critérios utilizados dizem respeito ao grau de icterícia, à febre e aos achados operatórios.
E) Os critérios utilizados dizem respeito às alterações encontradas na colangiorressonância e durante a cirurgia.

COMENTÁRIOS

O diagnóstico de colecistite aguda, segundo as Diretrizes de Tokyo (2018), é baseado em parâmetros clínicos, laboratoriais e exames de imagem. A gravidade da colecistite, classificada em grau I (leve), II (moderada) e III (grave), também utiliza parâmetros semelhantes, ou seja, clínicos, laboratoriais e de imagem.

Correta a alternativa A: os critérios utilizados dizem respeito a sinais do exame físico (massa no quadrante superior direito, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência), aos sinais de inflamação sistêmicos (leucocitose, disfunções orgânicas) e aos sinais inflamatórios nos exames de imagem (inflamação local, como colecistite enfisematosa, abscesso hepático e coleperitônio, vistos ao exame de imagem).

Incorreta a alternativa B: porque achados intraoperatórios não são critérios para classificar a gravidade da colecistite aguda!
Incorreta a alternativa C: porque alteração da função renal (oligúria, creatinina> 2,0 mg / dl) e a ultrassonografia são critérios para classificação da gravidade da colecistite, mas achados operatórios não.
Incorreta a alternativa D: porque febre e icterícia também não entram como critérios de gravidade. A febre entra como critério diagnóstico.
Incorreta a alternativa E: porque achados intraoperatórios não são critérios para a gravidade da colecistite aguda!

1.9 TRATAMENTO

A base do tratamento da colecistite aguda é a **COLECISTECTOMIA**, além dos cuidados de suporte com jejum oral, hidratação intravenosa, correção de distúrbios eletrolíticos, analgesia e antibióticos.

CONTROLE DA DOR:

Geralmente é alcançado com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) ou opioides. Lembrar que todos os opioides podem aumentar a pressão no esfíncter de Oddi.

ANTIBIÓTICOS:

A colecistite aguda é principalmente um processo inflamatório, mas a infecção secundária da vesícula biliar pode ocorrer como resultado da obstrução do ducto cístico e da estase biliar. Antibioticoterapia empírica contra bactérias Gram-negativas, Gram-positivas e anaeróbias é realizada em todos os pacientes diagnosticados com colecistite aguda. A terapia antimicrobiana tem como objetivo principal limitar a resposta séptica sistêmica e a inflamação local, prevenir infecções do sítio cirúrgico na ferida superficial, no leito vesicular e impedir a formação de abscesso intra-hepático. A escolha do antibiótico, bem como o tempo de utilização, vai depender da gravidade da colecistite, da presença de complicações e se a infecção é comunitária ou hospitalar, podendo ser corrigida de acordo com as culturas que, por ventura, tenham sido colhidas.

Em casos precoces e não graves, a terapia antimicrobiana é, na melhor das hipóteses, profilática, impedindo a progressão para a infecção. Quando uma perfuração, colecistite enfisematosa e necrose da vesícula biliar são observadas durante a colecistectomia, recomenda-se a duração de 4-7 dias. Quando o paciente estiver tolerando a dieta via oral, deve receber antibioticoterapia via oral.



Colecistite aguda não complicada: antibioticoprofilaxia.
Colecistite aguda complicada: antibioticoterapia (4-7 dias).

As principais bactérias isoladas foram *Escherichia coli* (41%), *Enterococcus* (12%), *Klebsiella* (11%) e *Enterobacter* (9 %) e anaeróbios (ex.: *Bacterioides fragilis*).

1.9.1 TRATAMENTO CIRÚRGICO – QUANDO INDICAR?

O tratamento definitivo da colecistite aguda é por meio da **COLECISTECTOMIA**, preferencialmente por via laparoscópica, e o momento da cirurgia depende da gravidade dos sintomas e do risco cirúrgico do paciente.

Pacientes de baixo risco cirúrgico (ASA I ou II) devem ser submetidos à **COLECISTECTOMIA** precoce, ou seja, até 72 horas do início dos sintomas. A cirurgia precoce é tecnicamente "mais fácil", pois a inflamação local aumenta após 72 horas do início dos sintomas. Com a evolução da inflamação, a dissecção torna-se menos precisa, pois os tecidos ficam mais friáveis, aumentando a gravidade das complicações cirúrgicas e tornando mais provável a conversão para cirurgia aberta.

Em pacientes de alto risco (ASA III, IV ou V), que não apresentem indicação de colecistectomia de emergência, por exemplo, perfuração de vesícula com coleperitôneo, devemos evitar a colecistectomia precoce, a menos que sua doença progrida ou falhe em responder à terapia não operatória. É feita antibioticoterapia e repouso intestinal. Os objetivos principais da terapia antimicrobiana na colecistite aguda são limitar a inflamação local e a resposta séptica sistêmica e prevenir a formação de abscesso intra-hepático e pericolecístico.

Pacientes com piora clínica (febre alta, instabilidade hemodinâmica ou dor intratável), após um a três dias do uso de antibióticos, são candidatos à drenagem percutânea da vesícula biliar guiada por exame de imagem (ultrassonografia ou tomografia), sob anestesia local e sedação. E, se mesmo com a drenagem não houver melhora clínica, o próximo passo será a colecistectomia, apesar do alto risco e pior prognóstico.

Em pacientes com colecistite aguda, em franco choque séptico, instáveis, além da antibioticoterapia de largo espectro e medidas de suporte, como reposição volêmica, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e controle da dor, a conduta primordial é drenagem percutânea da vesícula biliar guiada por exame de imagem (ultrassonografia ou tomografia). Esse procedimento, conhecido como **COLECISTOSTOMIA,** pode ser feito com anestesia local, e é deixado um dreno no interior da vesícula até a resolução da colecistite aguda ou drenagem mínima (< 10 ml/24 horas).

Por curiosidade, além da via percutânea para drenagem da vesícula biliar, existem outras duas opções:

- ✓ Drenagem endoscópica transpapilar: feita por CPRE, em que um dreno é colocado na vesícula biliar por meio do ducto cístico e exteriorizada no nariz (dreno nasobiliar) ou internamente no duodeno; e
- ✓ Drenagem transmural: orientada por ultrassonografia endoscópica, colocação de *stents* metálicos autoexpansíveis, entre vesícula biliar e o estômago ou duodeno, com descompressão e remoção de cálculos). Essa última abordagem pode interferir em futuras cirurgias de colecistectomia. Tanto a drenagem percutânea quanto a drenagem transmural apresentam excelentes resultados na resolução da colecistite aguda, 96% e 100% respectivamente.



Colangiografia pelo dreno vesicular.
Fonte: Shutterstock.

Lembrando que a colecistostomia é uma ponte para o tratamento definitivo, pois a probabilidade de sintomas recorrentes é alta, 20% em um ano. Então, o risco cirúrgico deve ser reconsiderado após a resolução da colecistite aguda, e, se o paciente apresentar condições clínicas, a colecistectomia eletiva deve ser realizada, em média, após 3 a 6 meses. Normalmente, o dreno é mantido até a cirurgia, mas pode ser fechado após confirmação da perviedade do ducto cístico, feita por estudo radiológico (colangiografia por meio de injeção de contraste pelo dreno). Isso é importante para uma melhor função intestinal do paciente por preservar o pool de ácidos biliares, que pode ser esgotado devido a uma drenagem prolongada pelo tubo de colecistostomia e levar à colestase intra-hepática e a um aumento nos testes de função hepática.

Pacientes que mantêm alto risco cirúrgico podem ser observados ou podemos considerar a extração percutânea de cálculos biliares, com ou sem litotripsia mecânica por meio do dreno de colecistostomia. Deve ser realizada uma colangiografia pelo dreno antes desse procedimento, para verificar a patência do ducto cístico.

RESUMINDO

TRATAMENTO DA COLECISTITE AGUDA

1- Colecistite aguda - paciente de baixo risco (ASA I e II) = **COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA PRECOCE** (até 72 horas) e antibioticoprofilaxia.

2- Colecistite aguda - paciente de alto risco (ASA III, IV e V) = antibioticoterapia. Se houver falha no tratamento conservador = drenagem da vesícula biliar / colecistectomia.

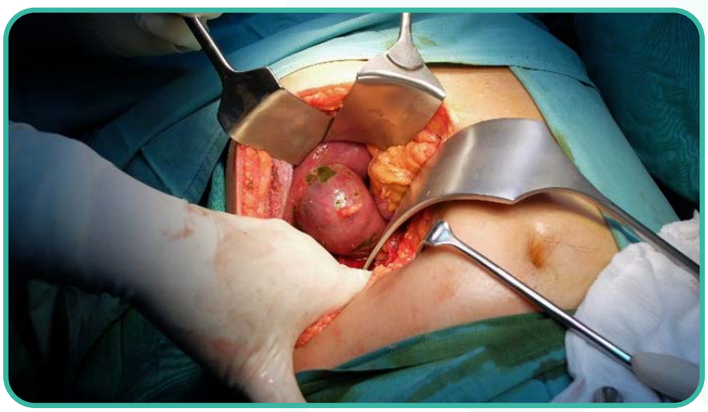
3- Colecistite aguda – paciente instável = COLECISTOSTOMIA (drenagem percutânea da vesícula biliar guiada por exame de imagem) e antibioticoterapia. Se houver falha = colecistectomia.

- Colecistectomia após 3 a 6 meses se condições clínicas favoráveis; e
- Extração percutânea/litotripsia pela colecistostomia se mantiver alto risco cirúrgico.

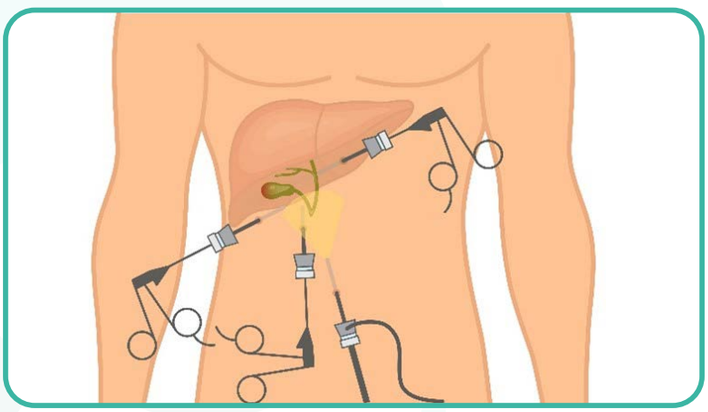
COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA X COLECISTECTOMIA ABERTA

Na colecistectomia convencional, ou seja, técnica aberta, o acesso à vesícula biliar pode ser feito por uma incisão subcostal direita (Kocher, mais utilizada), mediana, paramediana direita (2 a 5 cm da linha média, pararretal interna – Lennander) ou transversa (Sprengel).

A laparoscopia apresenta vantagens, como índices menores de: dor pós-operatória, infecção de ferida e taxas de pneumonia, tempo de internação e de recuperação.

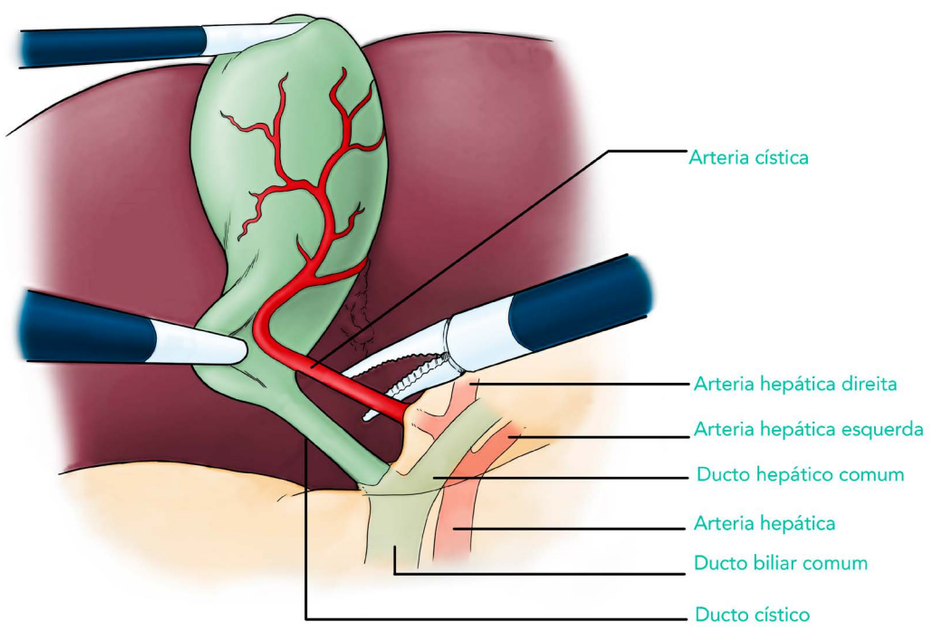


Colecistectomia aberta (incisão de Kocher) – necrose da parede vesicular. Fonte: Shutterstock.



Colecistectomia laparoscópica. Fonte: Shutterstock.

Pode ser necessária a realização de colecistectomia subtotal ou parcial, chamada de técnica de Thorek, em que a vesícula é seccionada transversalmente, a parede superior (ou posterior) da vesícula biliar fica no leito hepático e a mucosa deve ser cauterizada. Está indicada na presença de intenso processo inflamatório que dificulte a identificação segura da via biliar, pois tal manobra tem por objetivo evitar lesões iatrogênicas.



A cirurgia de colecistectomia laparoscópica, na vigência de uma colecistite aguda, requer atenção dobrada do cirurgião, pois os tecidos estão mais friáveis e com anatomia distorcida, por isso é importante a chamada "**VISÃO CRÍTICA DA SEGURANÇA**", que consiste na exposição adequada do trígono de Calot por meio da tração cranial do fundo da vesícula e ínfero-lateral direita do infundíbulo, dissecando e deixando o trígono livre de todos os tecidos, exceto o ducto cístico e a artéria, que devem ser identificados antes da secção. A dificuldade na identificação da visão crítica deve levar o cirurgião a considerar a realização de colangiografia ou a conversão da colecistectomia laparoscópica em cirurgia aberta.

Apenas relembrando os limites do trígono de Calot:

- ✓ Superior: borda hepática
- ✓ Inferior: ducto cístico
- ✓ Medial: ducto hepático comum
- ✓ Contém a artéria cística"

CAI NA PROVA

(UNB 2019) Paciente do sexo feminino, de 37 anos de idade, faxineira, quatro filhos, foi atendida no pronto-socorro hospitalar com índice de massa corporal de 32 e histórico de crises dispépticas e cólicas abdominais, localizadas em epigástrio. O quadro clínico evoluiu nas últimas 8 horas com dor forte e contínua no epigástrio e hipocôndrio direito, houve remissão transitória, com o uso de analgésicos orais, e dois episódios de vômitos. No exame físico, apresentava-se ansiosa, hipocorada (+/4+), taquicárdica (90 bm) e levemente ictérica. No que tange a esse caso clínico e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item subsecutivo. Se for constatado que essa paciente é diabética e se ela apresentar, em um exame de imagem, um halo gasoso em torno da vesícula biliar, deve-se indicar cirurgia de urgência.

A) CERTO

B) ERRADO

COMENTÁRIOS

Bom, depois de tudo que nós já estudamos, não há dúvida de que essa paciente tem um quadro de colecistite aguda. Pontos-chaves para esse diagnóstico: mulher, sobrepeso, multípara, diabética, dor forte e constante no hipocôndrio direito, superior a 4 horas, e vômitos.

Diante de um quadro de colecistite aguda, associada à presença de gás ao redor da vesícula biliar, em uma paciente diabética, devemos elencar a hipótese de colecistite enfisematosa.

É mais comum em homens acima de 60 anos e diabéticos. Trata-se de uma infecção provocada por bactérias anaeróbicas, como o Clostridium, e que frequentemente evolui para gangrena e perfuração. Um achado bastante sugestivo no exame físico é a presença de crepitação na parede abdominal.

A conduta terapêutica padrão nesses casos é a colecistectomia de urgência.

Correta a alternativa A.

(UFSC 2014) Assinale a alternativa CORRETA. Em pacientes criticamente enfermos com empiema da vesícula, a melhor opção terapêutica é:

A) tratamento clínico inicial e colecistectomia eletiva posteriormente.
B) papilotomia endoscópica.
C) coledocotomia com dreno de Kehr.
D) colecistostomia + papiloesfinteroplastia.
E) colecistostomia com tubo e colecistectomia quando melhorar.

COMENTÁRIO

O empiema da vesícula biliar nada mais é do que a presença de pus dentro da vesícula biliar. É uma das complicações da colecistite aguda. Necessita de tratamento imediato, com drenagem desse empiema, por meio de uma colecistectomia ou drenagem percutânea/endoscópica, a depender do risco cirúrgico do paciente. Vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A: porque o tratamento do empiema de vesícula deve ser imediato.

O tratamento clínico inicial e a colecistectomia eletiva são indicados nos pacientes com colecistite não complicada com alto risco cirúrgico, mas estáveis.

Incorreta a alternativa B: porque uma papilotomia endoscópica é feita para facilitar a drenagem da via biliar principal, e não da vesícula, que é a conduta no nosso paciente. Geralmente, é realizada para o tratamento da colangite aguda, com exérese de cálculos do colédoco pela CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica).

Incorreta a alternativa C: porque uma coledocotomia com colocação de dreno de Kehr não dá acesso ao empiema de vesícula, pois a origem da infecção geralmente é uma obstrução do ducto cístico por cálculo impactado no infundíbulo. Essa seria uma conduta de urgência nos casos de colangite aguda obstrutiva em pacientes graves, em que não haja disponibilidade de CPRE e se necessite que o procedimento seja breve.

Incorreta a alternativa D: porque a colecistostomia é uma conduta correta, mas a papiloesfinteroplastia não. Ela é geralmente realizada por meio da CPRE para desobstrução da via biliar por cálculos.

Correta a alternativa E: porque o tratamento do empiema de vesícula deve ser imediato. Além das medidas de suporte (jejum, hidratação, correção hidroeletrolítica, antibióticos contra Gram-negativo, positivos e anaeróbios), temos duas opções: colecistectomia precoce, se o paciente for de baixo risco, ASA I ou II, e a drenagem da vesícula biliar, feita por via percutânea guiada por exame de imagem, para pacientes instáveis. Como o autor da questão disse-nos que o paciente está "criticamente enfermo", provavelmente encontra-se séptico ou instável.

(IASMPE 2017) Mulher, 92 anos, é admitida com uma grave colecistite aguda. É submetida a colecistostomia percutânea, com pigtail, devido ao alto risco operatório e múltiplas comorbidades. Quatro semanas após o procedimento, o débito do dreno é de 200 mL/dia. Nesse caso, o próximo passo é:

A) Colecistectomia.
B) Passagem de prótese biliar por endoscopia.
C) Colangiografia retrograda endoscópica.
D) Colangiografia pelo dreno da colecistostomia.
E) Fechar a colecistostomia.

COMENTÁRIOS

Paciente idosa, 92 anos, com múltiplas comorbidades, com risco operatório elevado, admitida com quadro de colecistite aguda grave e corretamente submetida à drenagem percutânea (colecistostomia percutânea).

Quatro semanas após o procedimento, a paciente apresentou boa resposta com a drenagem e apresenta débito de 200 mL/dia. E agora? Podemos retirar o dreno? Vamos explicar com as alternativas:

Incorreta a alternativa A: certamente, uma paciente de 92 anos e com múltiplas comorbidades é de alto risco cirúrgico e não tem indicação de uma colecistectomia. Essa seria necessária na ausência de resposta à drenagem vesicular verificada entre 1 a 3 dias ou nos casos com resolução da colecistite aguda e melhora do risco cirúrgico, o que não é o caso da nossa paciente!

Incorreta a alternativa B: porque essa é uma opção para drenagem da vesícula biliar inflamada, que seria a drenagem endoscópica por via transmural e que consiste na colocação stents metálicos autoexpansíveis entre a vesícula e o duodeno ou estômago. Nossa paciente já está drenada e com resolução da colecistite!

Incorreta a alternativa C: a colangiografia retrógrada endoscópica (CPRE) não teria benefício adicional à colangiografia pela colecistostomia, que é um procedimento muito mais simples de ser realizado, sem necessidade de sedação. A CPRE ficaria reservada para após a colangiografia pela colecistostomia, se identificasse fator obstrutivo no colédoco.

Correta a alternativa D: porque, antes da retirada do dreno, é importante avaliar a patência do ducto cístico. Um débito de 200 ml ao dia é considerável, por isso a importância de se realizar a colangiografia antes de retirá-lo. Em casos com paciente de alto risco, com contraindicação para a colecistectomia, podem ser tentadas medidas para dissolução e extração dos cálculos pelo dreno.

Incorreta a alternativa E: a colecistostomia só pode ser fechada se houver certeza da patência do ducto cístico. Caso contrário, uma nova colecistite pode surgir.

1.9.2 TRATAMENTO TOKYO

As Diretrizes de Tokyo propõem que a estratégia de tratamento seja considerada e escolhida após a avaliação da gravidade da colecistite, do estado geral do paciente e da doença subjacente. Para avaliar o risco cirúrgico, utiliza-se como critérios os fatores preditivos (baseados nas disfunções orgânicas), o *status* físico da ASA e o Índice de Comorbidade Charlson. Resumindo, avalia-se se o paciente é capaz ou não de resistir à cirurgia, com base nesses critérios.

Você vai estudar a classificação do status físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA), que determina o risco cirúrgico do paciente, no nosso livro de “Avaliação Pré-operatória”, mas vamos recordá-la:

Sistema de Classificação de *Status* Físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA)		
Classificação ASA	**Definição**	**Exemplos para adultos**
ASA I	Um paciente normal e saudável.	Saudável, não fumante, sem ou com consumo mínimo de álcool.
ASA II	Um paciente com doença sistêmica leve.	Doenças leves sem limitações funcionais substanciais. Fumante atual, etilista, gravidez, obesidade (30 <IMC <40), DM / HAS bem controlado, doença pulmonar leve.
ASA III	Um paciente com doença sistêmica grave.	Limitações funcionais substanciais; uma ou mais doenças moderadas a graves. DM ou HAS mal controlado, DPOC, obesidade mórbida (IMC ≥40), hepatite ativa, dependência ou abuso de álcool, marcapasso implantado, redução moderada da fração de ejeção, IRC com diálise programada regularmente, IAM, AVC (> 3 meses).
ASA IV	Um paciente com doença sistêmica grave que é uma ameaça constante à vida.	IAM, AVC recentes (<3 meses), isquemia cardíaca em curso ou disfunção valvar grave, redução severa da fração de ejeção, sepse, IRC sem diálise programada regularmente.
ASA V	Um paciente moribundo que não deve sobreviver sem a operação.	Aneurisma abdominal/torácico roto, traumatismo maciço, sangramento intracraniano com efeito de massa, intestino isquêmico em face de patologia cardíaca significativa ou disfunção de múltiplos órgãos/sistemas.
ASA VI	Um paciente declarado com morte cerebral cujos órgãos estão sendo removidos para fins de doadores.	

* A adição de "E" indica cirurgia de emergência: (uma emergência é definida como existente quando o atraso no tratamento do paciente levaria a um aumento significativo da ameaça à vida ou parte do corpo).
Fonte: Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA).

Já o Índice de Charlson, é um método de pontuação para categorizar as comorbidades de um paciente. Não costuma ser cobrado em prova, mas vou coloca-lo aqui apenas para você entender o risco cirúrgico utilizado nas diretrizes de Tokyo. O mais importante é você guardar o *status* físico da ASA.

ÍNDICE DE COMORBIDADE CHARLSON

Pesos atribuídos para doenças	Condições	
1	Infarto do miocárdio	Doença pulmonar crônica
	Insuficiência cardíaca congestiva	Doença do tecido conjuntivo
	Doença vascular periférica	Úlcera péptica
	Doença cerebrovascular	Doença hepática leve
	Demência	Diabetes mellitus (sem complicações)
2	Hemiplegia	Qualquer tumor sólido
	Doença renal crônica moderada ou grave	Leucemia
	Diabetes mellitus com lesão de órgãos-alvo	Linfoma maligno
3	Doença hepática moderada ou grave	
6	Tumor sólido metastático	Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)

Uma das alterações mais importantes entre a TG13 e TG18 é que essa última define disfunção neurológica, disfunção respiratória e coexistência de icterícia (bilirrubina total ≥ 2 mg / dl) como fatores preditivos negativos na colecistite de grau III. Isso quer dizer que os pacientes não devem ser submetidos à cirurgia, pois esses fatores independentes estão associados a altas taxas de mortalidade. No entanto, a disfunção renal e a disfunção cardiovascular são consideradas tipos de falência favoráveis do sistema orgânico (FOSF), portanto são definidas como "fatores preditivos não negativos", porque essas disfunções geralmente podem ser revertidas pelo tratamento inicial e pelo suporte clínico e, desse modo, os pacientes beneficiariam-se da colecistectomia precoce. Na TG13, a colecistite aguda com gravidade grau III, a cirurgia precoce era contraindicada.

A cirurgia para pacientes com colecistite Tokyo II e III deve ser realizada em centros avançados (com UTI) e por cirurgiões experientes.



RESUMINDO

CONDUTA SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DE TOKYO

1. BAIXO RISCO (ASA ≤ 2):

TOKYO I: COLECISTECTOMIA PRECOCE;

TOKYO II: COLECISTECTOMIA PRECOCE; e

TOKYO III SEM DISFUNÇÃO NEUROLÓGICA/RESPIRATÓRIA/ BT ≥ 2 MG/dL = COLECISTECTOMIA PRECOCE (após reanimação).

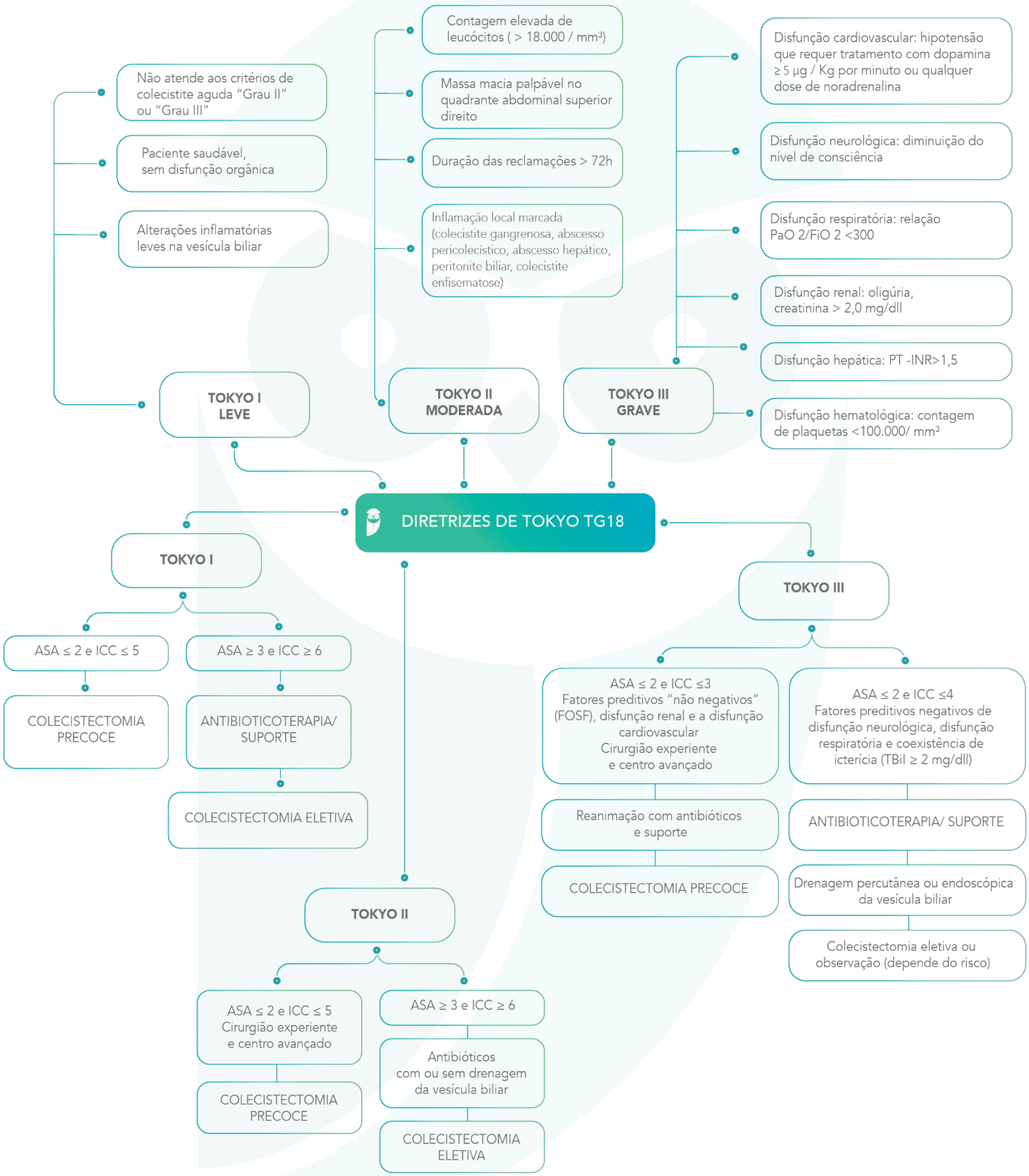
2. ALTO RISCO (ASA ≥ 3)

TOKYO I: ATB = PROGRAMAR COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA ELETIVA;

TOKYO II: ATB COM OU SEM COLECISTOSTOMIA = PROGRAMAR COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA ELETIVA; e

TOKYO III: COM DISFUNÇÃO NEUROLÓGICA/RESPIRATÓRIA/ BT ≥ 2 MG/Dl = COLECISTOSTOMIA = PROGRAMAR COLECISTECTOMIA SE HOUVER MELHORA DO RISCO CIRÚRGICO.

* ainda não há consenso sobre o momento da cirurgia após a drenagem da vesícula biliar. Idealmente, o médico que trata o paciente determinará o momento ideal para gerenciá-lo, tendo em mente seu risco.


Não atende aos critérios de colecistite aguda "Grau II" ou "Grau III"
Paciente saudável, sem disfunção orgânica
Alterações inflamatórias leves na vesícula biliar
TOKYO I LEVE
Contagem elevada de leucócitos (> 18.000 / mm³)
Massa macia palpável no quadrante abdominal superior direito
Duração das reclamações > 72h
Inflamação local marcada (colecistite gangrenosa, abscesso pericolecístico, abscesso hepático, peritonite biliar, colecistite enfisematose)
TOKYO II MODERADA
Disfunção cardiovascular: hipotensão que requer tratamento com dopamina ≥ 5 µg / Kg por minuto ou qualquer dose de noradrenalina
Disfunção neurológica: diminuição do nível de consciência
Disfunção respiratória: relação PaO 2/FiO 2 <300
Disfunção renal: oligúria, creatinina > 2,0 mg/dll
Disfunção hepática: PT -INR>1,5
Disfunção hematológica: contagem de plaquetas <100.000/ mm³
TOKYO III GRAVE
DIRETRIZES DE TOKYO TG18
TOKYO I
ASA ≤ 2 e ICC ≤ 5
ASA ≥ 3 e ICC ≥ 6
COLECISTECTOMIA PRECOCE
ANTIBIOTICOTERAPIA/ SUPORTE
COLECISTECTOMIA ELETIVA
TOKYO II
ASA ≤ 2 e ICC ≤ 5 Cirurgião experiente e centro avançado
COLECISTECTOMIA PRECOCE
ASA ≥ 3 e ICC ≥ 6
Antibióticos com ou sem drenagem da vesícula biliar
COLECISTECTOMIA ELETIVA
TOKYO III
ASA ≤ 2 e ICC ≤3 Fatores preditivos "não negativos" (FOSF), disfunção renal e a disfunção cardiovascular Cirurgião experiente e centro avançado
Reanimação com antibióticos e suporte
COLECISTECTOMIA PRECOCE
ASA ≤ 2 e ICC ≤4 Fatores preditivos negativos de disfunção neurológica, disfunção respiratória e coexistência de icterícia (TBil ≥ 2 mg/dll)
ANTIBIOTICOTERAPIA/ SUPORTE
Drenagem percutânea ou endoscópica da vesícula biliar
Colecistectomia eletiva ou observação (depende do risco)

CAI NA PROVA

(IASMPE 2020) Quanto ao tratamento da colecistite aguda, é correto afirmar que

A) o tratamento clínico exclusivo não tem mais espaço no arsenal.
B) o colecistectomia por videolaparoscopia está bem indicada no Tokio 1, porém é uma contraindicação no Tokio 2.
C) a drenagem percutânea tem espaço em casos de Tokio 2 e 3.
D) a escolha do antibiótico empírico não modifica conforme a gravidade e o risco resistência prévio.
E) colecistectomia aberta deve ser a opção no quadro agudo.

COMENTÁRIOS

As Diretrizes de Tokyo 2018 (TG18) são utilizadas para classificar e gerenciar o tratamento da colecistite e colangite aguda. Elas classificam a gravidade da colecistite em três graus (grave, moderada e leve).

CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DO TG18 / TG13 PARA COLECISTITE AGUDA

Colecistite aguda grau III (grave): associada à disfunção de qualquer um dos seguintes órgãos/sistemas:

1) Disfunção cardiovascular: hipotensão que requer tratamento com dopamina ≥ 5 µg/kg por minuto ou qualquer dose de noradrenalina;
2) Disfunção neurológica: diminuição do nível de consciência;
3) Disfunção respiratória: relação PaO 2 / FiO 2 <300;
4) Disfunção renal: oligúria, creatinina> 2,0 mg / dl;
5) Disfunção hepática: PT - INR> 1,5; e
6) Disfunção hematológica: contagem de plaquetas <100.000 / mm^3.

Colecistite aguda grau II (moderada): associada a qualquer uma das seguintes condições:

1) Contagem elevada de leucócitos (> 18.000 / mm^3);
2) Massa macia palpável no quadrante abdominal superior direito;
3) Duração das reclamações > 72 h; e
4) Inflamação local marcada (colecistite gangrenosa, abscesso pericolecístico, abscesso hepático, peritonite biliar, colecistite enfisematosa).

Colecistite aguda grau I (leve): a colecistite aguda "grau I" não atende aos critérios de colecistite aguda "grau III" ou "grau II". Também pode ser definida como colecistite aguda em um paciente saudável, sem disfunção orgânica e alterações inflamatórias leves na vesícula biliar, tornando a colecistectomia um procedimento cirúrgico seguro e de baixo risco.

Incorreta alternativa A: pacientes com colecistite Tokyo I e II com alto risco cirúrgico, ou seja, ASA ≥3, podem ser tratados apenas com suporte clínico e antibioticoterapia inicialmente. A colecistectomia poderá ser realizada posteriormente, de forma eletiva. Se permanecer o risco cirúrgico proibitivo mesmo após a resolução da colecistite, podem ser observados.

Incorreta alternativa B: desde que realizada em centros especializados e com cirurgião experiente, a colecistectomia precoce está indicada nos pacientes com colecistite aguda Tokyo II de baixo risco cirúrgico, ou seja, ASA ≤ 2.

Correta alternativa C: porque, em alguns casos de colecistite grau II e os de grau III, se o paciente for considerado de alto risco para procedimento cirúrgico (normalmente utilizando o ASA, ICC e fatores preditivos), está indicada a drenagem percutânea.

Incorreta alternativa D: porque a escolha do antibiótico, bem como seu tempo de utilização, vai depender da gravidade da colecistite, da presença de complicações e se a infecção é comunitária ou hospitalar, podendo ser corrigida de acordo com as culturas que por ventura tenham sido colhidas.

Incorreta alternativa E: o TG18 indica colecistectomia laparoscópica para todos os casos, tendo em vista que, nos casos graves (II e III), essa deve ser realizada em centros especializados com cirurgiões experientes, visando diminuir o risco de lesão da via biliar. Se necessário, a laparoscopia pode ser convertida para cirurgia aberta.

1.10 COLECISTITE AGUDA ALITIÁSICA

1.10.1 INTRODUÇÃO

A colecistite acalculosa ou alitiásica é uma doença necroinflamatória aguda da vesícula biliar com patogênese multifatorial. É responsável por aproximadamente 10% de todos os casos de colecistite aguda e está associada a altas taxas de morbimortalidade, pois há uma maior incidência de complicações.

Geralmente, acomete pacientes gravemente enfermos, que necessitam de cuidados intensivos. A maioria dos pacientes apresenta múltiplos fatores de risco, sendo os principais: idade avançada, doenças graves (por exemplo, sarcoidose, LES), trauma, uso prolongado de nutrição parenteral total, pós-operatório de cirurgia não biliar, grandes queimados, diabetes e imunossupressão.

1.10.2 FISIOPATOLOGIA

Embora o mecanismo fisiopatológico exato da colecistite alitiásica seja pouco conhecido, o aumento da viscosidade da bile, por uma maior concentração dos solutos biliares associada à estase vesicular, claramente desenvolve papel importante. Então, há um bloqueio do ducto cístico sem a presença de cálculos, podendo evoluir com isquemia e perfuração da parede nos casos mais graves. Outro fator também incriminado nesse processo é a isquemia tecidual da vesícula, decorrente de episódios de hipotensão sistêmica. Ela determinaria disfunção da mucosa com destruição do seu epitélio e exposição da mucosa aos sais biliares concentrados, que sabidamente são tóxicos aos tecidos, iniciando ou agravando processo inflamatório local.

Uma vez que a colecistite acalculosa é estabelecida, é comum a infecção secundária por patógenos entéricos, incluindo *Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Bacteroides fragilis* e cepas relacionadas.

Em alguns casos, infecções primárias específicas predispõem à colecistite acalculosa, por exemplo, infecções oportunistas e citomegalovírus em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

Fatores de risco para colecistite aguda alitiásica	
Leucemia mieloide aguda	Diabetes mellitus
Síndrome da imunodeficiência adquirida	Doença renal em estágio terminal
Estenose ampular	Insuficiência cardíaca
Transplante de medula óssea	Hemobilia
Queimaduras	**Imunossupressão**
Ressuscitação cardiopulmonar	**Infecções**
Parto	**Trauma grave**
Cisto de colédoco	Ventilação mecânica
Embolia gordurosa	Medicamentos (por exemplo, opiáceos, sunitinibe)
Doença cardíaca coronária	Metástases para porta hepática
Obstrução do ducto cístico por cateter trans-hepático percutâneo no ducto biliar	Transfusões múltiplas
Cirurgia não biliar	**Nutrição parenteral total (NPT)**
Sepse / hipotensão	Vasculite
Lupus eritematoso sitêmico	Sarcoidose sistêmica

1.10.3 EPIDEMIOLOGIA

A colecistite alitiásica é normalmente observada em pacientes hospitalizados em unidade de terapia intensiva (UTI) e gravemente enfermos. É mais frequente no sexo masculino. Apesar da colecistite aguda alitiásica geralmente acometer pacientes gravemente enfermos, ela também pode ocorrer em pacientes não hospitalizados e sem evidência de doença aguda ou trauma, e a presença de doença vascular significativa foi observada em 72% desses pacientes.

PACIENTE HOSPITALIZADO, GRAVE, COM DOR EM HCD OU SEPSE INEXPLICADA= PENSAR EM COLECISTITE ALITIÁSICA.

1.10.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

A apresentação pode ser semelhante à observada na colecistite calculosa, com febre, dor intensa no quadrante superior direito, sensibilidade à palpação e sinal de Murphy positivo. O que você precisa guardar, é que o cenário é diferente, por tratar-se de pacientes graves, geralmente hospitalizados. Então, os sintomas podem ser mascarados pelo estado crítico do paciente, muitas vezes sedado e em ventilação mecânica. A consequência é um diagnóstico mais tardio, o que, em parte, pode explicar o maior índice de gangrena e perfuração e a maior morbimortalidade descrita para essa síndrome.

1.10.5 EXAMES COMPLEMENTARES

LABORATÓRIO: leucocitose com desvio à esquerda, aumento da PCR, bilirrubinas, amilase, transaminases e fosfatase alcalina. É importante coleta de hemocultura nesses pacientes.

EXAMES DE IMAGEM: basicamente os mesmos realizados na colecistite litiásica e com parâmetros semelhantes. O ultrassom tem a vantagem de poder ser feito na beira do leito, já que a maioria dos pacientes está em estado crítico. A cintilografia é um exame de alta acurácia, porém pode ter uma taxa de falso-negativo de até 40%. Além disso, exige tempo para a realização e, em se tratando de pacientes graves, pode retardar o tratamento e agravar ainda mais o quadro.

1.10.6 DIAGNÓSTICO

A imagem na colecistite acalculosa aguda não é específica o suficiente para fazer o diagnóstico isoladamente. O diagnóstico de colecistite acalculosa aguda baseia-se em uma constelação de sintomas e sinais no cenário de achados de imagem e na exclusão de diagnósticos alternativos. O diagnóstico de colecistite acalculosa aguda geralmente é feito em pacientes com todos os seguintes itens:

- ✓ Febre, dor abdominal, leucocitose e/ou testes hepáticos elevados;
- ✓ Fatores de risco para colecistite acalculosa;
- ✓ Características radiológicas sugestivas de colecistite acalculosa (por exemplo, espessamento da parede da vesícula biliar, sinal ultrassonográfico de Murphy, líquido pericolecístico); e
- ✓ Nenhuma evidência de outras condições que possam provocar os achados clínicos e radiológicos. Devemos excluir outras causas de sepse, como pneumonia e infecção do trato urinário.

1.10.7 COMPLICAÇÕES

As complicações são as mesmas da colecistite calculosa. No entanto, são mais frequentes. A gangrena da parede vesicular pode estar presente ao diagnóstico em até 50% dos casos e pode resultar em perfuração em até 10% dos casos. A colecistite enfisematosa também é mais comum. Outras complicações relatadas são a fístula colecistoentérica ou colônica, formação de abscesso e coleperitônio.

1.10.8 TRATAMENTO

Medidas de suporte: jejum, hidratação, correção hidroeletrolítica, controle da dor e antibioticoterapia de largo espectro (colher hemocultura antes).

- ✓ **BAIXO RISCO CIRÚRGICO E ANESTÉSICO (ASA ≤ 2):** colecistectomia; e
- ✓ **ALTO RISCO CIRÚRGICO E ANESTÉSICO (ASA ≥ 3), INSTÁVEIS**: drenagem percutânea da vesícula biliar guiada por exame de imagem (ultrassom ou tomografia). Aproximadamente 90% dos pacientes melhoram com a drenagem. O dreno pode ser retirado após resolução da colecistite e drenagem mínima (< 10 ml, geralmente após 4 a 6 semanas). Como a recorrência é baixa, não está indicada colecistectomia posteriormente. Uma ultrassonografia deve ser realizada posteriormente para excluir uma litíase que possa não ter sido visualizada na imagem anterior. Se estiver presente, indicar a colecistectomia eletiva.

CAI NA PROVA

(UFRJ 2018) Homem, 75 anos, submetido à colectomia, evolui com deiscência da anastomose primária e necessidade de reintervenção. No 4° dia de pós-operatório apresenta piora do quadro com piora de leucocitose, instabilidade hemodinâmica e necessidade de aminas vasopressoras. Exame físico: sensibilidade no Quadrante Superior Direito (QSD) do abdome. Ultrassonografia (USG) abdominal: vesícula muito distendida sem cálculos. A conduta mais adequada para esse paciente, nesse momento, é:

A) Colecistectomia videolaparoscópica.
B) Colecistostomia percutânea.
C) Colecistectomia por laparotomia.
D) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada.

COMENTÁRIOS

Temos um paciente idoso, em pós-operatório de cirurgia abdominal (não biliar), com necessidade de reabordagem por deiscência de anastomose. Estamos diante de um paciente crítico, com dor em hipocôndrio direito, febre, piora da leucocitose e sinais ultrassonográficos de colecistite, mas sem cálculos. Devemos considerar o diagnóstico de colecistite aguda alitiásica.

Uma vez feito o diagnóstico, deve-se proceder com tratamento de urgência, que inclui a administração de antibióticos de amplo espectro, medidas de suporte e colecistectomia ou drenagem percutânea da vesícula biliar (colecistostomia), a depender do estado clínico do paciente.

Em doentes instáveis ou com disfunções orgânicas, como nosso paciente, a drenagem da vesícula biliar, por via percutânea guiada por exame de imagem, é a conduta de eleição.

No entanto, vale lembrar que, nos pacientes em que não se observa melhora após a drenagem, ou então nos casos de complicações, como perfuração com coleperitônio, a cirurgia deve ser de urgência.

Agora vamos às alternativas.

Incorreta a alternativa A: porque essa seria a conduta se o paciente estivesse estável hemodinamicamente e com baixo risco cirúrgico. Mas, a via preferida seria a laparotomia, pois nosso paciente tem uma laparotomia prévia recente.

Correta a alternativa B: a colecistostomia percutânea é o procedimento de eleição nos casos de colecistite aguda em pacientes instáveis e com alto risco cirúrgico. No entanto, devemos lembrar-nos de que, nos pacientes em que não há melhora após a drenagem, a colecistectomia deve ser imediata.

Incorreta alternativa C: porque essa seria a conduta se o paciente estivesse estável hemodinamicamente e com baixo risco cirúrgico. Como o paciente tem uma laparotomia prévia recente, essa seria a via preferida para realizar a colecistectomia.

Incorreta alternativa D: a CPRE (colangiopancreatografia endoscópica retrógrada) é um procedimento primariamente indicado nos casos em que há obstrução da via biliar, e não na colecistite alitiásica.

(SES PE - 2017) A colecistite alitiásica é uma condição cirúrgica grave, que necessita de um procedimento cirúrgico de emergência. É estimado que ocorra em 2-15% dos casos de colecistite, e a mortalidade pode chegar a 50%. Qual das situações abaixo é um fator de risco para essa situação?

A) Grande queimado.
B) Nutrição enteral oligomérica.
C) Hepatite C aguda.
D) Uso de vancomicina.
E) Úlcera duodenal H pylori +.

COMENTÁRIO

A colecistite alitiásica resulta de estase da vesícula biliar, isquemia e até perfuração nos casos mais graves. Geralmente, acomete pacientes críticos, hospitalizados, sendo que a maioria apresenta múltiplos fatores de risco. Abaixo estão os principais fatores de risco:

Fatores de risco para colecistite aguda alitiásica	
Leucemia mieloide aguda	Diabetes mellitus
Síndrome da imunodeficiência adquirida	Doença renal em estágio terminal
Estenose ampular	Insuficiência cardíaca
Transplante de medula óssea	Hemobilia
Queimaduras	Imunossupressão
Ressuscitação cardiopulmonar	Infecções
Parto	Trauma grave
Cisto de colédoco	Ventilação mecânica
Embolia gordurosa	Medicamentos (por exemplo, opiáceos, sunitinibe)
Doença cardíaca coronária	Metástases para porta hepática
Obstrução do ducto cístico por cateter trans-hepático percutâneo no ducto biliar	Transfusões múltiplas
Cirurgia não biliar	Nutrição parenteral total
Sepse/hipotensão	Vasculite

Dentre as alternativas, apenas o “grande queimado” constitui fator de risco para a colecistite alitiásica. Fique atento! Apenas a nutrição parenteral total é considerada fator de risco, e não a nutrição enteral!

Correta a alternativa A.

(SCM SP 2018) Um paciente de 62 anos de idade, com dez dias de revascularização do miocárdio, foi mantido na UTI em função de arritmia. Encontra-se sob intubação orotraqueal, mas já em desmame, em pressão de suporte e recebendo nutrição parenteral. Passou a apresentar distensão e dor à palpação do abdome, principalmente em HCD. Apresenta febre e leucocitose. Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e o exame a ser realizado:

A) Hepatite transfusional – hemocultura.
B) Colecistite aguda alitiásica – ultrassonografia de abdome.
C) Síndrome hepatorrenal – clearance de creatinina.
D) Infarto hepático – arteriografia hepática.
E) Hepatite transinfecciosa do imunodeprimido – sorologia para hepatite

COMENTÁRIOS

Estamos diante de um paciente internado em unidade de terapia intensiva, em pós-operatório de revascularização miocárdica, em ventilação mecânica e recebendo nutrição parenteral que inicia quadro de febre e dor à palpação de hipocôndrio direito. Esse é o quadro clássico da colecistite alitiásica! O diagnóstico é confirmado pela ultrassonografia (vantagem de poder ser realizada na beira do leito da UTI, sem necessidade de transportar o paciente).

O tratamento de escolha, se o paciente tiver condições clínicas, é a colecistectomia laparoscópica. Se o paciente for incapaz de tolerar um procedimento cirúrgico, a drenagem percutânea da vesícula, guiada por ultrassom ou por tomografia computadorizada, deve ser realizada.
Incorreta a alternativa A: não vamos pensar em hepatite transfusional, pois não foi relatada história de transfusão de hemocomponentes.

Correta a alternativa B: o provável diagnóstico é uma colecistite alitiásica, que será confirmada pela ultrassonografia.

Incorreta a alternativa C: a síndrome hepatorrenal é uma forma de falência aguda da função renal que ocorre em cerca de 10% dos pacientes com cirrose hepática avançada, o que não é o caso do nosso paciente.
Incorreta a alternativa D: o infarto hepático é bastante raro! Lembre-se de que o fígado apresenta vascularização dupla (artéria hepática e veia porta!). O infarto de um segmento pode ser secundário à ligadura iatrogênica de artéria hepática durante colecistectomia, trombose de ramo arterial hepático decorrente de aterosclerose, ou após ablação por radiofrequência de carcinoma hepatocelular, entre outros. A angiotomografia e arteriografia geralmente fazem o diagnóstico.
Incorreta a alternativa E: não há relato de que nosso paciente seja imunodeprimido, e o diagnóstico de uma hepatite transinfecciosa não se faz por sorologia.

1.11 COLECISTITE AGUDA NA GESTANTE

Os cálculos biliares são mais comuns durante a gravidez, devido à diminuição da motilidade da vesícula biliar e ao aumento da saturação de colesterol da bile. Os níveis elevados de hormônios reprodutivos durante a gravidez induzem uma variedade de alterações fisiológicas no sistema biliar, que promovem a formação de cálculos biliares:

- ✓ O estrogênio aumenta a secreção de colesterol e a progesterona reduz a secreção de ácido biliar, o que faz com que a bile fique supersaturada com o colesterol; e
- ✓ A progesterona diminui o esvaziamento da vesícula biliar, o que promove ainda mais a formação de pedras, causando estase biliar.

Essas alterações se normalizam um a dois meses após o parto.

A colecistite aguda é a segunda causa de abdome agudo não obstétrico na gestante (1-6: 10.000), lembrando que a primeira é a apendicite.

A apresentação de colecistite aguda é semelhante à de mulheres não grávidas: dor no quadrante superior direito ou epigástrica constante e intensa, prolongada (mais de quatro a seis horas) e possivelmente irradiando para o ombro (sinal de Kehr) ou região escapular direita. Os sintomas associados incluem febre, anorexia, náusea e vômito. O exame abdominal geralmente demonstra defesa voluntária e involuntária e no hipocôndrio direito e, frequentemente, o sinal de Murphy é positivo.

As alterações nos exames laboratoriais e de imagem também são semelhantes àquelas das pacientes não grávidas, só devemos estar atentos por na gravidez ocorrer uma leucocitose fisiológica (intervalo normal entre 9.000 e 15.000 células/microL).

O melhor exame de imagem para confirmar o diagnóstico da colecistite é a ultrassonografia e, se essa for inconclusiva, a ressonância nuclear magnética, de preferência sem o uso do gadolínio, é uma opção segura, por não expor o feto à radiação ionizante.

É necessária terapia cirúrgica imediata e definitiva para qualquer paciente com colecistite e sinais de sepse, suspeita de gangrena e perfuração, bem como progressão da doença durante a antibioticoterapia.

Na ausência de tais indicações para cirurgia de urgência ou emergência, o tratamento ideal para a colecistite aguda depende da idade gestacional:

Gestantes no primeiro e segundo trimestres, com baixo risco cirúrgico (ASA ≤ 2) devem ser submetidas à colecistectomia durante a hospitalização. Embora os sintomas da colecistite possam diminuir dentro de 7 a 10 dias após o início do tratamento não cirúrgico, existe um alto risco de recorrência (55%) ou complicações graves.

No caso de gestantes no terceiro trimestre, sempre que possível, deve-se tentar inicialmente o tratamento não cirúrgico, com antibióticos e medidas de suporte, para permitir o atraso da colecistectomia até o período pós-parto, geralmente após 6 semanas do parto. A colecistectomia no terceiro trimestre pode ser tecnicamente difícil e tem sido associada a um aumento no trabalho de parto prematuro. Se, apesar do tratamento não operatório, a paciente continuar apresentando sintomas ou mostrar sinais de complicações, a colecistectomia deve ser realizada nas pacientes com baixo risco cirúrgico.

Nas gestantes consideradas de alto risco para cirurgia (ASA ≥ 3), as alternativas à colecistectomia incluem drenagem percutânea ou aberta da vesícula biliar.



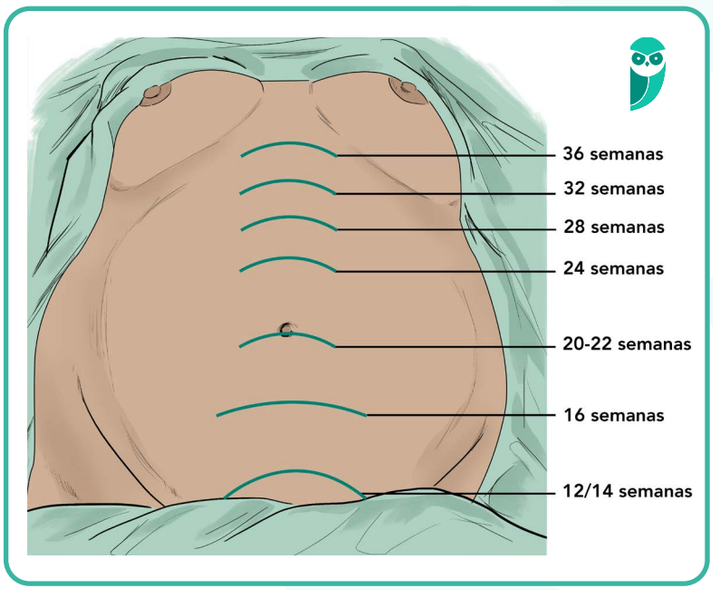
GESTANTE COM COLECISTITE

✓ Baixo risco (ASA ≤ 2):
- 1º e 2º trimenstre: colecistectomia laparoscópica; e
- 3° trimestre: antibióticos, postergar a colecistectomia para o pós-parto (6 semanas).

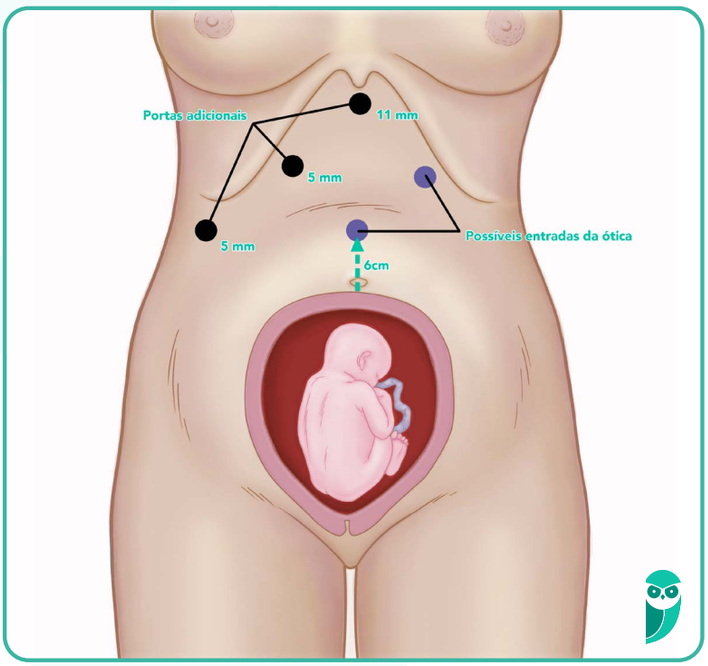
✓ Alto risco (ASA ≥ 3), instável: drenagem percutânea (colecistostomia).

Há um maior risco de perda fetal nas colecistectomias realizadas no primeiro trimestre. Uma taxa de aborto espontâneo de 12% com a colecistectomia aberta diminui para 5,6% e 0% durante o segundo e terceiro trimestres, respectivamente. Já o risco de trabalho de parto prematuro é quase zero no segundo trimestre e 40% durante o terceiro trimestre, tornando o segundo trimestre o momento ideal para colecistectomia por colelitíase, quando o risco de perda fetal e trabalho de parto prematuro são menores.

A colecistectomia laparoscópica, em qualquer trimestre de gestação, é a técnica preferida em mulheres grávidas. Uma abordagem aberta pode ser necessária no terceiro trimestre devido à dificuldade na colocação e insuflação das portas. A laparoscopia, em geral, oferece recuperação mais precoce, dor pós-operatória reduzida, menor uso de opioides, incisões menores e menos complicações da ferida, como hérnia ou infecções no local cirúrgico. A paciente deve ser posicionada levemente com a cabeça erguida e inclinada para a esquerda, descomprimindo a veia cava inferior. É aconselhável usar a técnica aberta (Hasson) para obter acesso inicial à cavidade abdominal e manter a insuflação de CO2 entre 10 e 15 mmHg. No terceiro trimestre, pode ser vantajoso mover o portal epigástrico para o quadrante superior esquerdo para evitar-se lesão uterina e ter uma melhor visão.



Altura uterina.



Portais da laparoscopia na gestante.

CAI NA PROVA

(HFR 2019) Uma paciente de 35 anos de idade, grávida de 18 semanas, apresentou quadro de dor em hipocôndrio direito do tipo cólica, associada a náuseas, vômitos e febre. Realizou um ultrassom (US) abdominal que mostrou sinais compatíveis com colecistite aguda litiásica. Assinale a afirmativa CORRETA sobre essa condição:

A) Tratamentos menos agressivos como a colecistostomia percutânea devem ser tentados para diminuir os riscos.
B) O tratamento de escolha é clínico (antibioterapia venosa), devido ao alto risco cirúrgico para mãe e feto.
C) O risco de desenvolver cálculos biliares diminui na gravidez, devido ao efeito protetor da progesterona.
D) Trata-se da urgência cirúrgica não ginecológica mais comum na gravidez, depois da apendicite aguda.

COMENTÁRIOS

Temos uma gestante de 18 semanas, ou seja, no 2º trimestre de gestação, com diagnóstico confirmado de colecistite aguda.

Incorreta a alternativa A: porque a colecistostomia percutânea é conduta de exceção em casos graves de colecistite aguda em que o paciente não apresenta condições clínicas para anestesia geral e cirurgia, ou seja, pacientes de alto risco cirúrgico (ASA III, IV e V) e instáveis.

Incorreta a alternativa B: porque temos uma paciente gestante com diagnóstico clínico e ultrassonográfico de colecistite aguda. O tratamento ideal da gestante no segundo trimestre é a colecistectomia videolaparoscópica. No 3° trimestre, podemos tentar o tratamento com antibióticos endovenosos e postergar a cirurgia para o pós-parto.

Incorreta a alternativa C: porque o risco de desenvolver cálculos biliares aumenta na gravidez.

Correta a alternativa D: porque a colecistite é a segunda causa de urgência abdominal, não obstétrica, na gestação.

(USP RP 2016) Mulher, 26 anos de idade, sem comorbidades, na 21ª semana de gestação, admitida em unidade de pronto atendimento, com episódio de dor forte e contínua no epigástrio e hipocôndrio direito, após ingesta de massas, há 10 horas, associada a náuseas e vômitos. Refere dois episódios semelhantes com duração mais curta que cederam após vômitos e medicação sintomática, no último bimestre. O exame ultrassonográfico está abaixo. (VER IMAGEM). A conduta mais indicada é:



A) Antibioticoprofilaxia, colecistectomia videolaparoscópica, em hospital de média complexidade, de imediato.

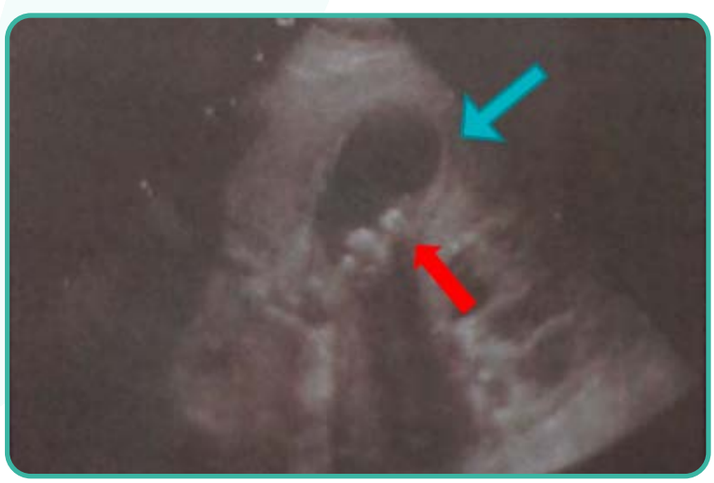
B) Antiespasmódico, antibioticoterapia e colecistectomia em hospital de média complexidade, após resolução de gravidez.

C) Antibioticoterapia e colecistectomia videolaparoscópica, em hospital de elevada complexidade, de imediato.

D) Antiespasmódico, antibioticoterapia e colecistectomia, em hospital de elevada complexidade, após resolução da gravidez.

COMENTÁRIOS

Bom, aqui temos uma gestante no 2º trimestre de gestação com uma história típica de colecistite aguda: ela tem dor em hipocôndrio direito e epigástrio, forte e persistente (superior a quatro horas), associada a náuseas e vômitos. A imagem de uma ultrassonografia confirma-nos essa hipótese. É possível visualizar cálculos no interior da vesícula (seta vermelha) e parede espessada (seta azul).



Agora vamos às alternativas!

Correta alternativa A: o tratamento de escolha da coleciste aguda na gestante do 2º trimestre é a colecistectomia laparoscópica precoce e pode ser realizado em hospital de média complexidade, já que a paciente está estável e não apresenta comorbidades (baixo risco cirúrgico). O risco de recorrência de uma colecistite no 1º e 2º trimestre pode chegar a 55%. Nas pacientes de alto risco cirúrgico (ASA III, IV e V) e instáveis, deve ser realizada antibioticoterapia e drenagem percutânea da vesícula, se necessário.

O uso de antibióticos na colecistite não complicada é profilático.

Incorreta alternativa B: essa seria a conduta se a paciente estivesse no 3º trimestre da gestação.

Incorreta alternativa C: como trata-se de um quadro de colecistite não complicada, ao que tudo indica, em uma gestação de baixo risco (Tokyo I), admite-se que a cirurgia seja realizada em um hospital de média complexidade. Só relembrando, em pacientes com colecistite Tokyo II e III, quando indicadas à colecistectomia, a cirurgia deverá ser realizada em centros avançados e com cirurgiões experientes.

Incorreta alternativa D: a colecistectomia diante de uma colecistite não complicada deve ser precoce e não há necessidade de ser em hospital de elevada complexidade

CAPÍTULO

2.0 COLANGITE AGUDA

2.1 INTRODUÇÃO

A colangite aguda é uma síndrome clínica caracterizada por febre, icterícia e dor abdominal, que se desenvolve como resultado de obstrução, estase e infecção no trato biliar. Também é conhecida como colangite ascendente. Foi descrita por Charcot em 1877 como uma doença grave e com risco de vida.

2.2 EPIDEMIOLOGIA

As causas mais frequentes de obstrução biliar em pacientes com colangite aguda são cálculos biliares (28% a 70%), estenose biliar benigna (5% a 28%) e malignidade (10% a 57 %).

A obstrução maligna pode ocorrer devido à presença de tumor na vesícula biliar, no ducto biliar, na ampola, no duodeno ou no pâncreas. As estenoses biliares benignas podem ser congênitas, pós-infecciosas (por exemplo, colangiopatia por AIDS) ou inflamatórias (por exemplo, colangite esclerosante primária).

A colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, esfincterotomia endoscópica, cirurgia do colédoco ou inserção de *stent* biliar são fatores de risco para o desenvolvimento da colangite. Raramente, o ducto biliar comum distal pode ser obstruído por alimentos ou detritos em pacientes com anastomose bilioentérica (síndrome de Sump).

Outras causas raras de obstrução que levam à colangite aguda incluem compressão extrínseca do ducto biliar devido a um divertículo periampullar duodenal (síndrome de Lemmel), inflamação secundária à pancreatite aguda ou cálculo impactado no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar (síndrome de Mirizzi). As causas intrínsecas da obstrução biliar incluem coágulos sanguíneos e infecções parasitárias (principalmente vermes hepáticos e ascaris). Os fragmentos de vermes retidos podem servir como ponto de partida para formação de cálculos biliares e causar colangite piogênica recorrente.

2.3 FISIOPATOLOGIA

OBSTRUÇÃO BILIAR



A colangite aguda é causada principalmente por infecção bacteriana em um paciente com obstrução biliar. Os organismos geralmente ascendem do duodeno quando os mecanismos de barreira à entrada de bactérias no sistema biliar são rompidos. Essas barreiras incluem o esfíncter de Oddi, a ação bacteriostática dos sais biliares e a ação de lavagem da bile. A mucosa biliar e IgA secretora podem impedir a colonização bacteriana devido a sua ação antiaderente. A disseminação hematogênica da veia porta é uma fonte rara de infecção.

Além da obstrução e infecção bacteriana da via biliar, outro fator importante para o desenvolvimento da colangite é o aumento da pressão intraluminal. A via biliar normalmente apresenta uma pressão que varia 10-14 cmH_2O, e pressões entre 18 a 29 cmH_2O causam fluxo biliar retrógrado, permitindo que a bile infectada atinja o sistema venoso e linfático e deflagre a bacteremia.

COLANGITE AGUDA = OBSTRUÇÃO BILIAR + COLESTASE + HIPERTENSÃO INTRABILIAR + INFECÇÃO.

Com a obstrução, há um aumento da pressão intrabiliar, o que leva ao aumento da permeabilidade dos ductos biliares, permitindo a translocação de bactérias e toxinas da circulação portal para o trato biliar e a migração de bactérias da bile para a circulação sistêmica, aumentando a resposta inflamatória sistêmica e o risco de septicemia.

De um modo geral, a flora bacteriana na colangite aguda é polimicrobiana. A *E.coli* é a principal bactéria Gram-negativa isolada (25% a 50%), seguida pela *Klebisiella* (15% a 20%) e *Enterobacter* (5% a 10%). E, entre as Gram-positivas, as mais comuns são as espécies de *Enterococcus* (10% a 20%). Bacilos Gram-negativos (ex.: *Pseudomonas*) e anaeróbios, como *Bacteroides* e *Clostridium*, também podem estar presentes como parte de uma infecção mista.

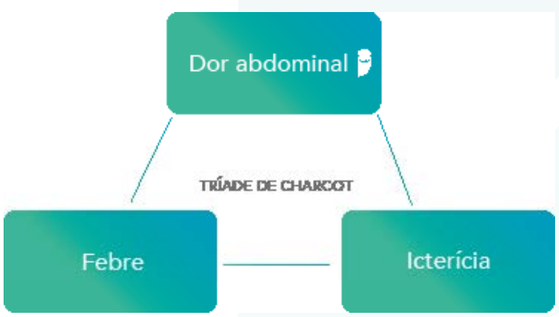
A maioria dos pacientes com colelitíase sintomática, colecistite aguda ou coledocolitíase na ausência de colangite possui um único microrganismo isolado em culturas biliares. Infecções polimicrobianas são mais comuns em pacientes com colangite aguda, em que a cultura da bile, cálculos ductais e *stents* biliares obstruídos são positivos em mais de 90% dos casos, produzindo um crescimento misto de bactérias Gram-negativas e Gram-positivas.

2.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

A apresentação clássica da colangite aguda é febre, dor abdominal e icterícia, a famosa "**TRÍADE DE CHARCOT"**, embora apenas 50% a 75% dos pacientes tenham todos os três achados. A sensibilidade da tríade é baixa (cerca de 26%), mas a especificidade é alta. Os sintomas mais comuns da colangite aguda são febre e dor abdominal, observadas em aproximadamente 80% dos pacientes. A icterícia é observada em 60% a 70% dos pacientes. A dor da colangite é menos intensa, comparada à colecistite e pancreatite, e **não** apresenta irritação peritoneal.

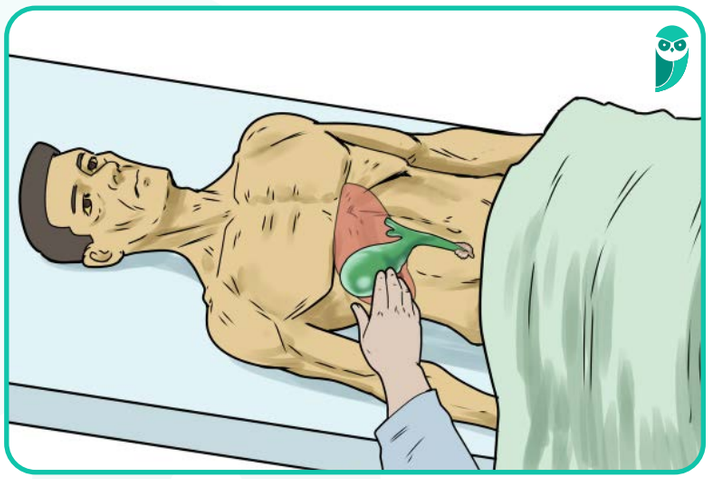
A icterícia causada pela elevação do nível sérico de bilirrubina pode ser notada na esclerótica, no freio lingual ou na pele. São necessários níveis séricos de bilirrubina acima de 2,5 mg/dl para detectar rotineiramente uma icterícia na esclerótica, e níveis acima de 5 mg/dl irão manifestar-se como icterícia cutânea. A impossibilidade de excretar a bile do fígado para os intestinos é um pré-requisito para o aparecimento da icterícia.

Pacientes com colangite aguda grave (supurativa), evidenciada por secreção purulenta na via biliar, podem apresentar, além da Tríade de Charcot, hipotensão e alterações do estado mental (sonolência, confusão mental), chamada de **PÊNTADE DE REYNOLDS**. A hipotensão pode ser o único sintoma presente em pacientes idosos ou em uso de glicocorticoides.





O sinal de Courvoisier-Terrier é definido como a presença de icterícia associada a uma vesícula biliar palpável e indolor. É um forte indicativo de neoplasia periampular. No entanto, pode ocorrer na coledocolitíase e na colangite.



Sinal de Courvoisier-Terrier.

CAI NA PROVA

(UNICAMP 2019) Mulher, 32a, procura atendimento médico por febre e dor abdominal em hipocôndrio direito há 1 dia. Antecedentes pessoais: litíase biliar e esteatose hepática diagnosticadas por ultrassonografia há seis meses. Exame físico: icterícia +++/4+; desidratada +/4+; corada; T = 38º C; FR = 26 irpm; FC= 120 bpm; abdome: dor a palpação em hipocôndrio direito no rebordo costal, Sinal de Murphy negativo, descompressão brusca dolorosa ausente. ALT = 250 UI/L; AST = 300 UI/L; bilirrubina direta = 6,7 mg/dl; bilirrubina indireta = 0,6 mg/dl; gama GT = 336 mg/dl; fosfatase alcalina = 680 UI/L; leucócitos = 16.400 mm³; (Bastonete 8%, Segmentado 71%, Linfócitos 15%, monócitos 4% eosinófilos 2%) HB = 13,1 g/dl; Ht = 40%. O quadro descrito é uma complicação de:

A) Colecistite aguda.
B) Coledocolitíase.
C) Pancreatite aguda.
D) Esteatohepatite.

COMENTÁRIOS

Temos uma paciente jovem, já com diagnóstico de colelitíase, evoluindo com dor em hipocôndrio direito, febre e icterícia, ou seja, temos a tríade de Charcot da colangite aguda. Para que haja a colangite, é necessário algum grau de obstrução da via biliar e posterior infecção da bile estagnada.

Vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A: porque na colecistite aguda não há icterícia tão marcante e um sinal clássico no exame físico é a presença do sinal de Murphy, ou seja, parada abrupta da inspiração profunda durante a palpação do quadrante superior direito.

Correta a alternativa B: porque a paciente já tem o diagnóstico de colelitíase e está evoluindo com icterícia às custas de bilirrubina direta. Nesses casos, devemos sempre pensar na hipótese de uma coledocolitíase, ou seja, obstrução da via biliar por cálculo, que é a principal causa de colangite aguda. Como ela ainda apresenta sinais de inflamação sistêmica, como febre, taquicardia e leucocitose com desvio à esquerda, o diagnóstico mais provável é uma colangite aguda. Ainda vou falar sobre o diagnóstico de colangite, mas já anote que, assim como na colecistite aguda, é necessário um exame de imagem para confirmá-lo.

Incorreta a alternativa C: porque a pancreatite aguda pode ser uma complicação da colelitíase, porém o padrão da dor abdominal é diferente e, geralmente, não apresenta icterícia associada. A dor é de forte intensidade, em região epigástrica, em faixa, com irradiação para o dorso, e é comum o paciente apresentar vômitos.

Incorreta a alternativa D: porque a esteatohepatite é uma inflamação hepática que ocorre em pacientes com esteatose hepática. Geralmente, apresentam hepatomegalia, fadiga, mal-estar e desconforto em hipocôndrio direito. Pode haver elevação das transaminases e bilirrubinas. Nossa paciente já tem diagnóstico de colelitíase e está ictérica, com padrão obstrutivo (aumento da bilirrubina direta). Temos que pensar na complicação mais óbvia nesses casos, que seria a coledocolitíase e colangite aguda.

(PSU AL 2019) Em relação à Colangite, assinale a alternativa CORRETA:

A) A dor é geralmente intensa e se associa com reação peritoneal (defesa abdominal localizada)
B) Deve-se evitar a manipulação (instrumentação) das vias biliares na fase aguda devido ao risco de septicemia
C) É essencial a presença de algum grau de obstrução da via biliar principal para instalação do quadro
D) Febre, icterícia e choque compõem a tríade de Charcot

COMENTÁRIOS

Questão direta sobre colangite, vamos logo às alternativas:

Incorreta a alternativa A: porque a dor da colangite é menos intensa e não está associada à reação peritoneal. Essa dor é típica da COLECISTITE AGUDA, que tem o sinal de Murphy positivo. A dor pode estar ausente na colangite, principalmente em pacientes idosos.

Incorreta a alternativa B: eu não cheguei no tratamento da colangite, mas adianto a você que ele é baseado em antibioticoterapia e drenagem da via biliar, que atualmente é feita por via endoscópica (CPRE – colangiopancreatografia retrógrada endoscópica), trans-hepática percutânea ou por via cirúrgica. Logo, a manipulação da via biliar para desobstrução dela é primordial!

Correta a alternativa C. É necessário haver algum grau de obstrução da via biliar, mesmo que parcial, para que se desenvolva a colangite. Lembrando que a principal causa da obstrução são os cálculos biliares.

Incorreta a alternativa D: porque a tríade de Charcot é composta por febre, icterícia e dor abdominal. A presença de alterações do nível neurológico e hipotensão, associada à tríade de Charcot, compõe a PÊNTADE DE REYNOLDS.

(UFSC 2019) A tríade de Charcot é uma síndrome caracterizada pelos seguintes sinais/sintomas:

A) Febre • prurido • choque
B) Dor abdominal • icterícia • febre.
C) Dor abdominal • icterícia • choque séptico.
D) Icterícia • alterações do sistema nervoso central • febre.
E) Choque • febre • alterações do sistema nervoso central.

COMENTÁRIOS

Se cair na sua prova uma questão de colangite, provavelmente será questionando sobre a tríade de Charcot ou pêntade de Reynolds, ou esses sinais e sintomas vão estar embutidos no enunciado. Então, por favor, guarde essa tríade e pêntade!

TRÍADE DE CHARCOT: DOR ABDOMINAL + FEBRE + ICTERÍCIA.
PÊNTADE DE REYNOLDS: TRÍADE + HIPOTENSÃO + ALTERAÇÃO MENTAL.

Correta a alternativa B.

(UFRJ 2017) Paciente submetido a colecistectomia há quatro meses, apresenta icterícia flutuante associada a episódios de febre, dor em hipocôndrio direito e fosfatase alcalina elevada, A hipótese diagnóstica provável é:

A) Estenose cicatricial da via biliar.
B) Litíase residual de colédoco.
C) Colestase pós-operatória.
D) Síndrome de Mirizzi.

COMENTÁRIOS

A presença de icterícia flutuante, aquela que "vai e volta" ou "aumenta e diminui", é típica de cálculo movimentando-se na via biliar principal. Em uma paciente com histórico de colecistectomia recente, o mais provável é que tenha ficado um cálculo residual no colédoco, propiciando uma colangite, que é o provável diagnóstico da nossa paciente, já que apresenta dor, febre e icterícia. A elevação da fosfatase alcalina, comum nos quadros de obstrução da via biliar, também é compatível com o diagnóstico.

Incorreta alternativa A: a estenose cicatricial de via biliar é uma complicação possível, diante de um pós-operatório de colecistectomia, mais comum nas cirurgias abertas. No entanto, a icterícia secundária à estenose é progressiva, e não de caráter flutuante, como diz a questão.

Correta alternativa B. A icterícia de caráter flutuante é compatível com cálculo móvel no ducto colédoco. Quando há a obstrução da papila, os sintomas surgem, e, quando o cálculo migra, permitindo a passagem da bile, há remissão dos sintomas. Lembre-se que, para poder dizer que um cálculo é primário de colédoco, são necessários pelo menos dois anos da colecistectomia. Antes desse período, o cálculo é primário ou residual.

Incorreta alternativa C: o termo "colestase" significa estagnação da bile, que pode ser extra-hepática (por obstrução) ou intra-hepática (geralmente por alteração funcional do hepatócito, como nas doenças autoimunes, reação a drogas, hepatites, álcool). A causa mais comum de colestase pós-operatória é a obstrução biliar extra-hepática decorrente de complicações intra-abdominais ou fármacos administrados no pós-operatório. A colestase intra-hepática ocasionalmente desenvolve-se depois de uma grande cirurgia, especialmente após procedimentos abdominais ou cardiovasculares (colestase intra-hepática pós-operatória benigna). A patogênese é desconhecida, mas a condição costuma resolver-se de maneira lenta e espontânea. A clínica apresentada é icterícia (sem padrão flutuante) e prurido.
Incorreta alternativa D: a síndrome de Mirizzi é caracterizada pela obstrução das vias biliares extra-hepáticas por compressão de um cálculo grande, no interior da vesícula, impactado na altura do ducto cístico. Logo, por definição, um paciente colecistectomizado não poderia desenvolver uma síndrome de Mirizzi.

(AMRIGS 2020) Em relação à colangite, analise as assertivas abaixo: I. A maioria dos casos são causados por enterobactérias. II. Deve-se indicar, o quanto antes possível, drenagem de via biliar. III. A tríade de Charcot está presente na maioria dos pacientes com colangite aguda. Quais estão corretas?

A) Apenas III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.

COMENTÁRIOS

Vamos às afirmações:
I: As bactérias mais comumente encontradas na colangite aguda são de origem entérica, Gram-negativas e positivas. A E. coli é a principal bactéria Gram-negativa isolada (25% a 50%), seguida pela Klebisiella (15% a 20%). Entre as Gram-positivas, as mais comuns são as espécies de Enterococcus (10% a 20 %): **CORRETA.**
II: a drenagem da via biliar diante de um quadro de colangite aguda é uma urgência. Pode ser feita por meio da CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica), percutânea trans-hepática e por via cirúrgica: **CORRETA.**
III: Relembrando a Tríade de Charcot: dor + icterícia + febre. Ela está presente em cerca de 50% a 75% dos pacientes, ou seja, na maioria: **CORRETA.**

Correta a alternativa D: porque todas as alternativas estão corretas.

2.5 EXAMES COMPLEMENTARES

2.5.1 EXAMES LABORATORIAIS

As principais alterações laboratoriais na colangite aguda incluem leucocitose, exames hepáticos com um padrão colestático com elevação da fosfatase alcalina, gamaglutamiltranspeptidase e de bilirrubina (predominantemente a fração direta). Pode haver um aumento importante das transaminases se houver necrose aguda de hepatócitos e formação de microabscessos no fígado.

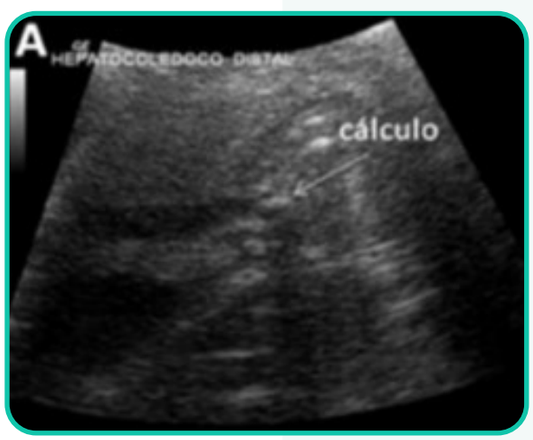
Culturas, sérica e biliar (se houver drenagem), devem sempre ser solicitadas para adequar a antibioticoterapia em pacientes com colangite moderada e grave.

2.5.2 EXAMES DE IMAGEM

Para o diagnóstico definitivo de colangite aguda, é necessário, obrigatoriamente, exame de imagem que demonstre dilatação da via biliar ou até mesmo o fator obstrutivo.

COLANGITE AGUDA = história clínica + exame físico + laboratório
EXAME DE IMAGEM.

ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL

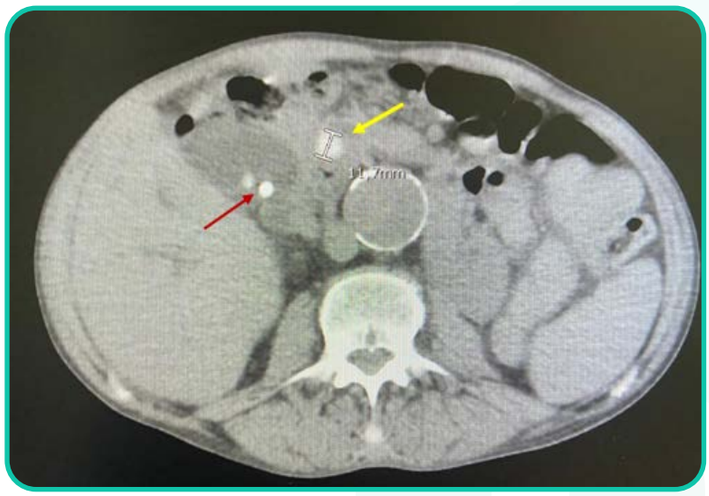


Coledocolitíase e dilatação da via biliar.
Fonte: Prova de acesso direto USP RP, 2011.

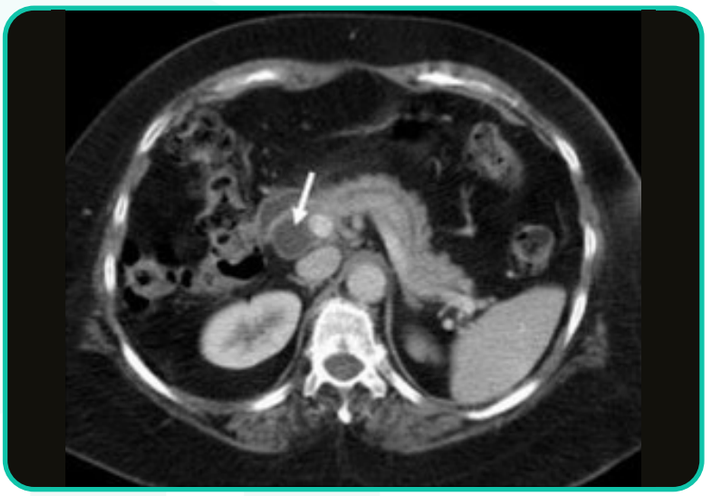
Na ultrassonografia, as alterações mais importantes incluem a dilatação biliar e visualização de cálculos no ducto biliar. Geralmente, consideramos um colédoco dilatado a partir de 6 mm. O ultrassom tem a vantagem de ser um teste não invasivo que pode ser realizado à beira do leito em pacientes críticos. Pode ser negativo, quando o cálculo presente nos ductos biliares for pequeno, ou com obstrução aguda, quando o ducto biliar ainda não teve tempo de se dilatar. Tem alta especificidade (96%), mas sensibilidade insuficiente (42%). A baixa sensibilidade para diagnosticar cálculos no colédoco distal pode ser justificada pelos gases intestinais, que frequentemente obscurecem o campo de imagem.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A tomografia tem alta sensibilidade para identificar a dilatação do ducto biliar e pode identificar estenose biliar (por exemplo, carcinoma biliar, câncer de pâncreas ou colangite esclerosante), mas tem baixa sensibilidade para cálculos do ducto biliar. É útil no diagnóstico de complicações locais, por exemplo, abscesso hepático ou trombose da veia porta. Em alguns casos mais graves, é possível ver a presença de aerobilia por produção de gás bacteriano dentro da árvore biliar obstruída.



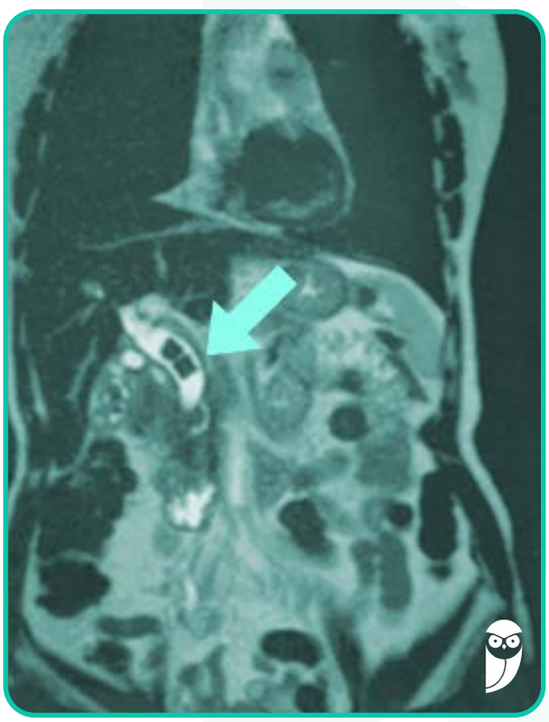
Seta vermelha: colelitíase. Seta amarela: coledocolitíase.
Fonte: acervo pessoal.



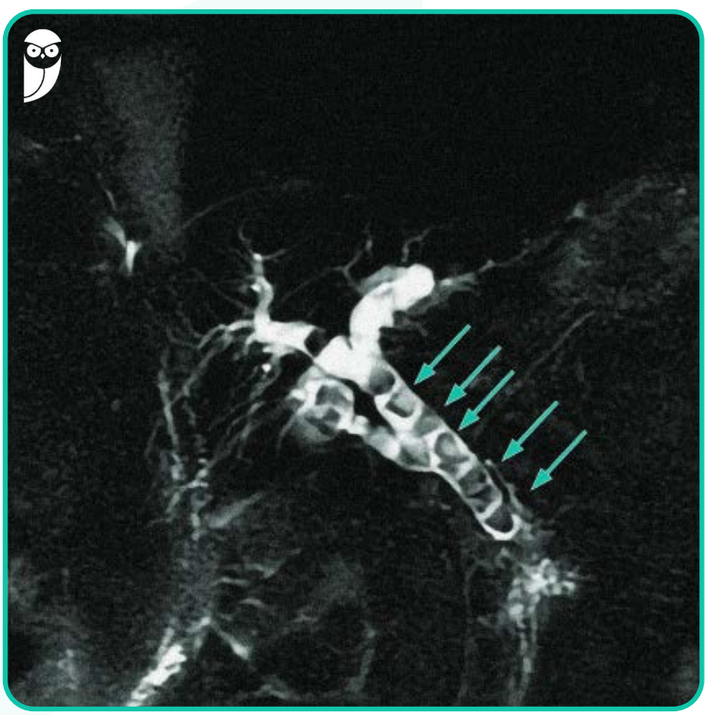
Colédoco dilatado.
Fonte: Prova de acesso direto SES PE, 2020.

COLANGIORRESSONÂNCIA

É geralmente solicitada quando a ultrassonografia ou a tomografia computadorizada não fecham o diagnóstico. A colangiorressonância pode delinear claramente o ducto biliar sem o uso de contraste e **POSSUI MAIOR PRECISÃO DIAGNÓSTICA NA IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DA OBSTRUÇÃO BILIAR** quando comparada à TC e à ultrassonografia. É um exame que oferece **excelente acurácia diagnóstica**, com sensibilidade e especificidade de 87% e 92%, respectivamente, mas tem baixa disponibilidade na maioria dos serviços e não possibilita o tratamento, como a CPRE.



Coledocolitíase.



Múltiplos cálculos na via biliar.
Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

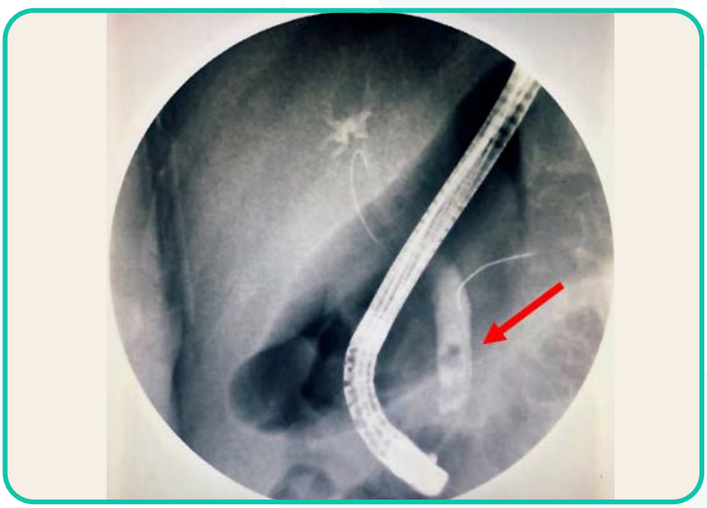
ECOENDOSCOPIA – ULTRASSOM ENDOSCÓPICO

A ecoendoscopia tem excelente acurácia para o diagnóstico de coledocolitíase. Apresenta sensibilidade e especificidade de 97% e 90%, respectivamente. Em relação à colangiorressonância, tem a vantagem de identificar melhor cálculos pequenos (< 6 mm), mas também é um exame pouco disponível.

COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE)

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) utiliza a endoscopia e a fluoroscopia para injetar contraste por meio da ampola de Vater. É um exame **diagnóstico e terapêutico** para realizar a drenagem da via biliar e retirada de cálculos, geralmente realizada após confirmação diagnóstica da colangite por meio de exames de imagem (ultrassom, tomografia, colangiorressônancia).

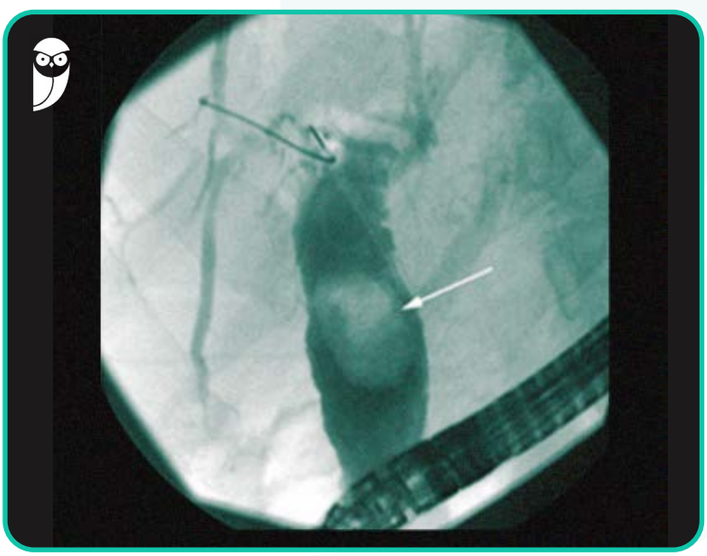
Não se esqueça de que a CPRE é um exame invasivo e apresenta complicações, como pancreatite aguda (mais comum), colangite, perfuração duodenal e sangramento quando a esfincterotomia é realizada (hemorragia digestiva alta exteriorizada por hematêmese e/ou melena).



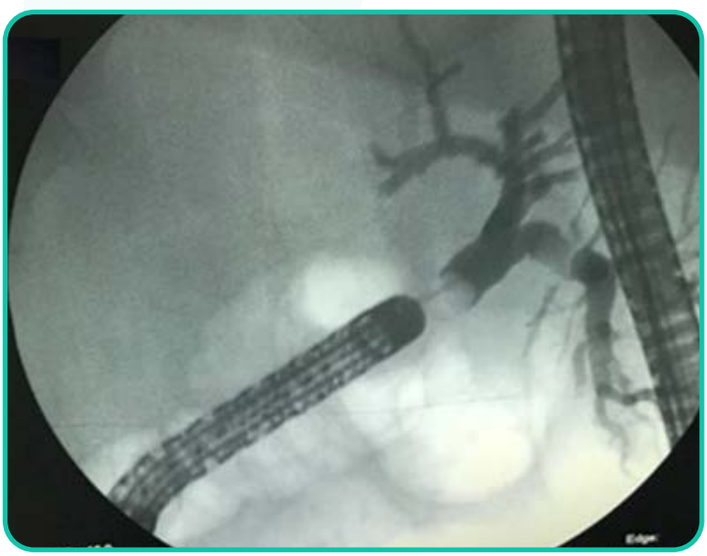
Coledocolitíase.
Fonte: *Shutterstock.*



Via biliar dilatada com múltiplos cálculos.
Fonte: Prova de acesso direto SURCE 2017.



Cálculo grande em colédoco com importante dilatação da via biliar.
Fonte: imagem adaptada do Uptodate.



Coledocolitíase e dilatação da via biliar: imagem do “cálice invertido”.
Fonte: acervo pessoal.

CAI NA PROVA

(IAMSPE 2020) Paciente de 90 anos, com quadro de dor discreta em hipocôndrio direito, associada à febre e calafrio, nega história prévia. Ao exame físico, bom estado geral, apresenta sinais de sarcopênica, pulso e pressão arterial normais, icterícia 2 em 4+, sem massas palpáveis e discreto desconforto em epigástrio. Realizou um ultrassom em outro serviço que demostrou colelitíase. O melhor passo diagnóstico é:

A) Ressonância com Colangio.
B) Tomografia.
C) Colangio endoscópica.
D) Colangio transparieto hepática.
E) Cintilografia com DISIDA.

COMENTÁRIOS

Temos uma paciente de 90 anos com dor em hipocôndrio direito, febre, calafrios, icterícia e diagnóstico de colelitíase confirmado por ultrassonografia. Qual é nossa principal hipótese para o caso?

Dor em hipocôndrio direito + febre + icterícia = TRÍADE DE CHARCOT = COLANGITE AGUDA! No caso em questão, a principal causa da colangite seria uma coledocolitíase, já que a paciente tem colelitíase. E qual seria o melhor exame diagnóstico? Não se esqueça de que nossa paciente tem 90 anos, e temos que optar pelo exame menos invasivo!

Correta alternativa A. A colangiorressonância pode delinear claramente o ducto biliar sem o uso de contraste e possui maior precisão diagnóstica na identificação da causa da obstrução biliar em comparação com a tomografia e a ultrassonografia abdominal. Apesar de ser o exame que oferece melhor acurácia diagnóstica, não possibilita o tratamento como a CPRE.

Incorreta alternativa B: a tomografia tem alta sensibilidade para identificar a dilatação do ducto biliar e pode identificar estenose biliar (por exemplo, carcinoma biliar, câncer de pâncreas ou colangite esclerosante), mas tem baixa sensibilidade para cálculos do ducto biliar (25% a 90%). Como o autor quer o melhor exame, ficamos com a colangiorressonância, que pode ser realizada sem o uso de contraste!
Incorreta alternativa C: a colangio endoscópica (CPRE) é um exame diagnóstico e terapêutico para realizar a drenagem da via biliar e retirada de cálculos, geralmente realizada após confirmação diagnóstica da colangite por meio de exames de imagem (ultrassonografia, tomografia, colangiorressônancia). Mas, não deixa de ser um exame invasivo, que necessita de sedação, uso de contraste, e, em uma paciente de 90 anos, que não apresenta sinais de sepse (está em bom estado geral, com pulso e pressão arterial normais), o ideal é confirmar o diagnóstico da colangite com exames menos invasivos. Já que a ultrassonografia não confirmou a dilatação da via biliar e a coledocolitíase, e o autor pede-nos o MELHOR exame para diagnóstico, esse seria a colangiorressonância.
Incorreta alternativa D: a colangio transparieto hepática guiada por ultrassonografia, assim como a CPRE, possibilita o diagnóstico e a drenagem da via biliar obstruída, mas necessita de dilatação confirmada da via biliar intra-hepática e pode apresentar complicações, como sangramento e vazamento de bile para a cavidade abdominal.
Incorreta alternativa E: a cintilografia hepatobiliar é um exame de imagem que avalia a função hepatocelular e a permeabilidade do sistema biliar, seguindo a produção e o fluxo da bile por meio do fígado e da árvore biliar, até o intestino delgado. Essa visualização é conseguida por meio da aquisição de imagens dinâmicas sequenciais após a injeção do radiofármaco (HIDA ou DISIDA) marcado com Tc 99m. É o exame padrão-ouro para o diagnóstico de colecistite aguda, não da colangite.

(IAMSPE 2018) Paciente, 82 anos, com quadro de rebaixamento do nível de consciência associado à febre e a desconforto abdominal há 48 horas. Ao exame físico, apresenta-se ictérico +++, taquicárdico (110 bpm) e sonolento. Dor discreta no andar superior do abdome. Nega cirurgia prévia, porém relata ser portador de hipertensão arterial e gota. Face ao exposto, é CORRETO afirmar que:

A) O exame de imagem a ser indicado deve ser uma colangiorressonância.
B) Os exames laboratoriais, como hemograma e proteína C-reativa, não mudarão substancialmente a conduta médica.
C) A tomografia é obrigatória, pois tem melhor sensibilidade que a ultrassonografia.
D) O exame de ultrassonografia pode ser único e conclusivo para orientação terapêutica.
E) A antibioticoterapia deve ter espectro especialmente dos germes Gram-positivos.

COMENTÁRIOS

Essa questão é bem semelhante à anterior. Coloquei-a aqui propositalmente, para raciocinarmos juntos a indicação de cada exame de imagem.

Trata-se de um paciente idoso com a tríade de Charcot e rebaixamento do nível de consciência. Caso a hipotensão também fosse descrita no quadro acima, ele teria completado os elementos da pêntade de Reynolds, que caracteriza o choque séptico associado à obstrução de via biliar.

Incorreta a alternativa A: a colangiorressonância é o exame de maior sensibilidade e especificidade para diagnóstico de cálculos na via biliar, no entanto sua aplicação fica reservada aos casos em que outros métodos, como o ultrassom ou a tomografia, foram incapazes de firmar o diagnóstico ou estavam contraindicados.

Incorreta a alternativa B: não considero essa alternativa totalmente incorreta. Realmente, diante de um paciente com um quadro séptico por provável colangite aguda, principalmente em pacientes idosos, que têm a resposta imune diminuída, independentemente dos exames laboratoriais, a conduta será realizar um exame de imagem que confirme o diagnóstico e proceder com a drenagem da via biliar. Mas, você verá daqui a pouco que leucocitose e aumento da PCR fazem parte dos critérios diagnósticos das "Diretrizes de Tokyo". Talvez por isso, essa alternativa tenha sido considerada incorreta.

Incorreta a alternativa C: a tomografia não é obrigatória, e sua sensibilidade é alta para identificação de dilatação da via biliar e baixa para identificar cálculos no ducto biliar. A ultrassonografia é o primeiro exame de imagem a ser realizado frente a um quadro de obstrução de via biliar, principalmente em um idoso já com sinais sistêmicos de sepse.

Correta a alternativa D. Além dos dados clínicos e laboratoriais, basta uma ultrassonografia evidenciando obstrução da via biliar para orientação terapêutica. O próximo passo será a CPRE para drenagem da via biliar.

Incorreta a alternativa E: a antibioticoterapia nos quadros de colangite deve ter amplo espectro, com cobertura para Gram-positivos, Gram-negativos e anaeróbios.

São exemplos de esquemas de primeira escolha a piperacilina com tazobactam ou ceftriaxona associada a metronidazol.

2.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

COLECISTITE AGUDA

Pacientes com colecistite aguda podem apresentar febre e dor abdominal. No entanto, eles não têm bilirrubina ou fosfatase alcalina significativamente elevadas, a menos que haja um processo secundário que cause colestase. A dor da colecistite aguda é mais forte e constante, apresenta sensibilidade abdominal e sinal de Murphy positivo. Além disso, a imagem abdominal na colecistite aguda geralmente revela um ducto biliar comum normal, espessamento da parede da vesícula biliar e um sinal ultrassonográfico de Murphy.

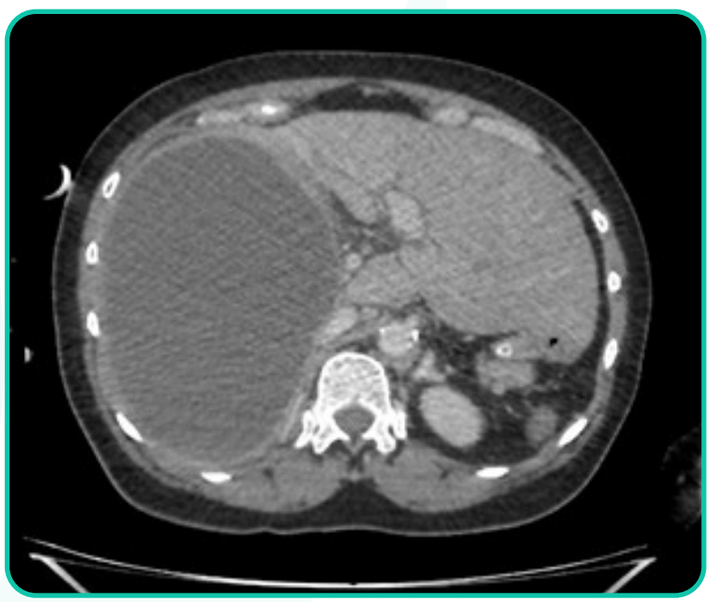
PANCREATITE AGUDA

A dor típica da pancreatite é epigástrica, aguda e de forte intensidade, geralmente associada a vômitos. Há um aumento da amilase e lipase séricas três vezes ou mais que o limite superior do normal, além de um aumento focal ou difuso do pâncreas visto na tomografia.

É possível que pacientes apresentem concomitantemente colangite e pancreatite aguda. Nesses casos, a prioridade é drenar a via biliar, ou seja, o tratamento por meio da CPRE deve ser urgente.

ABSCESSO HEPÁTICO

A infecção biliar (colecistite, colangite) é o principal fator predisponente para a formação de abscesso hepático e está presente em 40% a 60% dos casos. As manifestações clínicas típicas do abscesso hepático são febre, presente em 90% dos casos, e dor abdominal. Outros sintomas comuns incluem náusea, vômito, anorexia, perda de peso e mal-estar. A ultrassonografia e a tomografia podem diferenciar um abscesso hepático de uma colangite aguda.



Abscesso hepático.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

2.7 DIRETRIZES DE TOKYO

Meu querido aluno, apesar das provas cobrarem as Diretrizes de Tokyo principalmente em questões referentes à “colecistite aguda”, não podemos esquecer que as diretrizes também estabelecem tanto critérios para diagnosticar quanto para classificar a gravidade da colangite aguda.



CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO TG18/TG13 PARA COLANGITE AGUDA

A. Inflamação sistêmica

1. Febre (> 38°) e/ou calafrios; e
2. Dados laboratoriais: evidência de resposta inflamatória:
   - ✓ Contagem anormal dos leucócitos: < 4 ou > 10 x 1.000 / µL;
   - ✓ Aumento PCR ≥ 1 mg/dL; e
   - ✓ Outras alterações indicando inflamação.

B. Colestase

1. Icterícia (Bilirrubina ≥2 mg / dL); e
2. Dados laboratoriais: testes de função hepática anormais (FA, GGT, TGO ou TGP > 1,5 vezes o limite superior do normal).

C. Imagem

1. Dilatação biliar; e
2. Evidência da etiologia na imagem (estenose, cálculo, *stent* etc.).

Diagnóstico suspeito: um item em A + um item em B ou C.

Reparem que, para um diagnóstico definitivo de colangite aguda, é necessário ter a inflamação sistêmica, exame laboratorial com colestase e confirmação por meio do exame de imagem, que pode ser uma ultrassonografia, tomografia, colangiorressonância, ecoendoscopia ou até mesmo CPRE.

2.7.1 GRAVIDADE

Os critérios de classificação de gravidade do TG18 para a colangite aguda são importantes para prever prognóstico e determinar uma estratégia de tratamento, especialmente para identificar pacientes que necessitam de drenagem da via biliar precoce. Os critérios permitem a avaliação com base em sinais e sintomas clínicos, e exames laboratoriais de rotina, que podem ser realizados e fornecer resultados rapidamente, são minimamente invasivos para o paciente e têm baixo custo. As taxas de mortalidade para pacientes com colangite aguda grave são de aproximadamente 20% a 30%.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE DO TG18/TG13 PARA COLANGITE AGUDA

Colangite aguda grau III (grave): associada ao aparecimento de disfunção, pelo menos em qualquer um dos seguintes órgãos/sistemas:

1. Disfunção cardiovascular: hipotensão requerendo dopamina ≥ 5 µg/kg por minuto ou qualquer dose de noradrenalina;
2. Disfunção neurológica: perturbação da consciência;
3. Disfunção respiratória: relação PaO2 / FiO 2 < 300;
4. Disfunção renal: oligúria, creatinina sérica > 2,0 mg / dl;
5. Disfunção hepática: PT - INR > 1,5; e
6. Disfunção hematológica: contagem de plaquetas < 100.000 / mm^3.

Colangite aguda grau II (moderada): associada a duas das seguintes condições:

1. Contagem de leucócitos anormais (> 12.000 / mm^3, < 4.000/mm^3);
2. Febre alta (≥ 39 ° C);
3. Idade (≥ 75 anos);
4. Hiperbilirrubinemia (bilirrubina total ≥5 mg/dl); e
5. Hipoalbuminemia (< DST* a × 0,7).

Colangite aguda grau I (leve): a colangite aguda "grau I" não atende aos critérios de colangite aguda "grau III (grave)" ou "grau II (moderado)" no diagnóstico inicial.

*DST: Limite inferior do valor normal.

2.8 TRATAMENTO

A colangite aguda deve ser tratada de acordo com sua gravidade. **O tratamento da colangite aguda baseia-se em medidas de suporte, antibioticoterapia endovenosa e drenagem da via biliar**. Uma vez confirmado o diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado imediatamente, e a gravidade deve ser avaliada de acordo com os critérios de classificação de gravidade para colangite e o *status* geral do paciente deve ser avaliado (ASA, ICC).

Se o hospital não estiver equipado para realizar drenagem biliar endoscópica ou trans-hepática percutânea ou prestar cuidados intensivos, os pacientes com colangite moderada ou grave devem ser transferidos.

2.8.1 MEDIDAS DE SUPORTE

- ✓ Jejum e hidratação intravenosa;
- ✓ Correção de distúrbios eletrolíticos;
- ✓ Controle da dor (usar com cautela os opioides, como a morfina, pois fazem contração do esfíncter de Oddi, aumentando a pressão no ducto biliar); e
- ✓ Monitoramento cuidadoso da pressão arterial, frequência cardíaca e diurese.

2.8.2 ANTIBIOTICOTERAPIA

A escolha dos antibióticos deve levar em consideração se a infecção é adquirida na comunidade ou hospitalar, bem como fatores de risco individuais para infecção por bactérias resistentes, como idade, imunossupressão e comorbidades. O espectro deve ser amplo e cobrir bactérias Gram-negativas, positivas e anaeróbios. É aconselhável colher hemocultura antes de iniciar os antibióticos.

2.8.3 DRENAGEM BILIAR

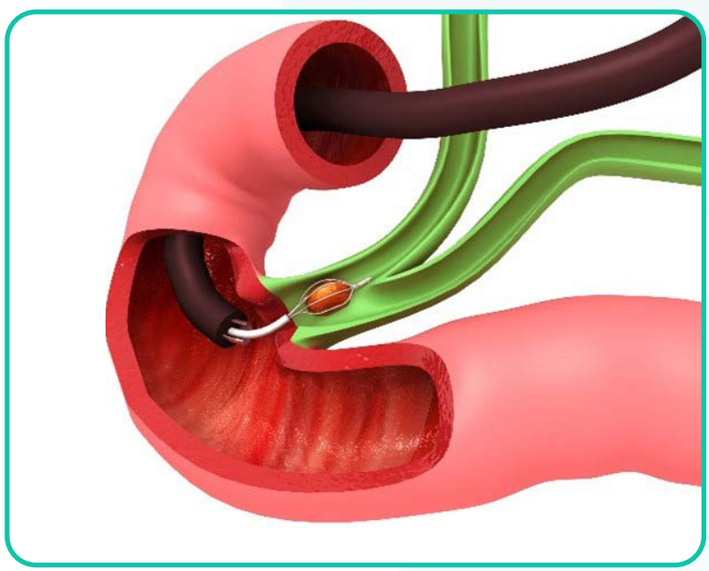
A drenagem da via biliar é primordial nos pacientes com colangite aguda, e geralmente é isso que é cobrado em provas. Geralmente as vias de drenagem são a endoscópica (CPRE), transparieto hepática e a via cirúrgica. Vamos falar um pouco de cada uma.

DRENAGEM ENDOSCÓPICA (CPRE)

Por ser um método de drenagem minimamente invasivo, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) com drenagem biliar transpapilar é o tratamento de escolha, **PADRÃO-OURO**, para a colangite aguda.



CPRE: extração de cálculo impactado no colédoco distal. Fonte: acervo pessoal.



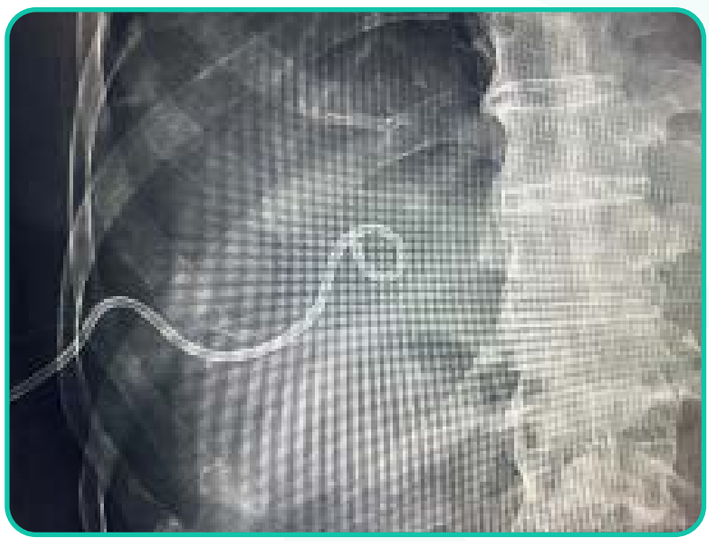
Extração de cálculo pela CPRE. Fonte: *Shutterstock.*

A CPRE com esfincterotomia apresenta taxa de 90% a 95% de sucesso na remoção de cálculos do ducto biliar, e também é possível a colocação de *stent* (dependendo da causa da obstrução). Para cálculos grandes, pode ser necessária a litotripsia para fragmentação antes da remoção. Não é aconselhável a esfincterotomia em pacientes com coagulopatia ou em uso de anticoagulantes.

Pode ser realizada uma dilatação do esfíncter de Oddi com balão, sem esfincterotomia, o que geralmente é o suficiente para retirar cálculos menores.

DRENAGEM TRANSPARIETO HEPÁTICA (DTPH)

A drenagem trans-hepática biliar percutânea, guiada por ultrassonografia, é realizada quando a drenagem endoscópica não está disponível ou é malsucedida ou inacessível (por exemplo, anastomose em Y de Roux ou ressecção de Whipple ou estreitamento duodenal). A colangiografia trans-hepática percutânea permite uma série de intervenções terapêuticas, incluindo drenagem da bile infectada, extração de cálculos do trato biliar, dilatação de estenoses benignas das vias biliares ou colocação de um *stent* em uma estenose maligna. No entanto, **requer dilatação da via biliar intra-hepática**, é mais invasiva em comparação com a CPRE e não deve ser realizada em pacientes com coagulopatias.



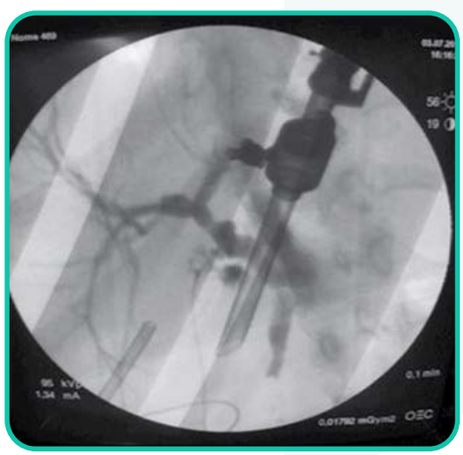
Drenagem trans-hepática percutânea
Fonte: *Shutterstock.*



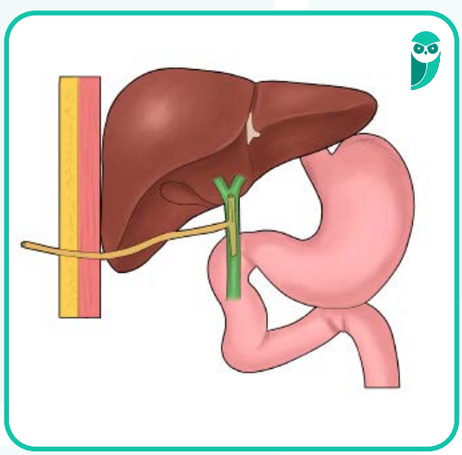
Prótese trans-hepática percutânea
Fonte: *Shutterstock.*

DRENAGEM CIRÚRGICA

Atualmente, a drenagem cirúrgica é extremamente rara devido ao amplo uso da drenagem endoscópica ou trans-hepática para o tratamento da colangite aguda. É mais mórbida, por isso reservada para pacientes nos quais outros métodos de drenagem biliar não podem ser realizados ou falharam. Para pacientes com colangite aguda devido a um cálculo obstrutivo, a descompressão biliar pode ser realizada com exploração aberta ou laparoscópica do ducto biliar comum, com remoção da coledocolitíase. Dentre as opções cirúrgicas, temos:



A- Colangiografia intraoperatória: obstrução distal (cálice invertido). Fonte: Prova de acesso direto FAMEMA, 2019.



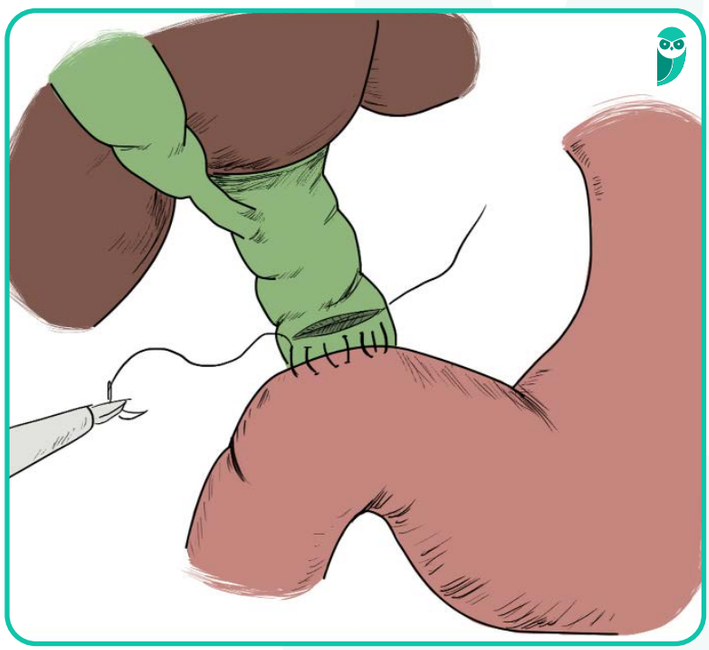
B- Coledocotomia e colocação do dreno de Kehr.



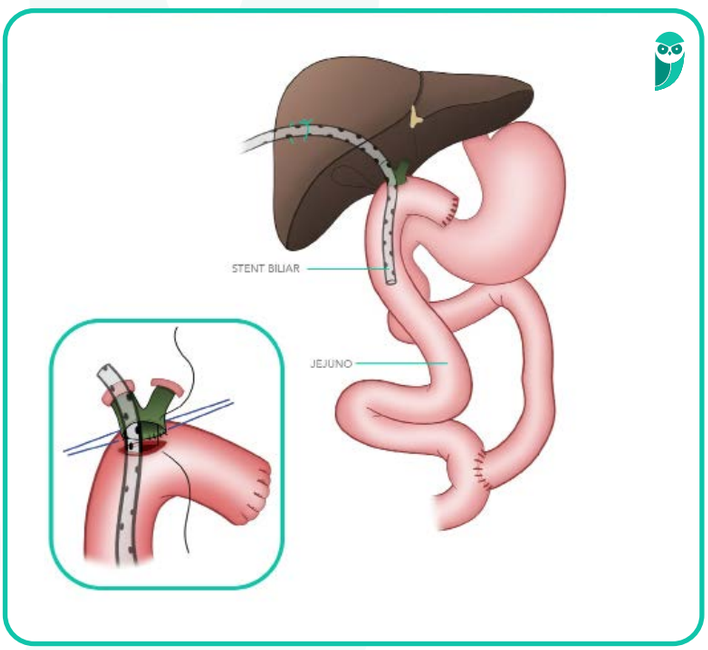
C- Colangiografia após retirada do cálculo e drenagem com Kehr. Fonte: *Shutterstock.*

- ✓ Coledocotomia e colocação de um tubo T (dreno de Kehr), com ou sem a retirada do cálculo (a depender das condições clínicas do paciente);
- ✓ Duodenotomia e esfincteroplastia com retirada do cálculo (geralmente em via biliar pouco dilatada e com cálculo impactado na ampola de Vater, que não sai por coledocotomia); e
- ✓ Derivação bileodigestiva: na presença de via biliar dilatada (> 2 cm) e/ou com múltiplos cálculos. Após a retirada do cálculo, pode ser realizada uma hepatoduodenostomia latero-lateral ou uma hepatojejunostomia em Y de Roux. A hepatoduodenostomia tem a vantagem de realizar uma única anastomose e ter acesso endoscópico posteriormente, mas o ducto distal à anastomose pode não drenar bem e coletar debris e restos alimentares provenientes do duodeno, que obstruem a anastomose ou ducto pancreático (pode causar pancreatite) e causar colangite recorrente, processo conhecido como "síndrome de Sump". Já a hepatojejunoanastomose tem menor risco de refluxo e colangite, mas fica inacessível ao endoscópico.

HEPATODUODENOANASTOMOSE



HEPATOJEJUNOANASTOMOSE



Em pacientes hemodinamicamente estáveis, uma colecistectomia e a retirada do cálculo obstrutivo podem ser realizadas ao mesmo tempo. Para pacientes graves, instáveis, devemos realizar apenas a drenagem da via biliar por meio de coledocotomia e colocação de um dreno de Kehr.

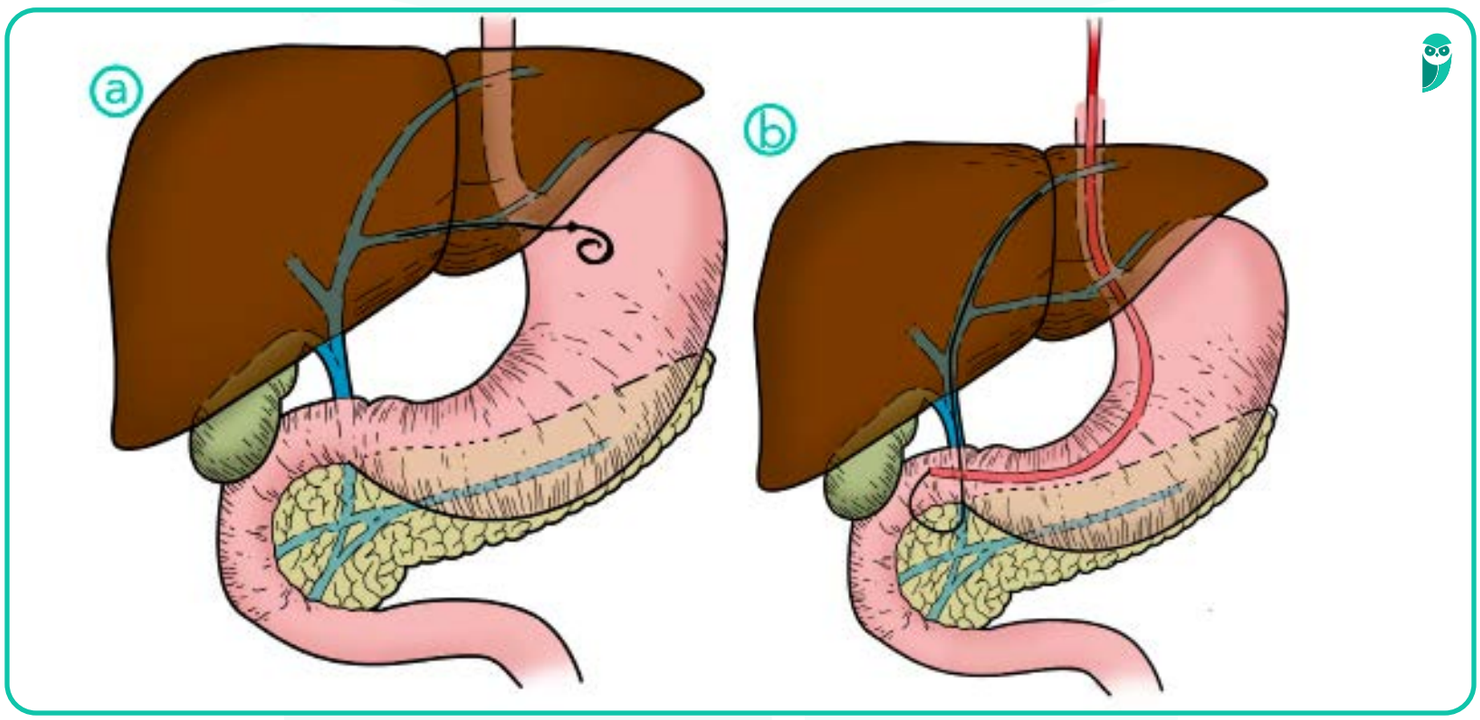
Nessa imagem, a colangiografia foi realizada pelo dreno de Kerh em um pós-operatório de colecistectomia com drenagem cirúrgica da via biliar. Repare que o contraste passa para o duodeno, mas há uma falha de enchimento no colédoco distal. Provavelmente o paciente estava instável hemodinamicamente e não foi realizada a exploração da via biliar para retirada do cálculo. Nesses casos, a conduta é realizar a CPRE para extração do cálculo.



Colangiografia – falha de enchimento em colédoco distal, com boa passagem do contraste para o duodeno. Fonte: Prova de acesso direto SUS SP, 2020.

DRENAGEM POR ECOENDOSCOPIA

Não costuma ser cobrada em prova, mas outra alternativa para o tratamento da colangite é a colangiopancreatografia guiada por ultrassom endoscópico com drenagem biliar e colocação de *stent*. Indicada em pacientes com alto risco de complicações com a CPRE ou DTPH, ou quando elas falham, e na impossibilidade de acesso endoscópico devido à anatomia cirúrgica alterada (ex.: Y de Roux) ou obstrução de tumores duodenais e ampulares.



Drenagem da via biliar por ecoendoscopia.
a) hepatogastrostomia; e b) coledocoduodenostomia.



Opções para drenagem da via biliar em pacientes gastrectomizados, com reconstrução em Y de Roux, sem acesso à endoscopia convencional:

- ✓ Enteroscopia por meio da alça aferente do Y para ter-se acesso à papila duodenal (tecnicamente difícil, realizada somente por endoscopistas especializados);
- ✓ Drenagem trans-hepática; e
- ✓ Drenagem por ultrassom endoscópico.

Segundo as diretrizes de Tokyo 2018, o momento da drenagem biliar depende da gravidade da doença:

Colangite grau I (leve): na maioria dos casos, o tratamento inicial incluindo antibióticos é suficiente e a maioria dos pacientes não necessita de drenagem biliar. No entanto, a drenagem biliar deve ser considerada se um paciente não responder ao tratamento inicial nas 24 horas iniciais.

Colangite grau II (moderada): é indicada uma drenagem biliar endoscópica (CPRE) ou percutânea trans-hepática precoce.

Colangite grau III (grave – supurativa): é indicada uma drenagem biliar endoscópica (CPRE) ou percutânea trans-hepática **URGENTE** (dentro de 24 horas). Melhorar a condição do paciente com tratamento inicial e controle respiratório/circulatório para a drenagem.

Se for necessário tratamento para a etiologia subjacente, esse deve ser realizado após resolução da colangite aguda e melhora do estado geral do paciente.

TRATAMENTO DA CAUSA

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica com esfincterotomia endoscópica pode ser efetiva para extração dos cálculos, podendo evitar um procedimento aberto inicial, mas cerca de 50% dos pacientes podem ter recidiva se não tratados também com colecistectomia. Essa deve ser realizada preferencialmente na mesma internação hospitalar.

Posteriormente à resolução da colangite, em pacientes com obstrução biliar maligna, as opções cirúrgicas incluem: ressecção (por exemplo, ressecção de Whipple ou ducto biliar), derivação bileodigestiva e drenagem do ducto.

RESUMINDO

Cálculos biliares: colecistectomia eletiva, preferencialmente na mesma internação, após a resolução da colangite, para evitar recorrência.

Estenose biliar benigna, lesão iatrogênica do ducto biliar: terapia endoscópica ou reparo cirúrgico.

Estenoses maligna: ressecção, bileodigestiva e colocação de *stent*.

CAI NA PROVA

(ABC 2020) Mulher, 75 anos, diabética, portadora de hipertensão arterial sistêmica, dislipidêmica, deu entrada no Pronto Atendimento com dor abdominal intensa. Ao exame físico: corada, desidratada ++/4, dispneica +/4, febril, ictérica ++/4, acianótica, dor abdominal difusa no abdome, descompressão brusca (DB) ausente. Tomografia computadorizada revela cálculos na vesícula e dilatação de vias biliares intra e extra-hepática, com possível cálculo em colédoco distal. Após exames laboratoriais, feito diagnóstico de pancreatite de causa biliar. Qual a conduta preconizada?

A) Colecistectomia + coledocotomia emergencial para alívio da icterícia.
B) Tratamento clínico da pancreatite e posterior colecistectomia.
C) Tratamento clínico inicial, CPRE e posterior colecistectomia.
D) Colecistectomia e derivação biliodigestiva para alívio da icterícia.

COMENTÁRIOS

Caro aluno, temos uma paciente com vários diagnósticos!!! Além das comorbidades de base, que são a hipertensão arterial e a dislipidemia, ela tem o diagnóstico de colelitíase, que complicou com uma coledocolitíase e colangite aguda (tríade de Charcot: febre + dor + icterícia) confirmada pela tomografia, que evidenciou dilatação da via biliar e possível cálculo no colédoco distal. Os exames laboratoriais, provavelmente dosagem de amilase e lipase, confirmaram uma pancreatite biliar. E agora, o que tratar primeiro?

A maioria das pancreatites agudas biliares é leve, 85% a 90% dos casos, e o tratamento baseia-se no jejum, repouso, analgesia, antieméticos, hidratação e reposição dos eletrólitos. Mas, diante de um quadro de colangite aguda, é primordial a desobstrução da via biliar.

Incorreta a alternativa A: porque primeiro devemos tratar a pancreatite e a colangite desobstruindo a via biliar. A colecistectomia deverá ser feita após melhora clínica da pancreatite aguda. Uma coledocotomia de urgência só estaria indicada na presença de uma colangite em que não há disponibilidade de CPRE ou se houver insucesso na drenagem.
Incorreta a alternativa B: porque esse seria o tratamento da pancreatite isolada. Diante de uma colangite, é prioridade desobstruir a via biliar!

Correta a alternativa C: porque essa é a sequência correta do tratamento da nossa paciente. Iniciar o tratamento clínico com jejum, reposição volêmica, antibioticoterapia, depois a CPRE para o tratamento da colangite e, após melhora do quadro agudo da pancreatite e resolução da colangite, programar a colecistectomia videolaparoscópica.

Incorreta a alternativa D: a primeira opção para a desobstrução da via biliar é endoscópica, ou seja, por CPRE, e, no insucesso dessa, temos opções como a drenagem trans-hepática percutânea (DTPH) e drenagem por ultrassom endoscópico. A abordagem cirúrgica é a última opção, por apresentar maior morbidade. Uma derivação bileodigestiva (hepatoduodenostomia ou hepatojejunostomia em Y de Roux) pode ser bem-sucedida na presença de uma via biliar muito dilatada (> 2 cm) ou na presença de múltiplos cálculos e só deve ser realizada estando estável o paciente.

(IAMSPE 2019) Paciente de 82 anos, com quadro de dor epigástrica, febre, sonolência, calafrio e sudorese chega ao pronto-socorro. Ao exame físico, apresenta-se ictérico 3 em 4+, com vesícula biliar palpável não dolorosa. Foi iniciada a antibioterapia e solicitada sua avaliação. A conduta correta é

A) drenagem percutânea da via biliar imediata, se houver dilatação da via biliar intra-hepática.
B) drenagem endoscópica da via biliar após 48 horas de antibioticoterapia, que deve ser feita se confirmada dilatação das vias biliares.
C) drenagem endoscópica da via biliar, que deve ser feita imediatamente mesmo sem exame de imagem.
D) colecistectomia primordial e deve ser feita em 48 horas.
E) drenagem endoscópica da via biliar, que só deve ser indicada após exame de imagem e, caso não aja resposta terapêutica, com antibioticoterapia iniciada.

COMENTÁRIOS

Temos um paciente idoso, com dor epigástrica, febre, sonolência (alteração do nível de consciência), calafrio e sudorese. No exame físico, chama a atenção icterícia importante (3+/4+) e vesícula biliar palpável não dolorosa (sinal de Courvoisier). Com esses dados, temos dois possíveis diagnósticos: uma colangite aguda (tríade de Charcot: dor, febre e icterícia) em uma obstrução da via biliar por uma neoplasia periampular.

Segundo as Diretrizes de Tokyo, o diagnóstico deve ser confirmado com um exame de imagem (ultrassom, tomografia ou colangiorressonância), e o tratamento vai de acordo com a gravidade da colangite.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE DO TG18/TG13 PARA COLANGITE AGUDA

Colangite aguda grau III (grave): associada ao aparecimento de disfunção, pelo menos em qualquer um dos seguintes órgãos/sistemas:

1. Disfunção cardiovascular: hipotensão requerendo dopamina ≥ 5 µg/kg por minuto ou qualquer dose de noradrenalina;
2. Disfunção neurológica: perturbação da consciência;
3. Disfunção respiratória: relação PaO2 / FiO 2 < 300;
4. Disfunção renal: oligúria, creatinina sérica > 2,0 mg / dl;
5. Disfunção hepática: PT - INR > 1,5; e
6. Disfunção hematológica: contagem de plaquetas < 100.000 / mm³.

Colangite aguda grau II (moderada): associada a duas das seguintes condições:

1. Contagem de leucócitos anormais (> 12.000 / mm³, < 4.000/mm³);
2. Febre alta (≥ 39 ° C);
3. Idade (≥ 75 anos);
4. Hiperbilirrubinemia (bilirrubina total ≥5 mg/dl); e
5. Hipoalbuminemia (< DST* a × 0,7).

Colangite aguda grau I (leve): a colangite aguda "grau I" não atende aos critérios de colangite aguda "grau III (grave)" ou "grau II (moderado)" no diagnóstico inicial.

*DST: Limite inferior do valor normal.

Nosso paciente é classificado como Tokyo III, por apresentar disfunção neurológica. A conduta nesses casos é, além do suporte e antibioticoterapia inicial, drenagem da via biliar com urgência. Agora vamos às alternativas:

Correta a alternativa A: porque pacientes com colangite grave (supurativa), Tokyo III, requerem descompressão biliar urgente (dentro de 24 horas). O diagnóstico deve ser confirmado com um exame de imagem, e a drenagem endoscópica ou drenagem biliar trans-hepática percutânea (DTPH) deve ser realizada o mais rápido possível. Lembrando que para realizar a CTPH é necessário que haja dilatação da via biliar intra-hepática.

Incorreta a alternativa B: pode ser feita a CPRE após confirmar a dilatação da via biliar, mas isso deve ser urgente, dentro de 24 horas, e não 48 horas. E, pensando em uma possível neoplasia periampular, pode haver maior dificuldade técnica na CPRE comparada à drenagem trans-hepática.
Incorreta a alternativa C: segundo Tokyo Guidelines de 2018 (TG18), é necessário um exame de imagem evidenciando dilatação biliar ou evidência da etiologia na imagem (estenose, litíase, stent) para o diagnóstico de colangite.
Incorreta a alternativa D: a drenagem da via biliar é primordial frente a uma colangite Tokyo III. Nem sabemos se o paciente apresenta litíase vesicular. Se for confirmada colelitíase nos exames de imagem, a colecistectomia deverá ser feita na mesma internação após melhora clínica da colangite.
Incorreta a alternativa E: essa é a conduta nos casos de colangite leve Tokyo I, que pode ser tratada com antibioticoterapia, e, se não apresentar melhora ou houver piora em 24 horas, a via biliar deverá ser drenada.

(IAMSPE 2018) Paciente, 82 anos, com quadro de rebaixamento do nível de consciência, associado à febre e a desconforto abdominal há 48 horas. Ao exame físico apresenta-se ictérico +++ taquicárdico 110 bpm; sonolento. Dor discreta no andar superior do abdome. Nega cirurgia prévia, porém relata ser portador de hipertensão arterial e gota. Para esse paciente, a drenagem da via biliar por endoscopia de urgência (nas primeiras 12 horas), terá indicação somente se:

A) Houver piora, apesar do tratamento clínico.
B) A bilirrubina for maior que 15 mg/dl.
C) Houver dilatação da via biliar ao ultrassom.
D) A causa for identificada ao exame de imagem.
E) Os marcadores tumorais (Ca 19.9) forem normais.

COMENTÁRIOS

Essas duas últimas questões são do IASMPE, de anos diferentes, mas o paciente é praticamente o mesmo! Para você ver como repetem-se as questões. Se você quer passar na Residência de uma determinada instituição, faça todas as provas dela!!!

Esse paciente tem um provável diagnóstico de uma colangite (ele ainda não tem exame de imagem, por isso é "provável") e já apresenta disfunção neurológica (Tokyo III). Diferente do paciente anterior, ele não tem o sinal de Courvoisier, então é possível que a obstrução seja por cálculo, e a melhor via de drenagem é por endoscopia, ou seja, CPRE.

Incorreta a alternativa A: essa é a conduta na colangite leve, Tokyo I, quando não há resposta à antibioticoterapia inicial.
Incorreta a alternativa B: os níveis de bilirrubina não constituem um critério para definir urgência na drenagem em pacientes com colangite.

Correta a alternativa C. Nosso paciente tem clínica de colangite (tríade de Charcot), mas é necessário confirmar o diagnóstico com exame de imagem, que pode ser uma ultrassonografia, antes de realizar a drenagem endoscópica (CPRE). Nesse paciente, a drenagem deverá ser feita com urgência, por tratar-se de uma colangite grave já com disfunção neurológica.

Incorreta a alternativa D: a causa da obstrução por vezes não pode ser identificada por meio da ultrassonografia ou tomografia. No entanto, a presença de sinais clínicos, associada à dilatação das vias biliares, é suficiente para o diagnóstico de colangite, independentemente da visualização do fator obstrutivo.

Incorreta a alternativa E: CA 19.9 é um marcador utilizado para auxiliar no diagnóstico de câncer das vias biliares. No entanto, trata-se de um marcador inespecífico e que se encontra aumentado em uma série de afecções benignas da via biliar, como nos quadros de colangite.

De qualquer modo, os níveis de CA 19.9 nada têm a ver com urgência para drenagem das vias biliares.

(UNICAMP 2018) Mulher, 31a, portadora de coledocolitíase, foi submetida à Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica + papilotomia e exploração das vias biliares, com retirada dos cálculos. Após retorno da sedação apresentou dor epigástrica intensa, sem melhora com medicação. Exame físico: consciente, ictérica 2+/4+, corada, hidratada, acianótica, PA = 110 x 75 mmHg; FC = 98 bpm; FR = 20 irpm. Abdome: plano, normotenso, dor a palpação profunda em epigastro, descompressão brusca negativa, digitopercussão indolor, sem visceromegalia. O diagnóstico a ser investigado é:

A) Perfuração duodenal.
B) Hepatite medicamentosa.
C) Lesão de colédoco.
D) Sepse de foco abdominal.

COMENTÁRIOS

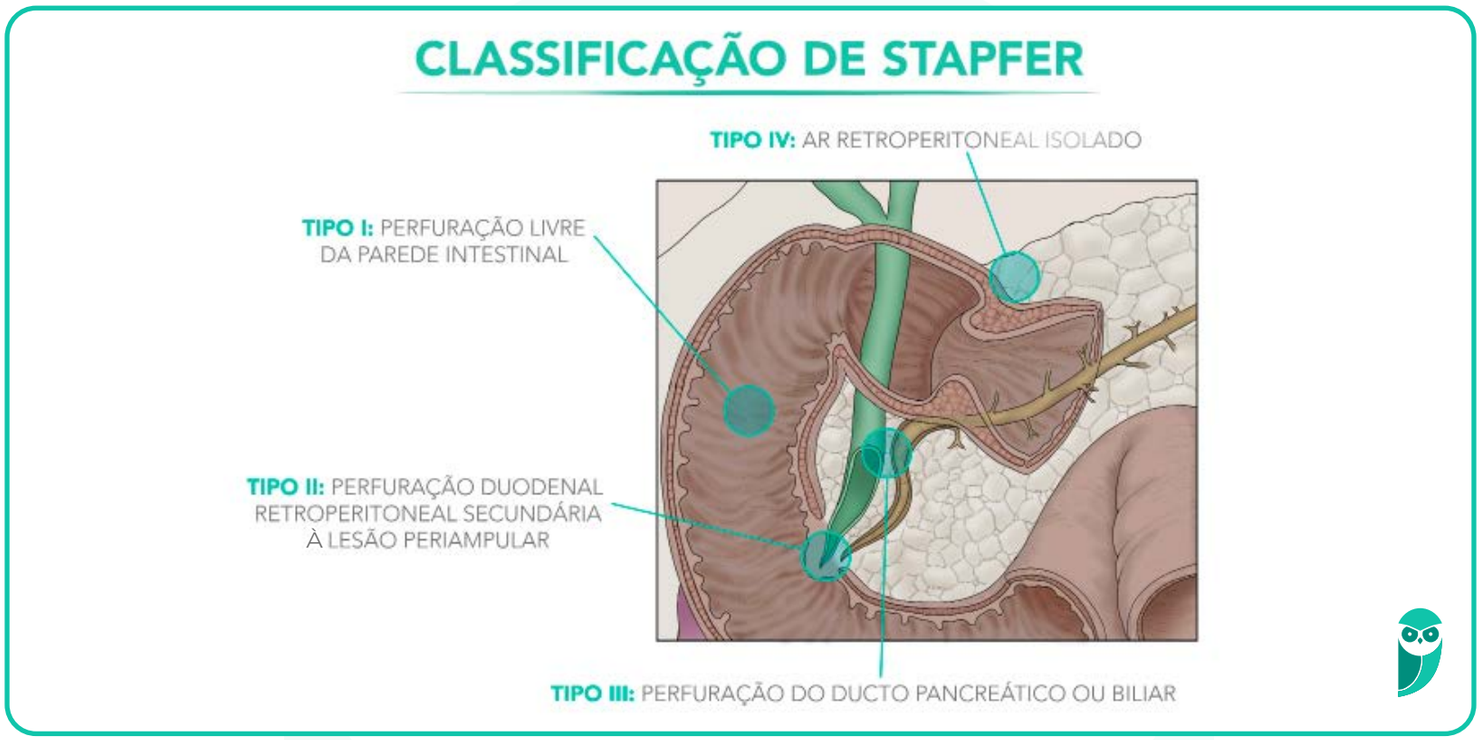
Temos uma paciente submetida à colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) e papilotomia, com retirada de cálculos, evoluindo com dor abdominal intensa. O abdome é doloroso em região epigástrica, mas sem sinais de peritonite.

As complicações mais comuns após a CPRE são a pancreatite aguda, perfuração duodenal e hemorragia digestiva alta (hematêmese e/ou melena).

O tratamento da pancreatite aguda na maioria dos casos é clínico, com jejum, hidratação endovenosa e analgesia. Em relação à perfuração duodenal, precisa operar? Para isso, existe a Classificação de Stapfer para perfuração duodenal pós-CPRE, que é baseada no mecanismo de localização anatômica e gravidade da lesão, que pode predizer a necessidade de intervenção cirúrgica. Você verá essa classificação no livro de "Vesícula e vias biliares", mas vou colocá-la aqui para que entenda melhor.

- ✓ Tipo I: perfuração livre da parede intestinal;
- ✓ Tipo II: perfuração duodenal retroperitoneal secundária à lesão periampular;
- ✓ Tipo III: perfuração do ducto pancreático ou biliar; e
- ✓ Tipo IV: ar retroperitoneal isolado.

O tipo II é a mais comum, geralmente após papilotomia.



O tratamento para todos os tipos de lesão inclui jejum, hidratação endovenosa, aspiração nasogástrica (SNG) e antibióticos endovenosos. Os pacientes que necessitem de repouso intestinal por uma semana devem receber nutrição parenteral. Perfurações livre para cavidade abdominal geralmente necessitam de tratamento cirúrgico de urgência. Já perfurações retroperitoneais, sem repercussões sistêmicas (provável caso do nosso paciente) podem ser tratadas clinicamente com as medidas descritas acima. Se o paciente não apresentar boa resposta clínica ou houver piora, deverá ser operado.

Correta a alternativa A. Perfuração duodenal é uma das possíveis complicações da CPRE, compatível com o quadro clínico apresentado pela nossa paciente. A ausência de peritonite é esperada inicialmente, pois o duodeno tem localização retroperitoneal. O diagnóstico pode ser confirmado por meio da tomografia de abdome, mediante a identificação do retro-pneumoperitônio.

Incorreta a alternativa B: hepatite não é uma complicação da CPRE. Além disso, não há relato de uso de qualquer medicação. Lembre-se de que a icterícia descrita é causada pela coledocolitíase que motivou a realização da CPRE.
Incorreta a alternativa C: não é comum ocorrer uma lesão do colédoco durante uma CPRE, o que cursaria com extravasamento de bile para a cavidade peritoneal, um coleperitônio, e consequente irritação peritoneal.
Incorreta a alternativa D: a paciente está consciente, estável hemodinamicamente (PA = 110 x 75 mmHg; FC = 98 bpm; FR = 20 irpm) e sem sinais de peritonite, ou seja, não há sinais de sepse.

2.9 COLANGITE PIOGÊNICA RECORRENTE

Por tratar-se de uma doença rara e pouco cobrada nos concursos de Residência, vamos fazer uma rápida revisão sobre as principais características dessa doença.

2.9.1 FISIOPATOLOGIA

A colangite piogênica recorrente é uma doença caracterizada pela formação de cálculos pigmentares marrons intrabiliares, resultando em estenose da árvore biliar e obstrução biliar com crises recorrentes de colangite. Os cálculos marrons são compostos de bilirrubinato de cálcio alternado por camadas de colesterol. É mais comumente encontrada nas populações do leste asiático.

A etiologia da colangite piogênica recorrente é desconhecida, mas, por ser mais frequente em regiões onde parasitas biliares, como *Clonorchis sinensis* (espécies *Opisthorchis* e *Fasciola hepatica*) e ***Ascaris lumbricoides***, são endêmicos, a parasitose biliar foi implicada na sua patogênese. Esses e outros patógenos secretam uma enzima que hidrolisa glucuronídeos de bilirrubina hidrossolúveis para formar bilirrubina livre, que então precipita para formar cálculos pigmentares marrons. Esses cálculos podem obstruir parcialmente ou completamente a árvore biliar, causando episódios recorrentes de colangite e eventualmente abscessos intra-hepáticos e/ou mesmo cirrose. A cronicidade da infecção e inflamação coloca esses pacientes sob risco de desenvolvimento de colangiocarcinoma. É incerto se o evento inicial é a infecção causando estenose inflamatória ou a estenose inflamatória causando a infecção subsequente da bile estagnada.

2.9.2 EPIDEMIOLOGIA

É encontrada quase exclusivamente nas populações do leste da Ásia. Ocorre com igual frequência em homens e mulheres, com prevalência máxima na terceira e quarta décadas de vida, embora também possa ser observada em pacientes com mais de 60 anos. É mais comum na população rural e em grupos socioeconômicos mais baixos, o que sugere que os fatores ambientais tenham um papel importante.

2.9.3 MANIFESTAÇÃO CLÍNICA E DIAGNÓSTICO

A apresentação clínica é de colangite com febre, dor no quadrante superior direito e icterícia. Devido à infecção, inflamação e aos cálculos, comumente presentes em um padrão segmentar ou lobar, a icterícia tende a ser leve. As características de apresentação mais comuns foram colangite (44%), dor abdominal sem colangite evidente (32%) e pancreatite (17%). A vesícula biliar está envolvida em aproximadamente 15% a 20% dos casos.

Os exames laboratoriais são similares aos de outras causas de colangite, com leucocitose e níveis elevados de bilirrubina e fosfatase alcalina. O diagnóstico geralmente é feito com uma tomografia ou colangiorressonância associada à CPRE. Atrofia lobar ou segmentar ou hipertrofia podem ser observadas em casos crônicos.

2.9.4 TRATAMENTO

Na vigência de um ataque agudo, o tratamento conservador com antibióticos parenterais, hidratação endovenosa e analgésicos geralmente é suficiente. Na falência dessa abordagem, com deterioração clínica, é mandatória a drenagem biliar via CPRE ou métodos percutâneos como a drenagem trans-hepática. Uma vez que a crise tenha cedido, uma completa investigação da anatomia da árvore biliar irá auxiliar no tratamento objetivo.

- ✓ A abordagem cirúrgica definitiva é quase sempre necessária. Os objetivos do tratamento cirúrgico são três:
- ✓ Remover todos os cálculos por CPRE ou colangiografia percutânea trans-hepática;
- ✓ *Bypass*, ampliar ou ressecar todas as estenoses; e
- ✓ Promover drenagem biliar adequada.

A presença de estenoses intra-hepáticas envolve um caso complicado que pode exigir ressecção, estenoseplastia ou jejunostomia hepaticocutânea. Quando a retirada de todos os cálculos não é possível, ou a necessidade futura de tratamento endoscópico é antecipada, o coto terminal da alça de Roux para uma hepaticojejunostomia pode ser exteriorizado na parede abdominal como um estoma para fornecer fácil acesso para coledocoscopia. Tendo em vista o risco de colangiocarcinoma, se a doença afetar predominantemente um lobo, esse deve ser ressecado em pacientes com reserva hepática adequada.

CAI NA PROVA

(AMRIGS 2019) Assinale a alternativa correta em relação à colangite piogênica.

A) Sua etiologia recorrente é desconhecida, mas está relacionada com cálculos de via biliar cuja composição é predominantemente de colesterol.
B) Há associação entre colangite piogênica primária com infecção por *Ascaris lumbricoides* e *Enterococcus faecium*.
C) A vesícula biliar só é comprometida em cerca de 20% dos casos.
D) Os sintomas e as manifestações da colangite piogênica recorrente estão comumente associados à icterícia acentuada e prurido.

COMENTÁRIOS

A colangite piogênica recorrente é uma doença rara do leste asiático, mas algumas bancas adoram cobrar essas raridades!!! Vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A: realmente, sua etiologia não é bem definida, mas os cálculos intrabiliares são pigmentares marrons, e não de colesterol. Esses são mais frequentes na litíase vesicular.
Incorreta a alternativa B: os parasitas mais frequentes implicados na patogênese da colangite piogênica são o Clonorchis sinensis (espécies Opisthorchis e Fasciola hepatica) e o Ascaris lumbricoides.

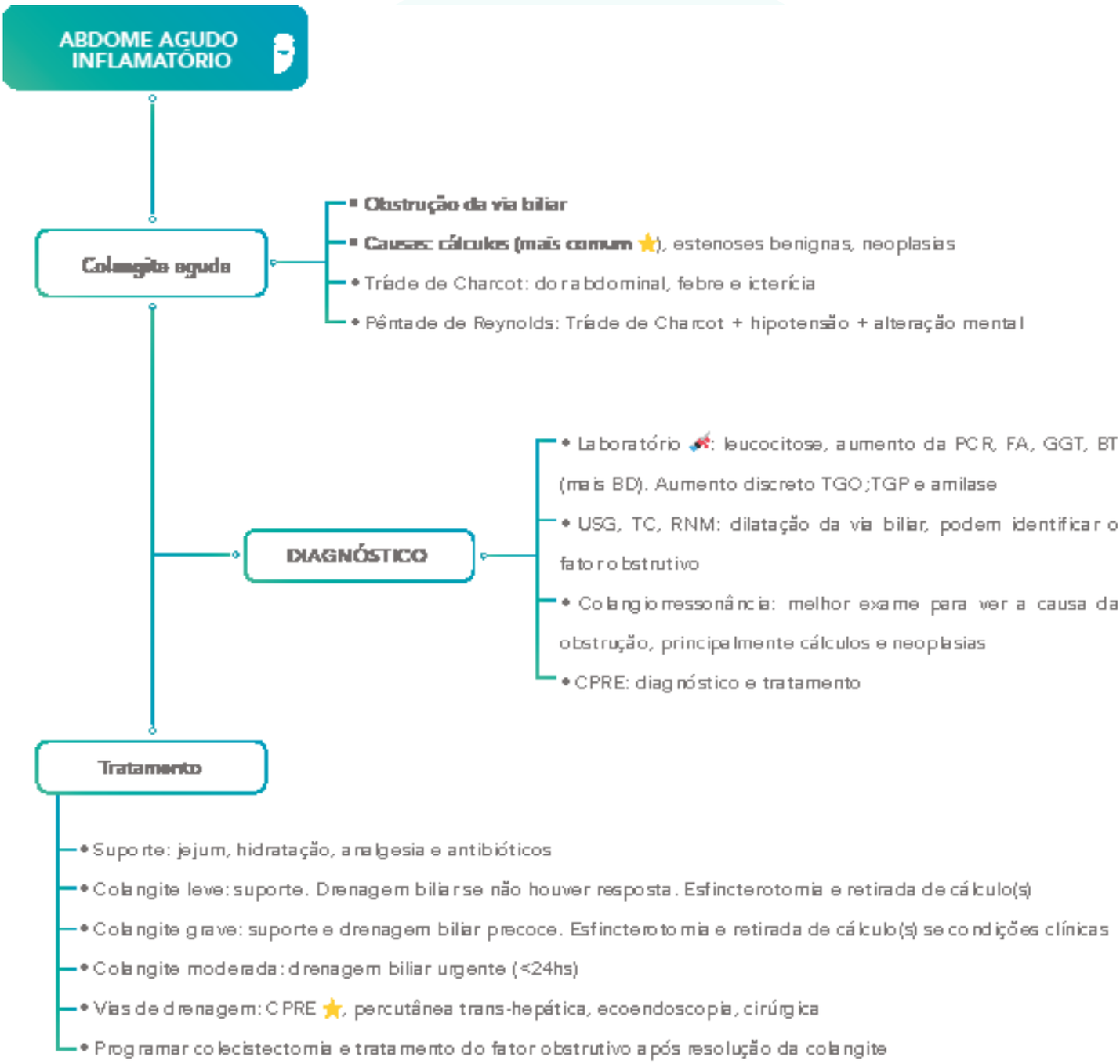
Correta a alternativa C. A vesícula biliar está acometida em 20% dos casos. A passagem de cálculos pode acarretar pancreatite aguda (17% dos casos).

Incorreta a alternativa D: geralmente, a icterícia é leve e não associada à prurido.

CAPÍTULO

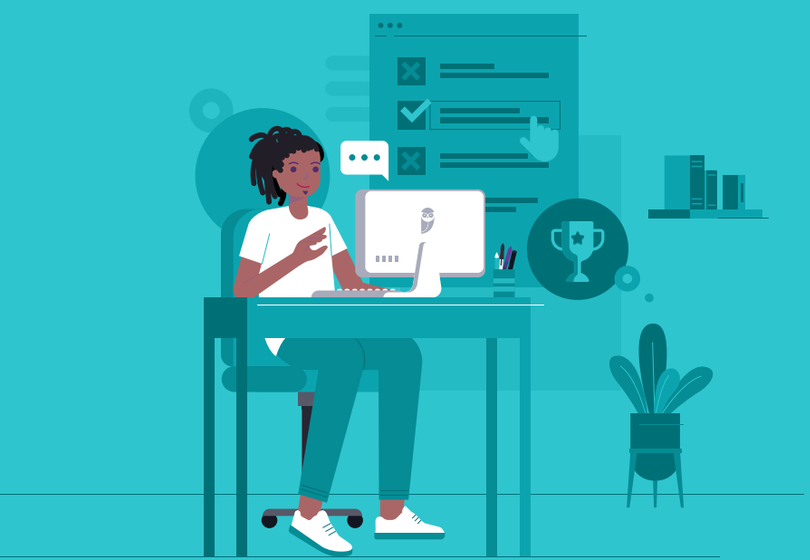
3.0 MAPAS MENTAIS




ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO
Colangite aguda
Obstrução da via biliar
Causas: cálculos (mais comum ⭐), estenoses benignas, neoplasias
Tríade de Charcot: dor abdominal, febre e icterícia
Pêntade de Reynolds: Tríade de Charcot + hipotensão + alteração mental
DIAGNÓSTICO
Laboratório 💉: leucocitose, aumento da PCR, FA, GGT, BT (mais BD). Aumento discreto TGO;TGP e amilase
USG, TC, RNM: dilatação da via biliar, podem identificar o fator obstrutivo
Colangiorressonância: melhor exame para ver a causa da obstrução, principalmente cálculos e neoplasias
CPRE: diagnóstico e tratamento
Tratamento
Suporte: jejum, hidratação, analgesia e antibióticos
Colangite leve: suporte. Drenagem biliar se não houver resposta. Esfincterotomia e retirada de cálculo(s)
Colangite grave: suporte e drenagem biliar precoce. Esfincterotomia e retirada de cálculo(s) se condições clínicas
Colangite moderada: drenagem biliar urgente (<24hs)
Vias de drenagem: CPRE ⭐, percutânea trans-hepática, ecoendoscopia, cirúrgica
Programar colecistectomia e tratamento do fator obstrutivo após resolução da colangite

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://bit.ly/2OCGlcu

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO
5.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição
- Uptodate:
- As manifestações clínicas e diagnóstico de colecistite
- Tratamento de colecistite calculosa aguda
- O diagnóstico e tratamento da colecistite acalculosa
- Técnicas de colecistectomia.
- Íleo biliar
- Abscesso hepático piogênico
- Colangite aguda: manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento
- Colangite piogênica recorrente
- Diretrizes de Tóquio 2018 (TG18):
- http://www.jshbps.jp/modules/en/index.php?content_id=47
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jhbp.516
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jhbp.515
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jhbp.518
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jhbp.512
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jhbp.509

CAPÍTULO
6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, terminamos mais um capítulo muito importante dentro de Abdome Agudo Inflamatório. Vias biliares e suas complicações são temas recorrentes nas provas de residência de todo o país. No próximo livro, ainda dentro de Abdome Agudo Inflamatório, falaremos sobre Diverticulite aguda.

Lembre-se que, se surgir alguma dúvida sobre este tema, ou qualquer outro relacionado à Cirurgia, estou à sua disposição para esclarecê-la no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED. E não esqueça de nos seguir nas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos médicos mais atuais de todas as especialidades.

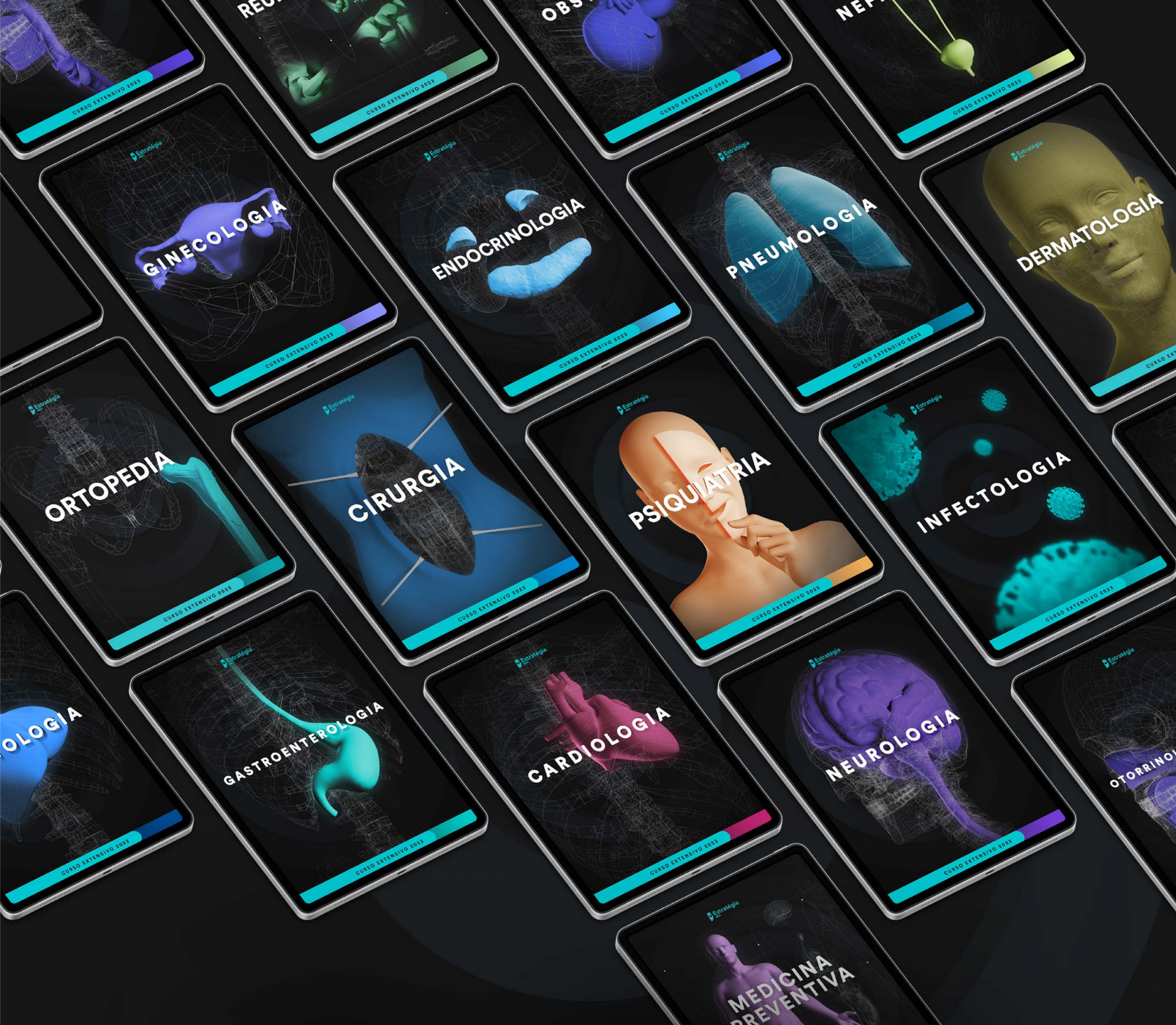
Bons estudos e fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva

@estrategiamed

@prof.renathapaiva



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED